

Buku Ajar

REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI UNTUK BIDAN

An Nisa Fithri • Sefria Indah Primasari • Brivian Florentis Yustanta
Rini Deska • Putu Lusita Nati Indriani • Idawati

Editor: Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.



BUKU AJAR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI UNTUK BIDAN

Penulis:

Dr. An Nisa Fithri, M.KM.

Sefria Indah Primasari, S.ST., M.Kes.

Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes.

Bdn. Rini Deska. S.ST., M.KM.

Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.

Dr. Idawati, S.ST., M.K.M., C.Ed.

Editor:

Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.



BUKU AJAR REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI UNTUK BIDAN

Penulis:

Dr. An Nisa Fithri, M.KM.
Sefria Indah Primasari, S.ST., M.Kes.
Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes.
Bdn. Rini Deska. S.ST., M.KM.
Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.
Dr. Idawati, S.ST., M.K.M., C.Ed.

Editor: Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-93-0

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja serta masa prakonsepsi secara komprehensif. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi dosen, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Masa remaja merupakan periode peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, sosial, emosional, dan seksual. Berbagai perubahan tersebut dapat memengaruhi cara remaja memahami dirinya, menjalin hubungan sosial, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, remaja memerlukan informasi kesehatan reproduksi yang benar, sesuai usia, mudah dipahami, dan disampaikan tanpa menghakimi.

Permasalahan kesehatan reproduksi remaja dapat meliputi pubertas, kebersihan organ reproduksi, gangguan menstruasi, anemia, masalah gizi, kesehatan mental, perilaku seksual berisiko, kehamilan yang tidak direncanakan, kekerasan seksual, pernikahan usia anak, serta infeksi menular seksual. Permasalahan tersebut perlu ditangani melalui pendekatan yang mempertimbangkan kondisi individu, keluarga, lingkungan, budaya, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pelayanan prakonsepsi juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana. Masa prakonsepsi memberikan kesempatan bagi perempuan, laki-laki, dan pasangan untuk memperbaiki kondisi kesehatan serta mengendalikan faktor risiko sebelum kehamilan terjadi. Pelayanan ini mencakup pengkajian status gizi, anemia, penyakit kronis, kesehatan mental, gaya hidup, penggunaan obat, imunisasi, riwayat reproduksi, serta kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Bidan memiliki peran strategis sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, advokat, dan koordinator pelayanan. Bidan diharapkan mampu memberikan edukasi, melakukan skrining dan deteksi dini, membantu pengambilan keputusan, serta melakukan kolaborasi dan rujukan sesuai kebutuhan. Pelayanan yang diberikan harus menjaga privasi, kerahasiaan, keselamatan, serta menghormati hak, nilai, budaya, dan pilihan setiap individu.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, dan sikap profesional. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu melakukan pengkajian, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, memberikan edukasi serta konseling, menentukan tindakan sesuai kewenangan, dan mengevaluasi hasil pelayanan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan buku ini.

Semoga Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan 1 ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Buku ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya bidan yang kompeten, humanis, kritis, dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, komprehensif, berkesinambungan, serta berpusat pada kebutuhan individu.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	1
A. Definisi dan Pengertian	5
B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Pra Konsepsi	6
C. Determinan Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Pra Konsepsi.....	7
D. Prinsip Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Konsepsi	9
E. Kebijakan, etika, dan aspek legal dasar pada layanan remaja/prakonsepsi.....	13
F. Pengorganisasian Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi.....	15
G. Latihan Soal.....	17
H. Ringkasan	20
I. Daftar Pustaka.....	22

BAB 2 ANATOMI FISILOGI REPRODUKSI DAN EDUKASI SEKSUALITAS KOMPREHENSIF SESUAI TAHAP USIA.....	27
A. Teori Dasar	30
B. Aktivitas 1 — Knows How.....	33
C. Aktivitas 2 — Shows How	33
D. Aktivitas 3 — Does	34
E. Aktivitas 4 — Reflective & Evidence-Based Learning.....	35
F. Latihan Soal.....	36
G. Ringkasan	54
H. Daftar Pustaka.....	60

BAB 3 KOMUNIKASI DAN KONSELING RAMAH REMAJA: KERAHASIAAN, ETIK, DAN PENDEKATAN BERPUSAT PADA REMAJA	63
A. Konsep Komunikasi dan Konseling Ramah Remaja	74
B. Pengertian Komunikasi dalam Pelayanan Kesehatan Remaja	75
C. Pengertian Konseling dalam Pelayanan Kesehatan Remaja	76

D. Konsep Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja.....	76
E. Prinsip Komunikasi Ramah Remaja	77
F. Tahapan Konseling Ramah Remaja.....	78
G. Peran Bidan dalam Komunikasi dan Konseling Remaja.....	79
H. Latihan Soal.....	80
I. Ringkasan	101
J. Daftar Pustaka.....	107

BAB 4 GIZI REMAJA DAN STATUS KESEHATAN: ANEMIA, KEK, OBESITAS, DAN PENCEGAHAN STUNTING ANTAR GENERASI.....109

A. Gizi Remaja.....	115
B. Status Kesehatan Remaja.....	120
C. Status Kesehatan Remaja: KEK (Kekurangan Energi Kronik)	126
D. Status Kesehatan Remaja: Obesitas	131
E. Status Kesehatan Remaja: Pencegahan Stunting Antar Generasi.....	136
F. Latihan Soal.....	144
G. Ringkasan	160
H. Daftar Pustaka.....	163

BAB 5 KESEHATAN MENSTRUASI: SIKLUS, KELUHAN UMUM, GANGGUAN MENSTRUASI, DAN TATA LAKSANA AWAL165

A. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis	168
B. Fase Siklus Menstruasi	169
C. Perubahan Fisiologis Lain yang Menyertai.....	169
D. Kesehatan Menstruasi pada Remaja.....	170
E. Tanda Menstruasi Normal	170
F. Keluhan Umum dan Patofisiologi	170
G. Gangguan Menstruasi.....	171
H. Pemeriksaan Penunjang	171
I. Tata Laksana Awal	171
J. Latihan Soal.....	173
K. Rangkuman Materi.....	182
L. Daftar Pustaka.....	187

BAB 6 PENCEGAHAN KEHAMILAN REMAJA: EDUKASI, KONSELING, DAN AKSES PELAYANAN YANG AMAN	191
A. Konsep dan Determinan Kehamilan Remaja	193
B. Komunikasi Dan Konseling Ramah Remaja/Prakonsepsi Secara Aman.....	195
C. Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja	197
D. Konseling Kesehatan Reproduksi bagi Remaja.....	197
E. Akses Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Aman bagi Remaja	198
F. Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja.....	198
G. Latihan Soal.....	203
H. Ringkasan	224
I. Daftar Pustaka.....	229
 PROFIL PENULIS	 231

BAB 1

KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Tujuan Instruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi konsep dasar kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi dalam praktik kebidanan

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan pengertian kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi dalam praktik kebidanan secara tepat.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi dalam praktik kebidanan secara tepat.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan determinan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi dalam praktik kebidanan secara tepat.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi dalam praktik kebidanan secara tepat.
5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kerangka kebijakan, etika, dan aspek legal dasar (hak, persetujuan, kerahasiaan) pada layanan remaja/prakonsepsi secara tepat.

Capaian Pembelajaran:

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

CPMK-1

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan secara sistematis dan tepat.

CPMK-2

Mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.

CPMK-3

Mahasiswa mampu menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.

CPMK-4

Mahasiswa mampu melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.

CPMK-5

Mahasiswa mampu merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.

CPMK-6

Mahasiswa mampu melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.

CPMK-7

Mahasiswa mampu Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi (WHO, 2020). Dalam praktik kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi tidak hanya difokuskan pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, tetapi juga mencakup periode sebelum kehamilan (pra konsepsi) serta masa remaja sebagai fase awal kematangan sistem reproduksi.

Masa remaja merupakan periode kritis karena perilaku kesehatan yang terbentuk akan berdampak hingga dewasa. Kurangnya literasi kesehatan reproduksi pada remaja berkaitan dengan meningkatnya risiko kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual (IMS), anemia, hingga gangguan kesehatan mental (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2020).

Di sisi lain, masa pra konsepsi adalah periode sebelum terjadinya pembuahan yang menjadi waktu optimal untuk melakukan intervensi kesehatan guna meningkatkan kesiapan biologis dan psikososial calon orang tua (Dean et al., 2019). Intervensi pada fase ini terbukti menurunkan risiko komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta kelainan kongenital (WHO, 2016). Dengan demikian, penguatan konsep kesehatan reproduksi remaja dan pra konsepsi dalam praktik kebidanan menjadi sangat penting dalam upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Bab ini akan membahas tentang Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Konsepsi Dalam Praktik Kebidanan. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu meningkatkan pengetahuan tentang Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Konsepsi Dalam Praktik Kebidanan. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah konsep dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Konsepsi Dalam Praktik Kebidanan: definisi, ruang lingkup, determinan dan prinsip layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi. Pada Bab ini juga akan diuraikan beberapa kerangka kebijakan pada layanan remaja/prakonsepsi.

Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, studi kasus, latihan soal dan dilengkapi dengan rangkuman.

Oleh karena itu, buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif mengenai konsep dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Konsepsi Dalam Praktik Kebidanan. Buku ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menjelaskan, memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada ibu (woman-centered care).

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi dalam Praktik Kebidanan, studi kasus, dan latihan soal.

Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi dalam Praktik Kebidanan

A. Definisi dan Pengertian

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia. WHO (2024) menegaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah kondisi kesejahteraan menyeluruh, bukan sekadar ketiadaan penyakit. Hal ini mencakup hak setiap individu untuk mengakses informasi, layanan, dan kebijakan yang mendukung fungsi reproduksi. Kesehatan reproduksi sebagai bidang multidisiplin yang mencakup kesehatan ibu, anak, remaja, serta keluarga berencana.

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan ditandai dengan perubahan aspek kognitif, fisik, hormonal dan mental yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka (Astuti, 2021). Masa remaja merupakan masa yang berisiko tinggi terhadap munculnya berbagai masalah sosial dan tidak terkecuali muncul juga masalah yang berkaitan kesehatan reproduksi (Nasrudin, 2017).

Masa remaja merupakan masa yang dianggap cukup rawan dalam kehidupan karena merupakan masa peralihan dari kehidupan anak-anak menjadi kehidupan dewasa yang penuh dengan gejolak (Matahari et al., 2020). Menjadi remaja berarti menjalani proses berat yang membutuhkan banyak penyesuaian, lonjakan pertumbuhan badan dan pematangan organ-organ reproduksi adalah salah satu dari masalah besar yang mereka hadapi, tidak terkecuali organ reproduksi yang rentan terhadap infeksi, kehamilan, penyakit menular seksual dan penggunaan obat-obatan terlarang. Perasaan seksual yang menguat tak bisa dialami oleh setiap remaja meskipun kadarnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitupun juga dengan kemampuan untuk mengendalikannya (Suryani, 2021)

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu keadaan sehat jasmani, psikologis, dan sosial yang berhubungan dengan fungsi dan proses sistem reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi remaja merupakan faktor penting yang harus mendapat perhatian untuk mewujudkan masyarakat sehat (Djama, 2017). Kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai kondisi sehat dari sistem, fungsi dan proses organ reproduksi yang dimiliki oleh remaja, yaitu laki-laki dan perempuan usia 10-19 tahun dan belum menikah (Mawardika et al., 2019).

Klasifikasi remaja pada umumnya didasarkan pada perubahan psikososial pada remaja. Perubahan fisik yang cepat dan terjadi berkelanjutan pada remaja menyebabkan para remaja sadar dan lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba membandingkan dengan teman-teman sebaya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar maka berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi anak, bahkan terkadang timbul ansietas, terutama pada anak perempuan bila tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Sebaliknya pada orangtua keadaan ini dapat menimbulkan konflik bila proses anak menjadi dewasa ini tidak dipahami dengan baik. (Arisani, 2025)

Kesehatan reproduksi remaja mencakup keadaan yang sehat dan optimal dari organ, fungsi, serta proses reproduksi selama masa remaja. Remaja biasanya berada pada rentang usia 10–19 tahun, di mana terjadi perubahan hormonal yang intens, berkembangnya sistem seksual sekunder, dan meningkatnya keingintahuan serta kebutuhan informasi tentang fungsi reproduksi. Remaja sangat rentan terhadap risiko kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan perilaku seksual berisiko jika tidak mendapatkan informasi yang memadai. Kesehatan reproduksi remaja mencakup keterampilan sosial, emosional, dan kognitif untuk menghadapi perubahan pubertas serta pengambilan keputusan terkait gender dan perilaku seksual. (Aima & Erwandi, 2024)

B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Pra Konsepsi

Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara umum mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Namun, pada remaja terdapat fokus khusus sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan siklus hidup, di mana setiap tahap kehidupan memiliki masalah dan kebutuhan kesehatan reproduksi yang berbeda. (Siregar, 2025)

Menurut WHO (2020), kesehatan reproduksi remaja mencakup hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang benar dan layanan kesehatan yang aman, efektif, dan dapat diterima secara sosial. Ruang lingkupnya meliputi:

1. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi
2. Pubertas dan perubahan hormonal
3. Siklus menstruasi dan ovulasi
4. Pencegahan IMS dan HIV
5. Kontrasepsi dan perencanaan keluarga
6. Pencegahan kekerasan berbasis gender
7. Kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial

Pra konsepsi adalah periode sebelum terjadinya kehamilan, yaitu saat sel telur dan sperma belum bertemu, tetapi individu telah mempersiapkan kondisi optimal untuk kehamilan. Pra konsepsi meliputi kesiapan fisik, kesiapan mental dan kesiapan sosial dan ekonomi. Pengetahuan kesehatan reproduksi sangat berhubungan dengan kesiapan pra konsepsi, terutama pada remaja putri. (Gunawati, 2025)

Masa pra-konsepsi adalah periode sebelum terjadinya pembuahan antara sel ovum dan sel sperma yakni masa ketika seorang individu siap untuk merencanakan kehamilan dan mempersiapkan kondisi fisik dan psikososialnya. Penyediaan layanan kesehatan dan edukasi yang tepat pada masa ini dapat mendorong persiapan kesehatan yang optimal bagi calon ibu dan calon ayah sebelum memasuki kehamilan. Program peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui edukasi berbasis sekolah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman remaja tentang kontrasepsi dan IMS. (Jusuf, 2023)

Upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan pra konsepsi dalam praktik kebidanan meliputi:

1. Pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini
2. Program pelayanan kesehatan remaja
3. Konseling pra nikah
4. Kampanye gaya hidup sehat
5. Pemanfaatan media digital edukatif

Pendekatan edukasi berbasis komunitas terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja (Reffita, 2025)

C. Determinan Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Pra Konsepsi

Determinan kesehatan reproduksi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan reproduksi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ini mencakup aspek biologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi (Sartika et al., 2024). Determinan kesehatan reproduksi mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan individu, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi pengetahuan, perilaku, lingkungan sosial, serta akses terhadap layanan kesehatan (Purba & Novita, 2022).

Determinasi kesehatan reproduksi remaja sangat kompleks karena melibatkan berbagai dimensi kehidupan individu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam memahami determinan ini bersifat multidisiplin (Rofiqoh et al., 2025).

Determinan Kesehatan Reproduksi Remaja, antara lain:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi remaja. Remaja dengan tingkat pengetahuan yang baik

cenderung memiliki perilaku yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan persepsi tentang kesehatan reproduksi, termasuk risiko kehamilan dan penyakit menular seksual.

2. Sikap dan Perilaku

Sikap dan perilaku remaja berperan penting dalam menentukan tindakan yang diambil terkait kesehatan reproduksi. Sikap yang negatif dapat meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko.

Perilaku yang tidak sehat seperti hubungan seksual pranikah tanpa perlindungan dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual dan kehamilan tidak diinginkan (Purba & Novita, 2022).

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang tepat (Rahmawati et al., 2023).

4. Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku remaja. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat mencegah perilaku berisiko.

5. Teman Sebaya

Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Tekanan dari teman sebaya dapat mendorong remaja untuk melakukan perilaku berisiko.

6. Media

Media memiliki peran dalam membentuk persepsi dan perilaku remaja. Paparan informasi yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi.

7. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi norma dan perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi.

8. Ekonomi

Status ekonomi mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.

9. Pelayanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat remaja.

Sedangkan determinan kesehatan pra konsepsi antara lain:

1. Status Gizi

Status gizi yang baik sangat penting dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. Kekurangan gizi dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan (Gunawati et al., 2025).

2. Status Kesehatan

Penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dapat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu dikontrol sebelum konsepsi.

3. Usia

Usia ideal untuk kehamilan adalah 20–35 tahun karena pada usia tersebut risiko komplikasi lebih rendah.

4. Kesehatan Mental

Kesehatan mental yang baik sangat penting dalam kesiapan menghadapi kehamilan dan peran sebagai orang tua.

5. Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat seperti tidak merokok dan konsumsi makanan bergizi sangat penting dalam persiapan kehamilan.

6. Pengetahuan Pra Konsepsi

Pengetahuan tentang pra konsepsi berhubungan dengan kesiapan individu dalam menghadapi kehamilan.

7. Dukungan Sosial

Dukungan keluarga dan pasangan sangat penting dalam menentukan kesiapan pra konsepsi.

D. Prinsip Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Konsepsi

Prinsip layanan kesehatan reproduksi meliputi kesetaraan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan (WHO, 2021). Layanan harus dapat diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi harus bersifat komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kerahasiaan dan penghormatan terhadap hak individu menjadi prinsip penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi, terutama bagi remaja (WHO, 2021).

Kesehatan reproduksi remaja merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena masa remaja adalah fase transisi menuju dewasa, di mana perilaku dan keputusan yang diambil akan memengaruhi kualitas hidup di masa depan (Patton et al., 2016). Pra konsepsi, yaitu fase sebelum kehamilan, juga krusial karena kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial calon ibu maupun ayah akan menentukan kualitas kehamilan dan kesehatan anak (Stephenson et al., 2018). Oleh karena itu, prinsip layanan kesehatan reproduksi remaja dan pra konsepsi harus

dirancang secara komprehensif, ramah remaja, berbasis hak, dan berorientasi pada pencegahan (WHO, 2021)

Prinsip Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja meliputi:

1. Komprehensif dan Holistik

Layanan kesehatan reproduksi remaja harus mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Pendekatan holistik ini tidak hanya fokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga pada promosi kesehatan dan pengembangan keterampilan hidup sehat.

2. Ramah Remaja

Konsep youth friendly services menekankan bahwa layanan harus mudah diakses, menjaga kerahasiaan, dan tidak diskriminatif. Tenaga kesehatan perlu dilatih agar memahami kebutuhan remaja dan mampu memberikan konseling yang sesuai (Aima & Erwandi, 2024).

3. Berbasis Hak Asasi Manusia

Hak remaja untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi harus dijamin. Perlindungan dari kekerasan seksual, diskriminasi gender, dan stigma sosial merupakan bagian integral dari layanan (UNFPA, 2020).

4. Partisipatif

Remaja perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan reproduksi. Partisipasi aktif akan meningkatkan efektivitas program dan membangun rasa kepemilikan terhadap kesehatan mereka sendiri (Jusuf et al., 2023).

5. Berorientasi pada Pencegahan

Fokus utama layanan adalah pencegahan kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, serta perilaku berisiko lainnya.

Sedangkan prinsip layanan kesehatan pra konsepsi, antara lain:

1. Kesiapan Fisik dan Nutrisi

Pra konsepsi menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan, status gizi, dan suplementasi seperti asam folat. Hal ini bertujuan mencegah anemia dan komplikasi kehamilan.

2. Kesiapan Mental dan Psikososial

Konseling pra konsepsi membantu calon orang tua mengatasi stres, kecemasan, dan memastikan kesiapan emosional. Dukungan pasangan dan keluarga sangat berpengaruh terhadap kesiapan mental (Patton et al., 2016).

3. Perilaku Sehat

Menghindari rokok, alkohol, dan narkoba merupakan prinsip utama pra konsepsi. Pola makan sehat dan aktivitas fisik juga berperan penting dalam mempersiapkan kehamilan yang berkualitas (Stephenson et al., 2018).

4. Akses Layanan Kesehatan

Konseling pra konsepsi, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi harus tersedia dan terintegrasi dengan program kesehatan ibu dan anak.

5. Kesetaraan Gender dan Inklusivitas

Pra konsepsi tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga melibatkan laki-laki dalam persiapan kehamilan. Kesetaraan gender dan inklusivitas menjadi prinsip penting agar semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama (UNFPA, 2020).

Masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi layanan kesehatan reproduksi remaja dan pra konsepsi. Edukasi pra konsepsi belum merata, stigma sosial terhadap pembicaraan seksualitas masih tinggi, dan layanan kesehatan ramah remaja belum optimal (Aima & Erwandi, 2024). Selain itu, angka pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan masih cukup tinggi di banyak negara berkembang (WHO, 2021).

Strategi intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah
- b. Penguatan layanan kesehatan ramah remaja di puskesmas dan klinik
- c. Konseling pra konsepsi sebagai bagian dari layanan kesehatan ibu
- d. Pemanfaatan media digital untuk edukasi kesehatan reproduksi (Patton et al., 2016).

Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah segala bentuk layanan kesehatan yang dibutuhkan remaja untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kesehatan organ reproduksi serta kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Layanan ini harus bersifat komprehensif, mudah diakses, ramah remaja, dan menjamin kerahasiaan. (Rokhmah, 2022)

Layanan ini terdiri dari:

1. Layanan Konseling dan Edukasi

Berisi tentang konseling pra-pubertas, Konseling hubungan dan seksualitas, Konseling pencegahan risiko (kehamilan, PMS), Konseling kesehatan mental.

2. Layanan Skrining dan Pemeriksaan Kesehatan

Berisi tentang pemeriksaan organ reproduksi, deteksi dini anemia, keputihan abnormal, pemeriksaan IMS, konsultasi terkait menstruasi tidak teratur.

3. Layanan Pencegahan Kehamilan

Berisi tentang penyediaan kontrasepsi yang sesuai usia dan kebutuhan, edukasi cara penggunaan kondom, rujukan jika diperlukan.

4. Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Berisi tentang layanan pengaduan, dukungan psikologis, pendampingan hukum, rujukan ke rumah sakit, psikolog, atau LSM perlindungan anak.

5. Layanan untuk Kehamilan Remaja

Berisi tentang pemeriksaan kehamilan, konseling psikologis, perlindungan hukum (jika terkait kekerasan seksual), rujukan sosial.

6. Layanan Ramah Remaja (Youth-Friendly Health Services)

Ciri layanan yang sesuai: rahasia & privasi terjaga, tenaga kesehatan tidak menghakimi, waktu pelayanan fleksibel, informasi sederhana dan mudah dipahami, biaya terjangkau atau gratis. Contohnya di Indonesia ada PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) di Puskesmas, Posyandu Remaja dan Layanan konseling oleh sekolah atau psikolog. (Susilaksmi, 2011).

Pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi untuk remaja harus berlandaskan pendekatan berbasis hak (rights-based), yaitu menjamin bahwa setiap remaja berhak memperoleh informasi, edukasi, dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Informasi yang disampaikan harus akurat, ilmiah, dan sesuai usia, sehingga remaja dapat memahami perubahan tubuh dan risiko kesehatan secara benar, bukan berdasarkan mitos atau stigma yang salah (Hannifah, 2024).

Layanan kesehatan reproduksi remaja dan pra konsepsi juga harus mengutamakan kerahasiaan dan privasi. Remaja perlu merasa aman ketika berkonsultasi tanpa takut identitas atau persoalan mereka diketahui orang lain. Selain itu, layanan harus ramah remaja, artinya petugas bersikap tidak menghakimi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan ruang bagi remaja untuk bertanya dengan nyaman.

Prinsip penting lainnya adalah aksesibilitas, yaitu layanan harus mudah dijangkau dari sisi lokasi, biaya, dan waktu pelayanan. Selain itu, pendidikan dan layanan harus komprehensif, meliputi pubertas, seksualitas sehat, pencegahan kehamilan, pencegahan PMS, relasi sehat, kekerasan seksual, hingga kesehatan mental. Materi ini harus bersifat sensitif gender dan inklusif, sehingga mencakup kebutuhan seluruh remaja, termasuk kelompok rentan dan remaja dengan disabilitas.

Terakhir, pendidikan dan layanan perlu bersifat partisipatif, yaitu melibatkan remaja dalam penyusunan program, penyampaian edukasi, dan evaluasi layanan. Dengan partisipasi aktif, remaja merasa dihargai dan lebih mudah menerima

informasi, sehingga program kesehatan reproduksi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

(Kurniawati, 2024).

E. Kebijakan, etika, dan aspek legal dasar pada layanan remaja/prakonsepsi.

Kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi harus diberikan berdasarkan siklus hidup dan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan global seperti International Conference on Population and Development (ICPD) menekankan bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak reproduksi yang harus dijamin oleh negara (WHO, 2021). Pendekatan berbasis hak (rights-based approach) dalam kebijakan kesehatan reproduksi bertujuan untuk memastikan akses yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap layanan kesehatan reproduksi (WHO, 2021).

Kebijakan layanan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia berfokus pada penyediaan layanan yang ramah remaja, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan (Kemenkes RI, 2020). Secara global, WHO dan UNFPA mendorong implementasi pendidikan seksual komprehensif untuk meningkatkan kesadaran remaja (UNFPA, 2022). Kebijakan ini bertujuan mencegah risiko kesehatan reproduksi sejak dini. Di Indonesia, kebijakan ini diimplementasikan melalui program PKPR yang menyediakan layanan kesehatan ramah remaja (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Program seperti Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi remaja. Program ini menekankan akses layanan, edukasi, dan konseling. Selain itu, pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif (Comprehensive Sexuality Education) menjadi bagian penting dalam kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat pada remaja.

Kebijakan pra konsepsi bertujuan meningkatkan kesiapan pasangan sebelum kehamilan (WHO, 2021). Pelayanan prakonsepsi bertujuan untuk mempersiapkan pasangan usia subur agar siap secara fisik, mental, dan sosial sebelum kehamilan (Kemenkes RI, 2020). Intervensi ini mencakup pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan konseling gizi (WHO, 2021).

Kebijakan prakonsepsi juga menekankan pentingnya deteksi dini penyakit kronis yang dapat mempengaruhi kehamilan, seperti diabetes dan hipertensi (WHO, 2021). Dengan adanya kebijakan prakonsepsi, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang (WHO, 2025). Program ini di Indonesia terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu

dan anak serta keluarga berencana (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berkelanjutan.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi stigma sosial dan keterbatasan akses layanan. Hal ini menjadi hambatan dalam penyampaian edukasi reproduksi (The Indonesian Institute, 2025). Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan edukasi berbasis digital dan penguatan kebijakan lintas sektor (WHO, 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak remaja.

Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi kesehatan dan stigma sosial terhadap isu reproduksi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan akibat kurangnya koordinasi lintas sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat (WHO, 2023).

Strategi implementasi kebijakan melibatkan pendekatan lintas sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan konseling kepada remaja dan calon orang tua. Peran ini mendukung perubahan perilaku sehat.

Remaja membutuhkan informasi yang komprehensif, meliputi (Hannifah, 2024):

1. Informasi tentang Pubertas dan Perubahan Fisik

Remaja memiliki hak untuk mendapatkan informasi Pendidikan Kesehatan tentang pubertas dan perubahan fisik saat usia remaja. Informasi reproduksi tersebut dapat berisi tentang penjelasan perubahan hormon reproduksi pada remaja, informasi fisiologis terjadinya menstruasi dan ovulasi, informasi tentang terjadinya mimpi basah, perubahan payudara dan suara serta informasi tentang cara menjaga kebersihan organ reproduksi untuk mengurangi kecemasan.

2. Informasi tentang Seksualitas Sehat

Informasi seksualitas sehat yang dibutuhkan oleh remaja seperti informasi seks pranikah berisi tentang risiko dan konsekuensinya, consent atau persetujuan dalam relasi termasuk remaja memiliki hak untuk menolak aktivitas seksual berisiko yang cenderung akan merugikan kesehatan, batasan diri dan penghargaan terhadap tubuh, dan informasi tentang hubungan yang sehat (healthy relationship).

3. Informasi tentang Pencegahan Kehamilan

Pencegahan kehamilan yang terjadi pada usia remaja Adalah dengan memberikan informasi tentang fungsi dan cara kerja alat kontrasepsi, efektivitas

masing-masing metode kontrasepsi dan mitos serta fakta kontrasepsi. Hal ini penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

4. Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS/IMS) & HIV/AIDS

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah kelompok penyakit infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral, dengan pasangan yang sudah terinfeksi. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang berpindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual langsung atau pertukaran cairan tubuh (WHO, 2023). Informasi pencegahan penyakit menular seksual diantaranya adalah cara penularan penyakit, gejala umum yang menyertai, penyakit menular seksual, cara pencegahan (kondom, perilaku aman, skrining), dan stigma & diskriminasi terhadap penderita HIV.

5. Informasi tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bersifat pemaksaan, tekanan, ancaman, manipulasi, atau tanpa persetujuan (non-consensual) yang berkaitan dengan aktivitas atau perilaku seksual. Tindakan ini dapat terjadi secara fisik, verbal, maupun non-fisik, dan dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta hukum bagi korbannya. Informasi tentang kekerasan seksual pada remaja meliputi, jenis kekerasan seksual, cara mengenali pelecehan, cara melapor dan mencari bantuan dan hak perlindungan anak dan remaja (Sharma, 2015).

6. Informasi tentang Kesehatan Mental Terkait Reproduksi

Kesehatan mental terkait reproduksi pada remaja sangat penting untuk diketahui oleh remaja, seperti dampak psikologis dari tekanan sosial dan media, body image atau gambaran diri remaja, dampak hubungan tidak sehat dan pengelolaan emosi.

F. Pengorganisasian Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi

Efektivitas layanan kesehatan reproduksi remaja dan pra-konsepsi tidak dapat berdiri sendiri di dalam fasilitas kesehatan (Puskesmas/Klinik). Layanan ini harus mendekati target sasaran melalui sekolah dengan pemberdayaan UKS, guru BK, kader remaja dan komunitas contohnya pada Posyandu Remaja, karang taruna dan kelompok keagamaan (Chandra-Mouli & Patel, 2017).

Untuk membangun layanan yang kuat, diperlukan jejaring terintegrasi yang menghubungkan berbagai sektor. Setiap sektor memiliki peran spesifik masing-masing. Puskesmas berperan sebagai pembina teknis, penyedia layanan klinis (seperti pemberian Tablet Tambah Darah, konseling, dan skrining), serta rujukan utama (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Sedangkan sekolah berperan sebagai pusat edukasi massal, skrining awal (misalnya pencatatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan pengukuran LILA/IMT), serta penggerak konselor sebaya (peer educator). Adapun Masyarakat atau Tokoh Masyarakat: Berperan menciptakan lingkungan yang mendukung (tidak tabu), melakukan penjangkauan bagi remaja putus sekolah, serta menggerakkan Posyandu Remaja (Chandra-Mouli & Patel, 2017).

Monitoring sebagai pemantauan proses dan evaluasi sebagai penilaian hasil untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mengenali hambatan secara dini. Monitoring dilakukan setiap bulan dengan fokus pada proses dan input, sedangkan evaluasi dilakukan per semester atau per tahun dengan fokus pada output dan outcome. Pelaksanaan monev yang berkala di tingkat komunitas dapat mendeteksi kegagalan program sebelum berdampak luas pada status kesehatan remaja (Patton et al., 2016).

Membangun layanan berbasis komunitas dan sekolah sering kali dihadapkan pada masalah stigma seputar kesehatan reproduksi, serta pergantian siswa (turnover) yang cepat (Chandra-Mouli & Patel, 2017). Agar program tetap berjalan jangka panjang, standardisasi layanan ramah remaja sangat diperlukan (World Health Organization, 2020).

Beberapa langkah strategi yang wajib diambil meliputi:

1. Institusionalisasi Kebijakan

Mendorong adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa untuk Posyandu Remaja atau SOP Sekolah yang mengintegrasikan edukasi pra-konsepsi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau Bimbingan Konseling

2. Digitalisasi Pencatatan

Mengurangi beban administrasi kader dengan beralih ke aplikasi pencatatan sederhana agar pelaporan lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan input data.

3. Standardisasi Pelatihan Guru dan Kader

Menyusun modul pelatihan dasar yang ringkas, sehingga saat terjadi pergantian kader atau guru UKS, proses transfer ilmu dapat berjalan cepat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

G. Latihan Soal

1. Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang ke puskesmas bersama ibunya. Ia mengeluhkan nyeri perut bagian bawah saat menstruasi sejak 6 bulan terakhir. Menstruasi terjadi setiap bulan dengan lama 5–7 hari. Pemeriksaan fisik dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan organ reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang paling mungkin dialami remaja tersebut adalah...
 - A. Amenore primer
 - B. Dismenore primer
 - C. Endometriosis
 - D. Menoragia
 - E. Amenore sekunder
2. Seorang perempuan usia 22 tahun akan menikah dalam waktu dua bulan. Ia datang ke klinik untuk mendapatkan konseling kesehatan reproduksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan status gizi baik, tekanan darah normal, dan belum pernah mendapatkan imunisasi tetanus. Tindakan yang paling tepat diberikan oleh petugas kesehatan adalah...
 - A. Menyarankan penggunaan kontrasepsi hormonal
 - B. Memberikan imunisasi TT dan konseling prakonsepsi
 - C. Merujuk ke rumah sakit
 - D. Menunda pernikahan
 - E. Memberikan terapi antibiotik
3. Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke klinik dengan keluhan keputihan berwarna kuning kehijauan, berbau, dan disertai rasa gatal pada area genital. Pasien mengaku sering berganti pasangan seksual. Faktor risiko utama yang menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada kasus tersebut adalah...
 - A. Usia reproduksi
 - B. Kurang aktivitas fisik
 - C. Berganti-ganti pasangan seksual
 - D. Riwayat menstruasi
 - E. Kurang konsumsi sayur
4. Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri saat berhubungan seksual dan perdarahan setelah berhubungan. Pemeriksaan menunjukkan adanya lesi pada serviks yang mencurigakan. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah...
 - A. Memberikan analgesik

- B. Memberikan vitamin
 - C. Melakukan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan
 - D. Menyarankan istirahat
 - E. Memberikan kontrasepsi hormonal
5. Seorang remaja perempuan usia 17 tahun datang ke klinik dengan keluhan tidak pernah mengalami menstruasi. Pemeriksaan menunjukkan perkembangan payudara dan rambut pubis sesuai usia. Tidak ditemukan kelainan anatomis pada genitalia eksterna. Langkah awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah...
- A. Memberikan terapi hormonal
 - B. Melakukan konseling dan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan penyebab amenore
 - C. Menyarankan pasien menikah
 - D. Memberikan antibiotik
 - E. Melakukan pemasangan IUD
6. Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang ke bidan untuk meminta informasi kontrasepsi tanpa sepengetahuan orang tua. Ia tampak cemas dan meminta agar identitasnya dirahasiakan. Tindakan bidan yang paling tepat adalah:
- A. Menolak pelayanan
 - B. Memberitahu orang tua
 - C. Memberikan konseling dan menjaga kerahasiaan
 - D. Mengabaikan pasien
 - E. Melapor ke pihak berwajib
7. Remaja perempuan usia 18 tahun datang ke praktik bidan bersama calon suaminya untuk melakukan pemeriksaan prakonsepsi. Ia memiliki riwayat anemia dan pola makan yang kurang baik. Selain itu, ia mengaku sering mengonsumsi makanan cepat saji dan jarang minum suplemen. Calon suaminya adalah perokok aktif. Mereka berencana untuk segera memiliki anak setelah menikah. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan kadar Hb rendah dan indeks massa tubuh (IMT) kurang dari normal. Tujuan utama pelayanan prakonsepsi pada kasus ini adalah:
- A. Mempercepat kehamilan
 - B. Menyiapkan kehamilan sehat
 - C. Mengurangi biaya
 - D. Menghindari pemeriksaan

- E. Tidak ada tujuan
8. Remaja perempuan datang ke praktek Bidan dengan kehamilan tidak diinginkan dan merasa depresi.
Tindakan awal bidan adalah:
- A. Mengobati
 - B. Memberikan dukungan emosional dan konseling
 - C. Menganjurkan ke rumah sakit
 - D. Melaporkan ke orangtuanya
 - E. Mengabaikan pasien
9. Seorang calon pengantin datang untuk pemeriksaan prakonsepsi. Bidan menemukan bahwa salah klien memiliki riwayat penyakit menular seksual, namun klien meminta agar hal tersebut tidak disampaikan kepada pasangannya.
Apa tindakan yang paling tepat secara etik dan legal?
- A. Menyampaikan kepada pasangan tanpa izin
 - B. Menjaga rahasia sepenuhnya tanpa edukasi
 - C. Memberikan edukasi kepada klien tentang pentingnya keterbukaan
 - D. Mengabaikan informasi tersebut
 - E. Melaporkan ke pihak berwajib
10. Seorang remaja perempuan usia 17 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan prakonsepsi menjelang pernikahannya. Ia datang tanpa didampingi orang tua dan meminta agar hasil pemeriksaan tetap dirahasiakan. Bidan melakukan skrining kesehatan dan menemukan bahwa remaja tersebut mengalami anemia ringan serta memiliki pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehamilan. Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kebijakan untuk memberikan pelayanan ramah remaja, menjaga kerahasiaan pasien, serta memberikan edukasi dan konseling sesuai standar pelayanan prakonsepsi.
Kebijakan layanan yang paling tepat diterapkan pada kasus tersebut adalah:
- A. Menolak pelayanan karena pasien masih remaja
 - B. Memberikan pelayanan sesuai standar dan menjaga kerahasiaan
 - C. Memberitahu orang tuanya
 - D. Menunda pelayanan
 - E. Memeriksa keadaan pasien

Kunci Jawaban

1. B
2. B
3. C
4. C
5. B
6. C
7. B
8. B
9. C
10. B

Studi Kasus

Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun datang ke praktik bidan untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi dan meminta informasi tentang kontrasepsi. Ia mengaku aktif secara seksual dan tidak ingin orang tuanya mengetahui kunjungannya. Saat pemeriksaan, bidan juga menemukan adanya gejala Infeksi Menular Seksual (IMS). Remaja tersebut meminta bidan untuk tidak mencatat atau melaporkan kondisinya kepada siapa pun, termasuk pasangannya.

Pertanyaan:

Tindakan bidan yang paling tepat terkait temuan dugaan IMS pada remaja tersebut adalah:

- A. Langsung memberitahu orang tua pasien
- B. Mengabaikan kondisi pasien
- C. Memberikan edukasi tentang IMS dan pentingnya pengobatan serta komunikasi dengan pasangan
- D. Menolak memberikan pelayanan
- E. Melaporkan ke pihak berwajib

Jawaban: C

Pembahasan: Bidan harus menjaga kerahasiaan pasien, namun tetap berkewajiban memberikan edukasi untuk mencegah penularan dan dampak lebih lanjut.

H. Ringkasan

Kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai kondisi sehat dari sistem, fungsi dan proses organ reproduksi yang dimiliki oleh remaja, yaitu laki-laki dan perempuan usia 10-19 tahun dan belum menikah. Kesehatan reproduksi remaja mencakup keterampilan sosial, emosional, dan kognitif untuk menghadapi

perubahan pubertas serta pengambilan keputusan terkait gender dan perilaku seksual.

Ruang lingkup kesehatan pada remaja dan prakonsepsi terdapat fokus khusus sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan siklus hidup, di mana setiap tahap kehidupan memiliki masalah dan kebutuhan kesehatan reproduksi yang berbeda. Determinasi kesehatan reproduksi remaja sangat kompleks karena melibatkan berbagai dimensi kehidupan individu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam memahami determinan ini bersifat multidisiplin.

Layanan kesehatan reproduksi remaja dan pra konsepsi juga harus mengutamakan kerahasiaan dan privasi. Remaja perlu merasa aman ketika berkonsultasi tanpa takut identitas atau persoalan mereka diketahui orang lain. Selain itu, layanan harus ramah remaja, artinya petugas bersikap tidak menghakimi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan ruang bagi remaja untuk bertanya dengan nyaman.

Kebijakan layanan kesehatan reproduksi remaja berfokus pada penyediaan layanan yang ramah remaja, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan. Sedangkan kebijakan pra konsepsi bertujuan meningkatkan kesiapan pasangan sebelum kehamilan. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan usia subur agar siap secara fisik, mental, dan sosial sebelum kehamilan. Intervensi ini mencakup pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan konseling gizi

Secara keseluruhan, dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh.

Glosarium

Kesehatan Reproduksi: Keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Remaja: Individu usia 10–19 tahun yang berada pada masa transisi dari anak-anak ke dewasa.

Kesehatan Reproduksi Remaja: Kondisi sehat dari sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada remaja secara fisik, psikologis, dan sosial.

Pra Konsepsi: Periode sebelum terjadinya pembuahan saat individu mempersiapkan kondisi optimal untuk kehamilan.

Infeksi Menular Seksual (IMS): Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual akibat bakteri, virus, jamur, atau parasit.

Pubertas: Masa perubahan fisik dan hormonal yang menandai kematangan seksual.

Menstruasi: Proses peluruhan lapisan rahim yang terjadi secara siklus pada perempuan.

Ovulasi: Proses pelepasan sel telur dari ovarium.

Kontrasepsi: Metode atau alat untuk mencegah kehamilan.

Determinasi Kesehatan: Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan individu, baik biologis, sosial, maupun lingkungan.

Kesehatan Mental: Kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan individu berfungsi secara optimal.

Anemia: Kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah yang dapat mempengaruhi kesehatan.

Skrining Prakonsepsi: Pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi risiko kesehatan sebelum kehamilan.

Konseling: Proses komunikasi untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja: Layanan kesehatan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan, dan sesuai kebutuhan remaja.

Kekerasan Seksual: Tindakan pemaksaan atau tanpa persetujuan yang berkaitan dengan aktivitas seksual.

Hak Reproduksi: Hak individu untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi.

Perilaku Hidup Sehat: Kebiasaan yang mendukung kesehatan seperti pola makan baik dan tidak merokok.

Dukungan Sosial: Bantuan dari keluarga, pasangan, atau lingkungan dalam mendukung kesehatan individu.

Tanda Vital: Parameter dasar kondisi tubuh meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu.

I. Daftar Pustaka

Aima, S., & Erwandi, D. (2024). Pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia: Sistematis review. *Jurnal Ners*, 8(2), 1446–1452.

Arisani, G., dkk. 2025. *Kesehatan Reproduksi Dalam Keluarga Dan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.

Astuti, A. (2021). The intersection between Helth and Culture: A Qualitative Exploratory Study about Indonesian Adolescent Sexual Reproductive Health Services. *Journal Of Medical & Health Sciences*, 15(6), 1147– 1152.

- Blum, R. W., & Nelson-Mmari, K. (2015). The health of young people in a global context. *Journal of Adolescent Health*, 57(3), 252–258.
- Chandra-Mouli, V., & Patel, S. V. (2017). Mapping the ground reality of adolescent pregnancy and child marriage: School and community-based interventions. *Journal of Adolescent Health*, 61(3), 273–282.
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., et al. (2025). Preconception care: A concept analysis of an evolving paradigm. *Journal of Advanced Nursing*, 81(7), 3674–3691.
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2019). Preconception care: Nutritional risks and interventions. *Reproductive Health*, 16(1), 1–14.
- Djama, N. T. (2017). Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*.
- Fatoni, Z., et al. (2015). Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Gunawati, D. M., Wahyuni, S., & Wuriningsih, A. Y. P. (2025). Pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan manajemen prakonsepsi. *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 3(2), 147–154.
- Hannifah, S. (2024) "Situasi dan Kebutuhan Remaja Tentang Edukasi Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Ners*, 8(2), pp. 1459–1469.
- Jusuf, E. C., Aman, A., Syahrir, S., Idrus, A., Mappaware, N. A., Chalid, M. T., Azizah, N., Asmuliadi, A., & Radmila, W. (2023). Upaya meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(2), 293–300. Universitas Hasanuddin.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Profil kesehatan reproduksi Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pelayanan pra konsepsi di fasilitas kesehatan primer. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

- Kurniawati, H.F. (2024) "Kebutuhan Informasi tentang Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) pada Masa Pandemi COVID 19," *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 15(1).
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sulistiawan, D. (2020). Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja terhadap Kesehatan Reproduksi melalui Pelatihan Life Skill Education. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 504–510.
- Mawardika, T., Indriani, D., & Liyanovitasari, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi melalui Pendidikan Kesehatan berupa Aplikasi Layanan Keperawatan Kesehatan Reproduksi Remaja (LAWAN ROMA) di SMP Wilayah Kerja Puskesmas Bawen Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 8(2), 99– 110.
- Mustika, A. E., Andriyanti, & Djuari, L. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan remaja di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(4).
- Nasrudin, M. (2017). Perkembangan Remaja. *Journal INSTITUTIONAL REPOSITORY of IAIN Tulungagung*.
- Nurhasanah, S., & Sugiantini, T. E. (2025). Pengaruh edukasi kesehatan reproduksi dalam PKPR terhadap pengetahuan remaja. *Jurnal Ners*, 9(4).
- Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., ... & Viner, R. M. (2016). Our future: A Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *The Lancet*, 387(10036), 2423–2478.
- Pradja, D. A. A. (2025). Literature review: Hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dengan perilaku seksual berisiko pada remaja. *Midwife Care Journal*.
- Purba, C. F., & Novita, A. (2022). Determinan pencegahan perilaku berisiko pada kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 12(1).
- Rahmawati, S., Setyowati, S., Budiati, T., & Rachmawati, I. N. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi remaja. *Journal of Telenursing*, 5(2).
- Reffita, L. I. (2025). Pengembangan program kesehatan reproduksi remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4).
- ResearchGate. (2025). Hambatan layanan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia.
- Rofiqoh, Y., Purwoko, B., & Naqyah, N. (2025). Kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 9(1).

- Rokhmah, N. (2022) "Scoping Review: Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal Ilmiah Umum dan Kesehatan Aisyiyah*, 7(1)
- Sartika, D., Fauziah, & Azhara, S. (2024). Analisis determinan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja putri. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4).
- Siregar, L. M. (2025). Pendidikan kesehatan reproduksi dalam pendekatan siklus hidup. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 6(1), 227–233.
- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A., Hutchinson, J., Cade, J. E & Barker, M. (2018). Before the beginning: Nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841.
- Susilaksmi, I. (2011) "Kebutuhan dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(1), pp.19–30.
- The Indonesian Institute. (2025). Implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia.
- United Nations Population Fund. (2020). State of world population 2020: Defying the practices that harm women and girls. UNFPA.
- Universitas Gadjah Mada. (2025). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 12 No. 3. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM.
- World Health Organization. (2021). Adolescent sexual and reproductive health. WHO Report.
- World Health Organization. (2024). Sexual and reproductive health: Global perspectives. Geneva: WHO.

BAB 2

ANATOMI FISILOGI REPRODUKSI DAN EDUKASI SEKSUALITAS KOMPREHENSIF SESUAI TAHAP USIA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

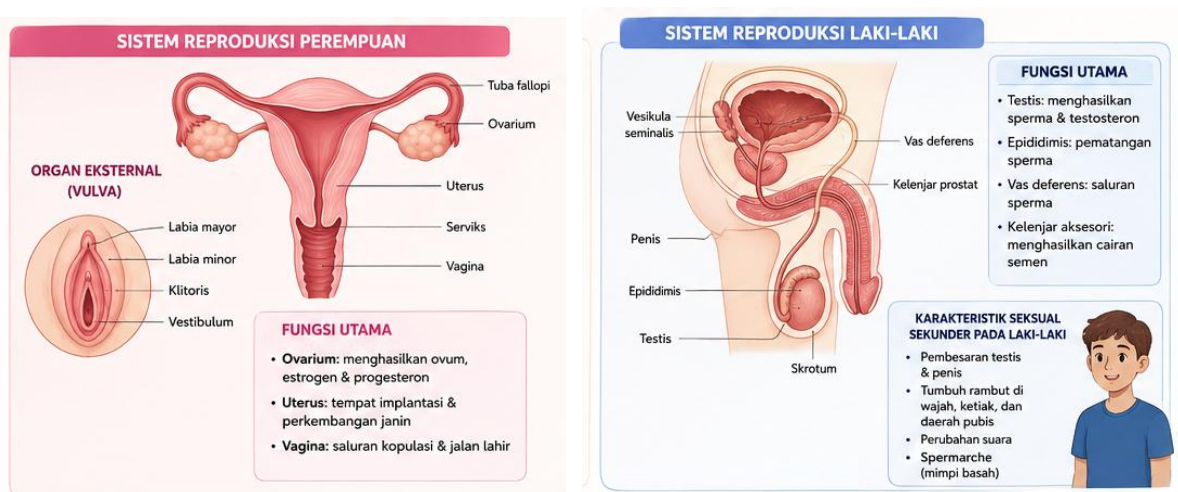
Bab 2. Anatomi– Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia	3.1 Menjelaskan anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan dasar regulasi hormonal sesuai tahap perkembangan.	3.2 Menyusun rancangan materi edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia, akurat ilmiah, dan sensitif budaya.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5
CPMK-3	Ujian tulis + proyek desain materi edukasi	Akurasi anatomi–fisiologi/menstruasi termasuk red flags; kualitas materi edukasi sesuai usia (akurasi & kesesuaian)	15	Nilai ujian; poster/leaflet/modul singkat
CPMK-4	Simulasi/OSCE konseling + observasi terstruktur	Keterampilan komunikasi empatik; penerapan kerahasiaan & informed choice; ketepatan rencana tindak lanjut/rujukan	15	Checklist OSCE; rekaman/video simulasi; ringkas catatan konseling (dummy)

CPMK-5	Proyek rencana intervensi promotif–preventif + presentasi	Ketepatan interpretasi masalah prioritas (gizi/mental); kualitas rancangan intervensi (SMART, feasible, berbasis risiko)	15	Dokumen rencana intervensi; slide/presentasi
--------	---	--	----	--

Uraian Materi

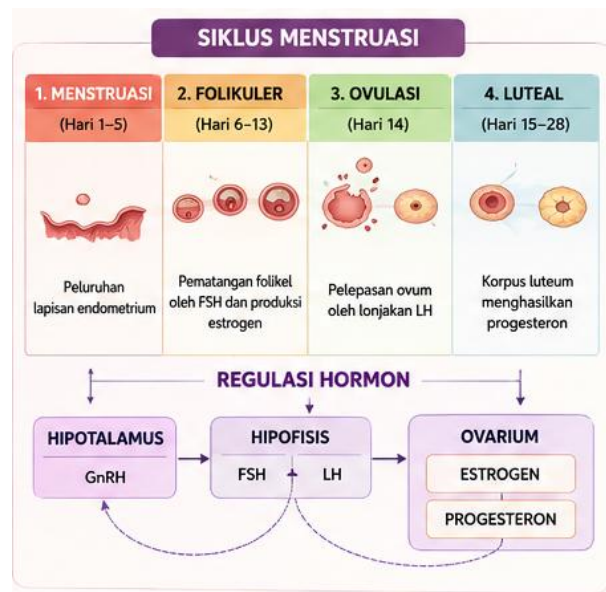
A. Teori Dasar

Sistem reproduksi manusia merupakan suatu sistem biologis yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan spesies melalui proses reproduksi, namun dalam konteks kesehatan remaja dan prakonsepsi, pemahaman terhadap anatomi dan fisiologi reproduksi tidak hanya terbatas pada fungsi biologis semata, melainkan juga berkaitan erat dengan perkembangan psikososial, perilaku kesehatan, serta kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, dalam praktik kebidanan, penguasaan konsep anatomi fisiologi harus diintegrasikan dengan kemampuan memberikan edukasi seksualitas yang komprehensif, sesuai tahap perkembangan usia, dan sensitif terhadap nilai budaya serta konteks sosial.



Gambar 2.1. Sistem Reproduksi Perempuan dan Laki-laki

Secara anatomi, sistem reproduksi perempuan terdiri atas organ eksternal seperti vulva yang meliputi labia mayor, labia minor, klitoris, dan vestibulum, serta organ internal yang meliputi vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Ovarium memiliki fungsi penting dalam menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam regulasi siklus menstruasi. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi dan perkembangan janin, sedangkan vagina berperan sebagai saluran kopulasi dan jalan lahir. Pada laki-laki, sistem reproduksi terdiri atas organ eksternal berupa penis dan skrotum, serta organ internal seperti testis, epididimis, vas deferens, vesikula seminalis, dan kelenjar prostat. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder.



Gambar 2.2 Siklus Menstruasi

Secara fisiologis, fungsi reproduksi perempuan diatur melalui siklus menstruasi yang terdiri dari fase menstruasi, fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Siklus ini dikendalikan oleh interaksi kompleks antara hormon hipotalamus, hipofisis, dan ovarium, yaitu gonadotropin-releasing hormone (GnRH), follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estrogen, dan progesteron.



Gambar 2.3 Perubahan Pubertas

Pada masa pubertas, terjadi aktivasi sumbu hipotalamus-hipofisis-gonad yang menyebabkan munculnya karakteristik seksual sekunder, seperti pembesaran payudara dan menarche pada perempuan, serta pembesaran testis dan spermatarche pada laki-laki. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial, seperti peningkatan rasa ingin tahu terhadap seksualitas, perubahan identitas diri, serta kecenderungan eksplorasi perilaku berisiko.



Gambar 2.4 Comprehensive Sexuality Education (CSE)

Dalam konteks ini, edukasi seksualitas komprehensif (Comprehensive Sexuality Education/CSE) menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi. UNESCO dan WHO menegaskan bahwa CSE merupakan proses pembelajaran yang berbasis ilmiah, bertahap, dan sesuai usia, yang mencakup aspek biologis, emosional, sosial, serta nilai dan etika terkait seksualitas. Edukasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab, serta mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan kekerasan berbasis gender.



Gambar 2.5. Edukasi Seksualitas Sesuai Tahap Usia

Pemberian edukasi seksualitas harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usia. Pada anak usia dini, fokus utama adalah pengenalan bagian tubuh dan konsep "tubuhku milikku" sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Pada remaja awal, edukasi difokuskan pada perubahan pubertas dan pemahaman terhadap perubahan fisik dan emosional. Pada remaja akhir, edukasi mulai mencakup hubungan interpersonal yang sehat, risiko perilaku seksual, serta pengambilan keputusan. Sementara pada tahap prakonsepsi, edukasi diarahkan pada kesiapan fisik, mental, dan sosial untuk kehamilan, termasuk perencanaan keluarga, status gizi, serta pencegahan faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi.

B. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Kasus

Seorang remaja perempuan usia 14 tahun datang ke Posyandu Remaja dengan keluhan merasa bingung dan cemas karena mengalami perubahan tubuh yang cepat dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengaku sudah mengalami menstruasi sejak usia 12 tahun, namun siklusnya tidak teratur. Remaja tersebut juga menyampaikan bahwa ia sering mendapatkan informasi tentang seksualitas dari media sosial, tetapi merasa informasi tersebut membingungkan dan tidak tahu mana yang benar.

Hasil pengkajian awal menunjukkan bahwa remaja tersebut belum pernah mendapatkan edukasi formal tentang kesehatan reproduksi baik dari keluarga maupun sekolah. Ia juga tampak malu untuk bertanya dan memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai menstruasi dan hubungan seksual.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama yang dialami remaja pada kasus di atas?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi kondisi tersebut (biologis, psikologis, sosial)?
3. Bagaimana keterkaitan kondisi tersebut dengan tahap perkembangan remaja?
4. Informasi apa saja yang perlu diluruskan terkait anatomi dan fisiologi reproduksi?
5. Materi edukasi seksualitas apa yang paling sesuai diberikan pada kasus ini?
6. Bagaimana pendekatan komunikasi yang tepat agar remaja merasa aman dan nyaman?
7. Apa risiko yang dapat terjadi jika remaja tidak mendapatkan edukasi yang benar?
8. Bagaimana peran bidan dalam memberikan edukasi dan tindak lanjut pada kasus ini?

C. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi / Skill Lab Edukasi Seksualitas

Mahasiswa melakukan role play dengan skenario:

1. Edukasi pubertas pada remaja awal
2. Edukasi body safety pada anak
3. Edukasi prakonsepsi pada calon pasangan

Fokus Penilaian

1. Ketepatan materi anatomi fisiologi
2. Kesesuaian materi dengan usia
3. Komunikasi empatik dan non-judgmental
4. Sensitivitas budaya

5. Kemampuan membangun kepercayaan
6. Mahasiswa naik dari *knows how* → *shows how* tidak langsung ujian tapi fokus pada performa, bukan hafalan

D. Aktivitas 3 — Does

Praktik Edukasi Seksualitas Komprehensif di Lahan / Simulasi Terstruktur

Deskripsi

Mahasiswa melakukan praktik edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas komprehensif kepada sasaran sesuai tahap usia, baik di lahan praktik (posyandu remaja, sekolah, puskesmas) maupun melalui simulasi terstruktur di kelas. Kegiatan ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan anatomi–fisiologi reproduksi dengan keterampilan komunikasi, sensitivitas budaya, serta prinsip keselamatan psikologis klien.

Sebelum praktik, mahasiswa diharapkan melakukan pengkajian sederhana terkait karakteristik sasaran, tingkat pengetahuan awal, serta kebutuhan edukasi yang relevan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, mahasiswa menyusun materi edukasi yang sesuai tahap usia, akurat secara ilmiah, dan disampaikan dengan pendekatan yang empatik serta tidak menghakimi. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diharapkan mampu membangun hubungan yang aman dan nyaman, menyampaikan materi secara sistematis, serta memberikan kesempatan kepada sasaran untuk bertanya dan berdiskusi.

Setelah kegiatan edukasi, mahasiswa melakukan evaluasi terhadap pemahaman sasaran serta refleksi terhadap proses yang telah dilakukan, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, aktivitas ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran dan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.

Tugas Mahasiswa

1. Melakukan pengkajian kebutuhan edukasi pada sasaran (usia, tingkat pemahaman, masalah utama)
2. Menentukan topik edukasi sesuai tahap usia
3. Menyusun materi edukasi (leaflet/poster/modul singkat)
4. Melaksanakan edukasi secara langsung atau simulasi
5. Melakukan evaluasi pemahaman sasaran
6. Menyusun laporan singkat kegiatan edukasi

Output yang Dikumpulkan

1. Media edukasi (poster/leaflet)

2. Dokumentasi kegiatan (foto/video/simulasi)
3. Catatan proses edukasi
4. Laporan singkat (1–2 halaman)
5. Refleksi pribadi

Pertanyaan Refleksi

1. Apakah materi yang Anda berikan sudah sesuai dengan tahap usia sasaran? Jelaskan.
2. Bagaimana respon sasaran terhadap edukasi yang Anda berikan?
3. Hambatan apa yang Anda temui selama proses edukasi?
4. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut?
5. Apa yang akan Anda perbaiki pada praktik berikutnya?

E. Aktivitas 4 — Reflective & Evidence-Based Learning

Analisis Praktik Edukasi Seksualitas Berbasis Evidence

Deskripsi

Mahasiswa melakukan analisis kritis terhadap praktik edukasi seksualitas komprehensif berdasarkan prinsip evidence-based practice. Aktivitas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi kesesuaian praktik edukasi dengan standar ilmiah, pedoman internasional (WHO/UNESCO), serta konteks budaya lokal.

Mahasiswa dapat menggunakan pengalaman praktik pada Aktivitas 3 atau diberikan studi kasus/video edukasi sebagai bahan analisis. Dalam proses ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan praktik edukasi, mengevaluasi kesesuaian materi dengan tahap usia, serta menilai aspek komunikasi, keselamatan psikologis, dan potensi bias atau stigma.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengaitkan praktik yang dilakukan dengan konsep anatomi fisiologi reproduksi serta prinsip edukasi seksualitas komprehensif, sehingga terbentuk kemampuan berpikir reflektif dan berbasis bukti dalam praktik kebidanan.

Tugas Mahasiswa

1. Mengkaji praktik edukasi (hasil sendiri atau studi kasus/video)
2. Membandingkan praktik dengan prinsip CSE (WHO/UNESCO)
3. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan praktik
4. Menganalisis kesesuaian materi dengan tahap usia
5. Memberikan rekomendasi perbaikan berbasis evidence

Output yang Dikumpulkan

1. Laporan analisis (2–3 halaman)
2. Ringkasan perbandingan dengan guideline
3. Rekomendasi perbaikan praktik

Pertanyaan Refleksi

1. Apakah praktik edukasi sudah sesuai dengan prinsip edukasi seksualitas komprehensif?
2. Apakah terdapat informasi yang berpotensi bias atau menimbulkan stigma?
3. Bagaimana kesesuaian materi dengan tahap perkembangan usia sasaran?
4. Apakah komunikasi yang digunakan sudah empatik dan non-judgmental?
5. Bagaimana praktik tersebut dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan aman?

F. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Edukasi Seksualitas Komprehensif pada Remaja
3	Kasus	Remaja awal dengan kebingungan terkait pubertas dan menstruasi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Pengumpulan data subyektif (anamnesis) 2. Prosedur tindakan (edukasi dan asesmen) 3. Edukasi/konseling (KIE) 4. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang remaja perempuan usia 14 tahun datang ke Posyandu Remaja dengan keluhan merasa cemas karena mengalami perubahan tubuh sejak 1 tahun terakhir. Ia mengatakan sudah mengalami menstruasi sejak usia 12 tahun, tetapi siklusnya tidak teratur. Remaja tersebut juga mengaku sering mendapatkan informasi tentang tubuh dan seksualitas dari media sosial, namun merasa bingung dan takut bahwa kondisi yang dialaminya tidak normal.

No.	Komponen	Isi
		Hasil pengkajian awal: Keadaan umum baik, tampak malu, kontak mata kurang, berbicara pelan. Tidak ada keluhan nyeri atau tanda bahaya fisik. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan asesmen kebutuhan edukasi sesuai tahap usia. 3. Sampaikan masalah/kebutuhan utama berdasarkan data yang diperoleh. 4. Berikan edukasi seksualitas (pubertas dan menstruasi) sesuai usia. 5. Lakukan komunikasi terapeutik yang empatik dan tidak menghakimi. 6. Berikan KIE singkat dan rencana tindak lanjut.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Penulisan nomor peserta sesuai ketentuan ujian. 3. Amati peserta dan beri penilaian: a) Actual mark (0/1/2/3) b) Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi di luar skenario. 5. Laksanakan tugas sesuai standar OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog. 2. Jika peserta menggali riwayat menstruasi: a) Menarche usia 12 tahun b) Siklus tidak teratur c) Tidak nyeri hebat 3. Jika peserta menggali sumber informasi: a) Dari media sosial 4. Edukasi yang diharapkan:

No.	Komponen	Isi
		a) Penjelasan pubertas normal b) Menstruasi normal dan variasinya c) Perubahan tubuh adalah normal d) Edukasi sederhana dan sesuai usia 5. Komunikasi yang diharapkan: a) Empatik b) Tidak menghakimi c) Bahasa sederhana 6. Penguji hanya memberikan data jika diminta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat setelah digunakan. 2. Siapkan lembar baru untuk peserta berikutnya.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai remaja usia 14 tahun 2. Tampak malu, cemas, dan ragu 3. Berbicara pelan dan tidak percaya diri 4. Jika peserta empatik → PS lebih terbuka 5. Jika peserta menghakimi → PS diam
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang PS: Pagi/siang Peserta: Apa keluhan utama? PS: Saya bingung, tubuh saya berubah dan saya sudah haid Peserta: Sejak kapan haid? PS: Sejak umur 12 tahun Peserta: Bagaimana siklusnya? PS: Kadang teratur, kadang tidak Peserta: Apa yang membuat kamu khawatir? PS: Saya takut ini tidak normal Peserta: Dapat informasi dari mana? PS: Dari media sosial Peserta (memberi edukasi) PS: Oh... jadi itu normal ya, Bu?
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan (role play komunikasi)

No.	Komponen	Isi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan ruang konseling 2. Menyiapkan lembar penilaian
12	Kebutuhan alat	1. Kursi dan meja konseling 2. Lembar penilaian 3. Pena 4. Leaflet edukasi 5. Handrub
13	Penulis	Brivian Florentis Yustanta, SST, Bdn, M.Kes
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI (2020) – Standar Profesi Bidan 2. Kementerian Kesehatan RI (2022) – Standar Kompetensi Bidan 3. WHO (2018) – Adolescent Sexual and Reproductive Health 4. UNESCO (2018) – Sexuality Education Guidance 5. BKKBN (2021) – Kesehatan Reproduksi Remaja

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat perkembangan/pubertas (menarche/spermarche, perubahan tubuh)		
3. Riwayat menstruasi (siklus, lama, keluhan)		
4. Pengetahuan awal tentang kesehatan reproduksi		
5. Sumber informasi (media sosial, teman, keluarga)		
6. Kekhawatiran/masalah yang dirasakan		
7. Riwayat kesehatan (anemia, penyakit kronis, dll)		
8. Faktor psikososial (dukungan keluarga, lingkungan, perilaku)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan (Edukasi dan Asesmen)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan		
c. Meminta persetujuan (informed consent sederhana)		
d. Menjaga privasi dan kenyamanan		
e. Hand hygiene		
f. Menyiapkan media edukasi (jika ada)		
2. Langkah-langkah		
a. Mengidentifikasi kebutuhan edukasi sesuai usia		
b. Menjelaskan pubertas/perubahan tubuh		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
c. Menjelaskan menstruasi normal		
d. Menyampaikan bahwa kondisi adalah normal (reassurance)		
e. Menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi		
f. Menyampaikan edukasi sesuai usia (tidak berlebihan/tidak kurang)		
g. Menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami		
h. Memberikan kesempatan bertanya		
i. Menjawab pertanyaan dengan benar		
j. Mengidentifikasi risiko (misinformasi, perilaku berisiko)		
k. Memberikan edukasi pencegahan sederhana		
l. Menyusun rencana tindak lanjut		
3. Pasca tindakan		
a. Merangkum edukasi		
b. Menutup komunikasi dengan baik		
c. Merapikan alat/lingkungan		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–18 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. Edukasi/konseling (KIE)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Komunikasi empatik dan tidak menghakimi		
3. Menjelaskan kondisi dengan bahasa sederhana		
4. Memberikan dukungan psikologis		
5. Melibatkan klien dalam diskusi		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis dalam tindakan		
2. Menjaga privasi dan keselamatan psikologis		
3. Responsif terhadap kondisi klien		
4. Suara jelas, tenang, komunikatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

Total Skor Dan Kelulusan

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 (*dicatat di rubrik penilaian*)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji:.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan praktik mahasiswa dalam situasi nyata atau simulasi klinik. Penilai mengamati bagaimana mahasiswa melakukan proses edukasi kesehatan reproduksi secara langsung, kemudian memberikan umpan balik segera setelah kegiatan selesai. Domain yang dinilai mencakup kemampuan asesmen kebutuhan, akurasi materi, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan psikologis klien.	DOPS dilakukan melalui observasi langsung saat mahasiswa memberikan edukasi kesehatan reproduksi sesuai tahap usia. Penilai mengamati proses mulai dari pengkajian kebutuhan, penyampaian materi, hingga komunikasi. Setelah itu diberikan umpan balik langsung. Aspek yang dinilai meliputi asesmen, akurasi materi, kesesuaian usia, komunikasi, dan keselamatan psikologis.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan anatomi fisiologi reproduksi dengan keterampilan komunikasi edukatif yang sesuai tahap usia, aman, dan tidak menimbulkan stigma. Edukasi seksualitas komprehensif harus dilakukan secara evidence-based, sensitif budaya, dan berorientasi pada pencegahan risiko kesehatan reproduksi.	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan anatomi fisiologi dengan keterampilan edukasi yang sesuai usia, akurat, dan tidak menimbulkan stigma. Penilaian berfokus pada penerapan pengetahuan dalam praktik nyata.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik atau simulasi yang relevan dengan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi, seperti kebingungan terkait pubertas, menstruasi tidak teratur, atau paparan informasi seksual yang tidak tepat.	Remaja perempuan usia 15 tahun datang ke posyandu remaja dengan keluhan siklus menstruasi tidak teratur sejak menarche usia 13 tahun. Ia cemas karena mendapat informasi dari media sosial bahwa kondisi tersebut berbahaya. Tidak ada tanda bahaya fisik, namun klien tampak cemas dan kurang percaya diri.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan rangkaian kegiatan edukasi secara langsung, bukan sekadar menjelaskan teori. Keterampilan yang diamati meliputi membangun komunikasi awal, menggali kebutuhan edukasi, menjelaskan anatomi dan fisiologi reproduksi secara sederhana, memberikan edukasi sesuai usia, serta melakukan evaluasi pemahaman klien.	Mahasiswa membangun komunikasi, menggali keluhan dan pengetahuan klien, lalu memberikan edukasi tentang pubertas dan menstruasi secara sederhana. Mahasiswa juga meluruskan misinformasi, memberikan reassurance, dan memberi kesempatan bertanya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan asesmen kebutuhan edukasi, ketepatan materi anatomi fisiologi, kesesuaian edukasi dengan tahap usia, komunikasi empatik dan non-judgmental, keselamatan psikologis, serta	Meliputi kemampuan asesmen kebutuhan, ketepatan materi, kesesuaian dengan usia, komunikasi empatik, keselamatan psikologis, serta kemampuan mengoreksi misinformasi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
	kemampuan menyusun rencana tindak lanjut.	
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah performa nyata mahasiswa saat memberikan edukasi. Dalam konteks ini, yang dinilai bukan hanya isi materi, tetapi juga cara penyampaian, sensitivitas terhadap kondisi klien, serta kemampuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman.	Pembimbing menilai cara mahasiswa menyampaikan edukasi, penggunaan bahasa sesuai usia, respon terhadap kecemasan klien, serta kemampuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah kegiatan selesai, mencakup kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik harus spesifik, konstruktif, dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.	Diberikan segera setelah kegiatan. Berisi kelebihan dan perbaikan, misalnya komunikasi sudah baik tetapi perlu meningkatkan eksplorasi kebutuhan klien atau penyederhanaan penjelasan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS diringkas menjadi tiga kategori: kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penilaian didasarkan pada ketepatan materi, komunikasi, keselamatan psikologis, dan kemampuan mengambil keputusan edukatif.	• Kompeten: edukasi tepat, sistematis, dan empatik • Perlu supervisi: cukup baik tetapi masih perlu arahan • Remedial: materi atau komunikasi belum tepat
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai level <i>does</i> dalam piramida Miller, karena performa diamati langsung dalam praktik nyata. Hal ini sangat	DOPS menunjukkan capaian pada level <i>does</i> , karena mahasiswa dinilai dari praktik langsung. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
	sesuai dengan pendekatan OBE yang menekankan capaian kompetensi berbasis performa.	mampu menerapkannya dalam edukasi yang efektif dan aman.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti autentik yang menunjukkan proses dan hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan. Portofolio tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga perkembangan kompetensi dari waktu ke waktu.	Mahasiswa mengumpulkan dokumentasi kegiatan edukasi remaja tentang menstruasi, mulai dari simulasi di kelas hingga praktik di posyandu remaja.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam praktik kebidanan.	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan siklus menstruasi secara benar serta menyampaikan edukasi dengan bahasa yang sesuai usia remaja.
OSCE dan DOPS	OSCE menilai keterampilan dalam simulasi, sedangkan DOPS menilai performa langsung di lahan praktik. Keduanya menjadi bukti utama kompetensi klinik.	OSCE: mahasiswa melakukan role play edukasi pubertas. DOPS: mahasiswa memberikan edukasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
		langsung pada remaja di posyandu.
Catatan kasus singkat	Catatan singkat berisi ringkasan kasus, tindakan yang dilakukan, dan hasil edukasi yang diberikan.	Remaja usia 15 tahun dengan menstruasi tidak teratur, mahasiswa memberikan edukasi tentang pubertas dan reassurance bahwa kondisi masih normal.
Refleksi patient safety	Refleksi mahasiswa mengenai bagaimana menjaga keselamatan dan kenyamanan klien, termasuk aspek psikologis dan privasi.	Mahasiswa menyadari pentingnya menggunakan bahasa yang tidak menakutkan agar remaja tidak semakin cemas.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing mengenai kekuatan dan area perbaikan mahasiswa.	Dosen menilai mahasiswa sudah empatik, tetapi perlu meningkatkan cara menggali kebutuhan klien secara lebih mendalam.
Karakteristik penilaian	Penilaian portofolio bersifat berkelanjutan, berbasis bukti, dan menilai proses serta hasil secara holistik.	Penilaian tidak hanya dari satu kegiatan edukasi, tetapi dari beberapa pengalaman mahasiswa dalam berbagai setting.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa tidak hanya muncul sekali, tetapi konsisten dalam berbagai situasi.	Mahasiswa mampu memberikan edukasi yang baik baik di simulasi kelas maupun di praktik lapangan.
Makna dalam OBE	Portofolio mendukung pendekatan Outcome-Based Education karena menilai capaian pembelajaran	Mahasiswa tidak hanya memahami anatomi fisiologi reproduksi, tetapi mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
	berdasarkan performa nyata mahasiswa.	menerapkannya dalam edukasi yang efektif dan sesuai kebutuhan klien.

Tabel. Case Report pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat yang menggambarkan pengalaman klinik mahasiswa dalam menangani satu kasus secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis, hingga tindakan yang dilakukan.	Mahasiswa menyusun laporan tentang remaja usia 15 tahun dengan menstruasi tidak teratur, termasuk hasil pengkajian, analisis kondisi, dan edukasi yang diberikan.
Tujuan	Tujuan case report adalah melatih kemampuan mahasiswa dalam berpikir klinis, mengintegrasikan teori dengan praktik, serta mendokumentasikan proses pengambilan keputusan.	Mahasiswa mampu menghubungkan ketidakteraturan siklus menstruasi dengan proses pubertas normal dan menentukan bahwa edukasi merupakan intervensi utama.
Isi laporan	Laporan berisi identitas kasus, data subjektif dan objektif, analisis masalah, rencana dan tindakan, serta evaluasi hasil.	Contoh pada Kasus: • Identitas: remaja 15 tahun • Data: siklus menstruasi tidak teratur • Analisis: variasi normal pubertas • Tindakan: edukasi pubertas dan menstruasi • Evaluasi: klien lebih memahami dan tidak cemas
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan analisis, kesesuaian tindakan, serta kemampuan mengaitkan teori dengan praktik.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan menjelaskan bahwa siklus tidak teratur pada remaja awal masih

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
		normal serta memberikan edukasi yang sesuai usia.
Nilai edukatif	Case report memberikan pengalaman belajar nyata yang memperkuat pemahaman konsep dan meningkatkan keterampilan klinik.	Mahasiswa memahami pentingnya komunikasi yang empatik saat menghadapi remaja yang cemas terhadap perubahan tubuhnya.
Makna dalam OBE	Case report mendukung OBE karena menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan pada kasus nyata secara terstruktur dan reflektif.	Mahasiswa tidak hanya memahami anatomi fisiologi reproduksi, tetapi mampu menerapkannya dalam edukasi yang tepat dan sesuai kebutuhan klien.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety adalah proses mahasiswa meninjau kembali praktik yang dilakukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan klien, termasuk aspek fisik dan psikologis.	Mahasiswa merefleksikan proses edukasi pada remaja dan menyadari pentingnya menjaga privasi serta menggunakan bahasa yang tidak membuat klien merasa takut atau malu.
Tujuan	Tujuan refleksi adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap potensi risiko	Mahasiswa memahami bahwa penyampaian informasi yang kurang tepat dapat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia
	dalam praktik serta mendorong perbaikan berkelanjutan.	meningkatkan kecemasan remaja.
Fokus refleksi	Fokus pada keselamatan psikologis, komunikasi, akurasi informasi, serta kenyamanan klien selama proses edukasi.	Mahasiswa menilai apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai usia dan tidak menimbulkan rasa takut atau stigma.
Risiko yang diidentifikasi	Risiko meliputi misinformasi, komunikasi yang tidak empatik, pelanggaran privasi, serta penyampaian materi yang tidak sesuai usia.	Remaja menjadi lebih cemas karena sebelumnya mendapatkan informasi yang salah dari media sosial.
Tindakan pencegahan	Tindakan pencegahan meliputi penggunaan bahasa sederhana, komunikasi empatik, menjaga kerahasiaan, dan memberikan informasi yang akurat.	Mahasiswa memberikan penjelasan bahwa menstruasi tidak teratur pada remaja awal masih normal dan tidak berbahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa edukasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kondisi psikologis klien.	Mahasiswa belajar bahwa pendekatan yang empatik dapat membuat remaja lebih terbuka dan menerima edukasi.
Makna dalam OBE	Refleksi patient safety mendukung OBE karena menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi praktik dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.	Mahasiswa mampu memperbaiki cara komunikasi pada edukasi berikutnya sehingga lebih efektif dan aman bagi klien.

G. Ringkasan

Anatomi dan fisiologi reproduksi merupakan dasar penting dalam memahami kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi. Sistem reproduksi perempuan terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina, sedangkan pada laki-laki meliputi testis, vas deferens, dan penis. Secara fisiologis, fungsi reproduksi perempuan diatur melalui siklus menstruasi yang terdiri dari fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal, yang dikendalikan oleh hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron.

Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik dan psikologis yang merupakan proses normal, termasuk munculnya menstruasi (menarche) pada perempuan. Pada fase awal pubertas, siklus menstruasi seringkali belum teratur dan masih dalam batas normal. Namun, kurangnya pemahaman serta paparan informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan kecemasan dan kesalahpahaman pada remaja.

Edukasi seksualitas komprehensif (Comprehensive Sexuality Education/CSE) merupakan pendekatan edukasi yang berbasis ilmiah, sesuai tahap usia, sensitif budaya, dan berorientasi pada pencegahan masalah kesehatan reproduksi. Pada anak, edukasi difokuskan pada konsep “tubuhku milikku” sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Pada remaja awal, fokus pada pemahaman pubertas dan perubahan tubuh. Pada remaja akhir, edukasi berkembang pada hubungan sehat dan risiko perilaku seksual. Sedangkan pada tahap prakonsepsi, edukasi diarahkan pada kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam perencanaan kehamilan.

Dalam praktik kebidanan, penting untuk mengenali tanda-tanda yang perlu diwaspadai, seperti misinformasi dari media, kecemasan berlebihan, perilaku berisiko, serta gangguan menstruasi yang tidak normal. Oleh karena itu, bidan harus mampu memberikan edukasi yang tepat, menggunakan komunikasi empatik, serta menjaga keselamatan psikologis klien.

Mahasiswa diharapkan mampu memahami anatomi fisiologi reproduksi, menjelaskan siklus menstruasi, memberikan edukasi sesuai tahap usia, serta melakukan komunikasi yang empatik dan tidak menghakimi. Kompetensi ini menjadi dasar dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berpusat pada klien.

Alur asuhan singkat Identifikasi usia & tahap perkembangan → Gali keluhan utama → Nilai pengetahuan awal → Identifikasi kebutuhan edukasi → Tentukan kondisi (normal / perlu perhatian) → Identifikasi risiko (misinformasi, kecemasan, perilaku berisiko) → Tentukan materi sesuai usia → Susun bahasa sederhana → Siapkan media edukasi → Bangun komunikasi empatik → Jelaskan anatomi & fisiologi secara sederhana → Berikan reassurance → Hindari stigma → Tanyakan

pemahaman klien → Klarifikasi informasi → Beri kesempatan bertanya → Anjurkan kontrol bila perlu → Rujuk jika ada red flags → Dokumentasikan hasil edukasi



Tabel Red Flags & Eskalasi

Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Menstruasi tidak terjadi hingga usia ≥ 15 tahun (amenore primer)	Kemungkinan gangguan hormonal, kelainan anatomi, atau pubertas terlambat	Rujuk ke dokter untuk evaluasi hormon dan organ reproduksi
Menstruasi berhenti > 3 bulan (amenore sekunder)	Dapat terkait stres, gangguan hormon, atau kehamilan	Lakukan skrining awal $\rightarrow$ rujuk untuk pemeriksaan lanjutan
Perdarahan menstruasi sangat banyak (menorrhagia)	Risiko anemia, gangguan hormonal atau kelainan uterus	Edukasi + cek Hb $\rightarrow$ rujuk bila berat
Nyeri haid sangat berat (dismenore berat)	Kemungkinan endometriosis atau gangguan lain	Rujuk untuk evaluasi lebih lanjut
Siklus menstruasi sangat tidak teratur (> 2 tahun setelah menarche)	Kemungkinan gangguan hormonal (PCOS, dll)	Rujuk ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi
Keputihan berbau, berwarna abnormal, atau gatal	Kemungkinan infeksi (IMS atau non-IMS)	Edukasi higiene $\rightarrow$ rujuk untuk pemeriksaan
Remaja aktif secara seksual tanpa proteksi	Risiko kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan IMS	Konseling + rujuk layanan kesehatan reproduksi
Informasi seksual yang salah (misinformasi)	Dapat menyebabkan perilaku berisiko dan kecemasan	Edukasi ulang berbasis evidence
Kecemasan berlebihan terkait perubahan tubuh	Gangguan psikologis atau kurang edukasi	Komunikasi empatik $\rightarrow$ rujuk jika berat
Tanda kekerasan seksual (fisik/psikologis)	Kondisi darurat dan membutuhkan perlindungan	Lakukan pendekatan aman $\rightarrow$ rujuk ke layanan perlindungan
Anemia (lemas, pucat, mudah lelah) pada remaja	Dampak menstruasi atau gizi buruk	Edukasi gizi + cek Hb $\rightarrow$ rujuk bila perlu

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pengetahuan sangat rendah tentang kesehatan reproduksi	Risiko tinggi perilaku tidak sehat	Edukasi komprehensif dan berkelanjutan
Perilaku berisiko (pornografi, tekanan teman sebaya)	Risiko gangguan psikososial dan kesehatan reproduksi	Konseling + edukasi + monitoring
Tanda gangguan perkembangan pubertas (terlalu cepat/lambat)	Gangguan hormonal atau kondisi medis	Rujuk untuk evaluasi spesialis
Tidak adanya dukungan keluarga	Risiko rendahnya pemahaman dan coping buruk	Libatkan keluarga dalam edukasi

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Anatomi Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia**

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan anatomi sistem reproduksi perempuan dan laki-laki	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi organ reproduksi secara fisiologis	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan siklus menstruasi dan regulasi hormonalnya	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan perubahan pubertas pada remaja	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa membedakan kondisi normal dan tidak normal pada menstruasi remaja	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan anamnesis sederhana terkait kesehatan reproduksi remaja	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan edukasi sesuai tahap usia	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan edukasi seksualitas sesuai usia secara benar dan sederhana	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menggunakan komunikasi empatik dan tidak menghakimi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengoreksi misinformasi terkait kesehatan reproduksi	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa mengenali red flags pada kesehatan reproduksi remaja	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memberikan edukasi pencegahan risiko (IMS, KTD, dll)	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa memberikan reassurance dan dukungan psikologis pada klien	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan perlu rujukan atau tindak lanjut	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil edukasi secara sederhana dan jelas	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan psikologis, dan profesionalisme	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2021). *Principles of Anatomy and Physiology* (16th ed.). Wiley.
- Berek, J. S. (2020). *Berek & Novak's Gynecology* (16th ed.). Wolters Kluwer.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- BKKBN. (2021). *Kesehatan Reproduksi dan Prakonsepsi*. Jakarta: BKKBN.
- UNESCO. (2018). *International Technical Guidance on Sexuality Education*. Paris: UNESCO.
- World Health Organization. (2018). *WHO Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2016). *Global Health Sector Strategy on Sexually Transmitted Infections 2016–2021*. Geneva: WHO.
- Bearinger, L. H., Sieving, R. E., Ferguson, J., & Sharma, V. (2017). Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents. *The Lancet*, 390(10102), 1220–1231.
- Chandra-Mouli, V., Lane, C., & Wong, S. (2015). What does not work in adolescent sexual and reproductive health. *BMJ Global Health*, 1(3), e000020.
- Widman, L., Nesi, J., Kamke, K., Choukas-Bradley, S., & Stewart, J. L. (2018). Technology-based interventions to reduce sexually transmitted infections and unintended pregnancy among youth. *Journal of Adolescent Health*, 62(6), 651–660.
- Salam, R. A., Faqqah, A., Sajjad, N., et al. (2016). Improving adolescent sexual and reproductive health. *Journal of Adolescent Health*, 59(4), S11–S28.

- Kassa, G. M., Arowojolu, A. O., Odukogbe, A. A., & Yalew, A. W. (2018). Prevalence and determinants of adolescent pregnancy. *Reproductive Health*, 15(1), 195.
- Sari, R. P., & Widyastuti, Y. (2019). Hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual remaja di SMA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2), 85–92.
- Putri, A. N., & Susanti, D. (2020). Edukasi kesehatan reproduksi terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang pubertas. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(1), 45–52.
- Lestari, D., & Handayani, S. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seksual berisiko pada remaja. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 1–10.
- Rahmawati, I., & Prasetyo, B. (2021). Pengaruh pendidikan seks terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 100–108.
- Hidayati, N., & Sari, M. (2017). Hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 5(2), 67–74.
- Yuliana, E., & Wulandari, R. (2022). Efektivitas media edukasi dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 23–30.
- Anggraini, D., & Kurniawati, T. (2019). Peran orang tua dalam pendidikan seks pada remaja. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, 7(1), 12–20.
- Pratiwi, R., & Nugroho, A. (2018). Faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri. *Jurnal Gizi Indonesia*, 6(2), 110–117.
- Widiastuti, A., & Suryani, E. (2020). Hubungan siklus menstruasi dengan tingkat stres pada remaja. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 9(2), 95–102.
- Kurniasari, D., & Fitriani, N. (2021). Edukasi kesehatan reproduksi berbasis sekolah dalam meningkatkan perilaku sehat remaja. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(1), 55–63.

BAB 3

KOMUNIKASI DAN KONSELING RAMAH REMAJA: KERAHASIAAN, ETIK, DAN PENDEKATAN BERPUSAT PADA REMAJA

Pendahuluan

Masa remaja merupakan periode transisi yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia, ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara cepat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, remaja memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Komunikasi dan konseling ramah remaja merupakan pendekatan yang menempatkan remaja sebagai pusat pelayanan (*adolescent-centered care*). Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan yang setara, saling menghargai, serta bebas dari stigma dan penilaian negatif. Remaja akan lebih terbuka dan percaya apabila mereka merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun hubungan terapeutik antara bidan dan remaja.

Bab ini akan membahas secara komprehensif konsep komunikasi dan konseling ramah remaja, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti sikap tidak menghakimi, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penghargaan terhadap pendapat remaja, menjaga kerahasiaan, serta memberikan ruang untuk diskusi aktif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mahasiswa kebidanan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, beretika, dan berorientasi pada kebutuhan remaja sebagai individu yang unik dan berkembang.

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Table CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi dalam Praktik Kebidanan	1.1 Menjelaskan definisi, ruang lingkup, determinan, dan prinsip layanan kesehatan reproduksi remaja & prakonsepsi.	1.2 Mengidentifikasi kerangka kebijakan, etika, dan aspek legal dasar (hak, persetujuan, kerahasiaan) pada layanan remaja/prakonsepsi.	CPMK-1	CPMK-7
Bab 2. Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja: Pubertas, Perubahan Psikososial, dan Risiko Kesehatan	2.1 Menganalisis tahapan pubertas dan perubahan biologis remaja serta implikasi kebutuhan kesehatan reproduksi.	2.2 Menganalisis perubahan psikososial dan faktor risiko/perlindungan perilaku berisiko terkait reproduksi.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-5
Bab 3. Anatomi–Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia	3.1 Menjelaskan anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan dasar regulasi hormonal sesuai tahap perkembangan.	3.2 Menyusun rancangan materi edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia, akurat ilmiah, dan sensitif budaya.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Komunikasi dan Konseling Ramah Remaja: Kerahasiaan, Etik, dan Pendekatan Berpusat pada Remaja	4.1 Menerapkan teknik komunikasi ramah remaja (empatik, non-judgmental, membangun kepercayaan).	4.2 Menerapkan prinsip konseling aman (kerahasiaan, informed choice, etik) untuk isu sensitif dan kebutuhan tindak lanjut.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-7
Bab 5. Gizi Remaja dan Status Kesehatan: Anemia, KEK, Obesitas, dan Pencegahan Stunting Antar Generasi	5.1 Menganalisis status gizi remaja serta faktor risiko anemia, KEK, obesitas dan konsekuensi kesehatan reproduksi.	5.2 Merancang intervensi gizi dan gaya hidup untuk pencegahan stunting antar generasi berbasis risiko.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7
Bab 6. Kesehatan Menstruasi: Siklus, Keluhan Umum, Gangguan Menstruasi, dan Tata Laksana Awal	6.1 Menjelaskan fisiologi siklus menstruasi, keluhan umum, dan tanda bahaya yang memerlukan perhatian.	6.2 Melakukan tatalaksana awal gangguan menstruasi sederhana (edukasi, skrining red flags) dan menentukan kebutuhan rujukan.	CPMK-3	CPMK-5; CPMK-6
Bab 7. Pencegahan Kehamilan Remaja: Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan yang Aman	7.1 Menganalisis determinan kehamilan remaja dan strategi pencegahan berbasis edukasi serta dukungan sosial.	7.2 Melakukan konseling kontrasepsi remaja yang aman (informed choice), termasuk akses layanan dan tindak lanjut.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-7
Bab 8. Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining	8.1 Mengidentifikasi faktor risiko IMS/HIV pada remaja serta prinsip pencegahan dan reduksi risiko.	8.2 Melakukan skrining risiko, edukasi pencegahan, dan rujukan/kolaborasi	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Risiko, Edukasi, dan Rujukan		untuk layanan tes dan tatalaksana sesuai alur.		
Bab 9. Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Remaja: Deteksi Dini, Tatalaksana Awal, dan Rujukan	9.1 Mengidentifikasi tanda, dampak, dan faktor risiko kekerasan berbasis gender pada remaja.	9.2 Melakukan tatalaksana awal berbasis trauma (keamanan, dukungan) dan rujukan ke layanan perlindungan sesuai kewenangan.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
Bab 10. Kesehatan Mental Remaja terkait Reproduksi: Stres, Citra Tubuh, dan Perilaku Berisiko	10.1 Menganalisis keterkaitan stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko dengan kesehatan reproduksi remaja.	10.2 Merancang dukungan awal dan rujukan untuk masalah kesehatan mental terkait reproduksi berbasis faktor risiko/protektif.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-4
Bab 11. Konsep Prakonsepsi: Tujuan, Sasaran, dan Paket Pelayanan Prakonsepsi	11.1 Menjelaskan tujuan, sasaran, dan komponen paket pelayanan prakonsepsi pada individu/pasangan.	11.2 Mengidentifikasi determinan kesiapan prakonsepsi dan prioritas masalah untuk perencanaan intervensi.	CPMK-6	CPMK-1; CPMK-7
Bab 12. Skrining dan Intervensi Prakonsepsi: Imunisasi, Penyakit Kronis, Obat, dan Kebiasaan Berisiko	12.1 Melakukan skrining prakonsepsi meliputi imunisasi, penyakit kronis, obat, paparan risiko, dan status gizi.	12.2 Menyusun rencana intervensi prakonsepsi dan tindak lanjut/rujukan berdasarkan hasil skrining.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7
Bab 13. Konseling Prakonsepsi: Perencanaan Kehamilan, KB	13.1 Melakukan konseling prakonsepsi untuk perencanaan kehamilan dan KB	13.2 Menilai kesiapan keluarga dan menyusun rencana tindak lanjut	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Prahamil, dan Kesiapan Keluarga	prahamil secara informed choice.	kolaboratif dengan jejaring layanan.		
Bab 14. Pelayanan Berbasis Sekolah dan Komunitas: Jejaring, Edukasi, dan Pencatatan-Pelaporan	14.1 Merancang layanan/program berbasis sekolah/komunitas (jejaring, peran pemangku kepentingan, inklusivitas).	14.2 Melaksanakan pencatatan–pelaporan dan monitoring–evaluasi sederhana untuk perbaikan layanan berbasis data.	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-5

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tes tulis (MCQ/uraian) + studi kasus etik–legal	Akurasi konsep & determinan; ketepatan identifikasi isu etik/legal dan keputusan yang sesuai prinsip	10	Lembar jawaban ujian; lembar analisis kasus
CPMK-2	Tugas analisis kasus perkembangan remaja + kuis	Ketepatan analisis pubertas/psikososial; ketepatan pemetaan faktor risiko dan faktor protektif	15	Naskah tugas analisis; nilai kuis
CPMK-3	Ujian tulis + proyek desain materi edukasi	Akurasi anatomi–fisiologi/menstruasi termasuk red flags; kualitas materi edukasi sesuai usia (akurasi & kesesuaian)	15	Nilai ujian; poster/leaflet/modul singkat
CPMK-4	Simulasi/OSCE konseling + observasi terstruktur	Keterampilan komunikasi empatik; penerapan kerahasiaan & informed choice;	15	Checklist OSCE; rekaman/video simulasi; ringkas

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		ketepatan rencana tindak lanjut/rujukan		catatan konseling (dummy)
CPMK-5	Proyek rencana intervensi promotif-preventif + presentasi	Ketepatan interpretasi masalah prioritas (gizi/mental); kualitas rancangan intervensi (SMART, feasible, berbasis risiko)	15	Dokumen rencana intervensi; slide/presentasi
CPMK-6	Praktik skrining (skill lab/mini-CEX) + penyusunan care plan	Kelengkapan data skrining & identifikasi red flags; ketepatan rencana intervensi dan jadwal tindak lanjut/rujukan	15	Checklist skrining; care plan prakonsepsi
CPMK-7	Portofolio program sekolah/komunitas + laporan M&E sederhana	Kualitas desain jejaring & alur layanan; ketepatan format pelaporan dan analisis data untuk rekomendasi perbaikan	15	Portofolio program; format pelaporan; laporan M&E

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep & determinan	Banyak konsep keliru/tidak lengkap; determinan tidak relevan	Konsep dasar benar namun kurang lengkap; determinan terbatas	Konsep dan determinan tepat dan cukup lengkap	Konsep sangat tepat, lengkap, dan mampu mengaitkan determinan secara logis
1.2 Ketepatan keputusan	Tidak mampu mengidentifikasi isu; keputusan	Isu teridentifikasi sebagian; keputusan	Isu teridentifikasi jelas; keputusan	Isu komprehensif; keputusan tepat, konsisten, dan mempertimbangkan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik–legal pada kasus	tidak sesuai prinsip	masih umum/kurang tepat	sesuai prinsip utama	konsekuensi serta perlindungan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Analisis pubertas & implikasi risiko	Analisis tidak sesuai tahap; implikasi risiko tidak jelas	Analisis tahap cukup benar; implikasi risiko masih terbatas	Analisis tahap tepat; implikasi risiko jelas dan relevan	Analisis sangat tajam; mampu memprioritaskan risiko dan menjelaskan rasionalnya
2.2 Pemetaan faktor psikososial (risiko/protektif)	Faktor tidak relevan/terlewat banyak	Faktor cukup relevan namun belum terstruktur	Faktor relevan dan terstruktur; ada prioritas awal	Faktor komprehensif, terstruktur, dan menunjukkan hubungan sebab-akibat yang kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi anatomi–fisiologi/menstruasi & red flags	Banyak kesalahan konsep; red flags tidak dikenali	Konsep dasar benar; red flags dikenali sebagian	Konsep akurat; red flags dikenali dan dijelaskan	Konsep sangat akurat; red flags lengkap dan disertai rasional singkat yang kuat
3.2 Kualitas rancangan materi edukasi sesuai usia	Tidak sesuai usia; informasi tidak akurat/menyesatkan	Cukup sesuai usia; akurasi/struktur perlu perbaikan	Sesuai usia; akurat, jelas, dan	Sangat sesuai usia; sangat jelas, menarik, akurat, dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			sensitif budaya	meminimalkan stigma serta bias

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Keterampilan komunikasi ramah remaja	Tidak empatik/terkesan menghakimi; alur komunikasi kacau	Cukup empatik; alur ada tetapi kurang konsisten	Empatik, jelas, terstruktur, dan membangun kepercayaan	Sangat empatik, responsif, menenangkan; mampu mengelola isu sensitif dengan sangat baik
4.2 Kualitas konseling aman & rencana rujukan	Kerahasiaan/informed choice tidak diterapkan; rencana tidak jelas	Prinsip diterapkan sebagian; rencana tindak lanjut umum	Prinsip diterapkan baik; rencana tindak lanjut/rujukan jelas	Prinsip sangat konsisten; rencana rujukan rinci, aman, dan mempertimbangkan hambatan akses serta dukungan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Interpretasi masalah prioritas (gizi/mental)	Interpretasi keliru; prioritas tidak tepat	Interpretasi cukup benar; prioritas belum kuat	Interpretasi tepat; prioritas jelas dan berbasis risiko	Interpretasi sangat tepat; prioritas tajam dengan pertimbangan faktor kontekstual
5.2 Kualitas rancangan intervensi	Tidak SMART/kurang feasible;	Cukup SMART namun	SMART dan feasible; langkah	Sangat SMART; feasible tinggi, terukur, dan mempertimbangkan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
promotif–preventif	langkah tidak runtut	masih umum; feasibility belum jelas	runtut dan terukur	sumber daya/kolaborasi serta strategi keberlanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kelengkapan & ketepatan skrining prakonsepsi	Data penting banyak terlewat; red flags tidak dikenali	Data cukup; red flags dikenali sebagian	Data lengkap dan relevan; red flags dikenali	Data sangat lengkap dan sistematis; red flags lengkap disertai justifikasi singkat
6.2 Rencana intervensi & tindak lanjut/rujukan	Rencana tidak sesuai temuan; tindak lanjut tidak jelas	Rencana cukup sesuai namun kurang terprioritaskan	Rencana sesuai temuan; ada prioritas dan tindak lanjut jelas	Rencana sangat tepat; prioritas kuat, tindak lanjut rinci, dan rujukan tepat waktu sesuai risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Desain jejaring/program sekolah–komunitas	Tidak jelas stakeholder/alur; tidak inklusif	Stakeholder/alur ada namun belum lengkap	Stakeholder dan alur jelas; inklusif dasar	Sangat jelas dan kuat; kolaborasi realistis, inklusif, dan ada strategi keberlanjutan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2 Pencatatan– pelaporan & M&E sederhana	Format tidak rapi/tidak konsisten; indikator tidak jelas	Format cukup; indikator terbatas; analisis minim	Format konsisten; indikator jelas; analisis dasar untuk perbaikan	Format sangat baik; indikator tepat; analisis data bermakna dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang spesifik

A. Konsep Komunikasi dan Konseling Ramah Remaja

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara pemberi pelayanan kesehatan dan klien. Dalam pelayanan kesehatan remaja, komunikasi harus dilakukan secara efektif, empatik, dan tidak menghakimi agar remaja merasa nyaman untuk menyampaikan masalah kesehatannya.

Konseling adalah proses interaksi antara tenaga kesehatan dan klien yang bertujuan membantu klien memahami masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, serta mengembangkan perilaku sehat.

Pelayanan kesehatan ramah remaja merupakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan remaja secara komprehensif, mudah diakses, menjaga privasi, serta menghormati hak-hak remaja.

Karakteristik komunikasi ramah remaja meliputi

1. Sikap terbuka dan tidak menghakimi

Sikap terbuka berarti tenaga kesehatan, khususnya bidan, mampu menerima setiap informasi yang disampaikan oleh remaja tanpa menunjukkan reaksi negatif. Remaja sering kali datang dengan berbagai masalah yang sensitif, seperti menstruasi, hubungan sosial, atau kesehatan reproduksi. Jika bidan menunjukkan sikap menghakimi, seperti menyalahkan atau memberi label negatif, remaja akan cenderung menutup diri. Dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi, bidan dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga remaja merasa dihargai. Hal ini akan mendorong remaja untuk lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapi, sehingga proses konseling dapat berjalan lebih efektif.

2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

Remaja memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga penggunaan bahasa dalam komunikasi harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pendidikan mereka. Penggunaan istilah medis yang terlalu kompleks dapat membuat remaja bingung atau bahkan merasa terintimidasi. Oleh karena itu, bidan perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan komunikatif. Penjelasan juga sebaiknya disertai contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Dengan demikian, informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

3. Menghargai pendapat dan perasaan remaja

Remaja berada dalam tahap perkembangan di mana mereka mulai membentuk identitas diri dan memiliki pandangan sendiri terhadap berbagai hal. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk menghargai setiap

pendapat dan perasaan yang disampaikan oleh remaja. Menghargai bukan berarti selalu menyetujui, tetapi memberikan ruang bagi remaja untuk mengekspresikan dirinya. Bidan perlu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa pendapat remaja dihargai. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri remaja serta memperkuat hubungan terapeutik antara bidan dan klien.

4. Menjaga kerahasiaan informasi

Kerahasiaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan remaja. Banyak remaja merasa khawatir bahwa informasi yang mereka sampaikan akan diketahui oleh orang tua atau orang lain tanpa izin mereka.

Bidan harus menjelaskan sejak awal bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan keselamatan klien. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, remaja akan lebih percaya dan bersedia untuk terbuka mengenai masalah yang dialaminya.

5. Memberikan kesempatan remaja untuk bertanya dan berdiskusi

Komunikasi yang efektif tidak bersifat satu arah, melainkan melibatkan interaksi aktif antara tenaga kesehatan dan klien. Remaja perlu diberikan kesempatan untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, serta mendiskusikan hal-hal yang belum mereka pahami.

Bidan sebaiknya mendorong remaja untuk aktif dalam proses komunikasi, misalnya dengan menggunakan pertanyaan terbuka atau memberikan waktu khusus untuk diskusi. Dengan demikian, remaja tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna.

B. Pengertian Komunikasi dalam Pelayanan Kesehatan Remaja

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, maupun perasaan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi tidak sekadar menjadi sarana untuk menyampaikan informasi medis, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya hubungan yang saling percaya antara tenaga kesehatan dan klien. Hubungan yang baik tersebut sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada kelompok usia remaja, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Masa remaja adalah fase perkembangan yang ditandai oleh berbagai perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Remaja mulai mengalami perubahan hormonal, perkembangan organ reproduksi, serta perubahan cara berpikir dan emosi. Kondisi ini sering kali membuat remaja menghadapi berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait kesehatan mereka, khususnya kesehatan reproduksi.

Namun demikian, tidak semua remaja merasa nyaman untuk membicarakan masalah kesehatannya. Sebagian remaja merasa malu, takut disalahkan, atau khawatir informasi yang mereka sampaikan akan diketahui oleh orang lain.

Pengalaman negatif dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan juga dapat membuat remaja menjadi enggan mencari bantuan. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mampu menciptakan rasa aman, menghargai privasi, dan memberikan ruang bagi remaja untuk menyampaikan masalah yang mereka alami tanpa rasa takut. Dalam praktik pelayanan kesehatan, komunikasi yang efektif tidak hanya ditandai oleh kemampuan berbicara dengan jelas, tetapi juga oleh kemampuan mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, serta memahami kondisi emosional klien. Bagi remaja, sikap tenaga kesehatan yang terbuka dan tidak menghakimi sangat menentukan apakah mereka bersedia melanjutkan komunikasi secara lebih mendalam.

C. Pengertian Konseling dalam Pelayanan Kesehatan Remaja

Konseling merupakan suatu proses interaksi yang terstruktur antara tenaga kesehatan dan klien yang bertujuan membantu klien memahami situasi yang dihadapi serta menemukan solusi yang paling sesuai bagi dirinya. Dalam konteks pelayanan kesehatan remaja, konseling berfungsi sebagai sarana untuk membantu remaja memahami kondisi kesehatannya, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Selain memberikan informasi, konseling juga bertujuan membantu remaja mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Masa remaja sering kali diwarnai oleh pengaruh lingkungan, tekanan dari teman sebaya, serta rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal baru. Melalui konseling yang baik, bidan dapat membantu remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan reproduksi yang sehat di masa depan.

D. Konsep Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja

Pelayanan kesehatan ramah remaja merupakan pendekatan pelayanan yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta kondisi perkembangan remaja. Pendekatan ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya harus berkualitas secara medis, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi remaja. Beberapa ciri pelayanan kesehatan yang ramah remaja antara lain kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, adanya jaminan kerahasiaan informasi, serta sikap tenaga kesehatan yang terbuka dan tidak diskriminatif. Selain itu, lingkungan pelayanan juga perlu dirancang sedemikian rupa sehingga remaja merasa nyaman untuk datang dan berkonsultasi. Informasi

kesehatan yang diberikan kepada remaja juga harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau istilah medis yang sulit dipahami dapat membuat remaja merasa kebingungan atau bahkan enggan untuk melanjutkan komunikasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menyampaikan informasi secara jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana.

E. Prinsip Komunikasi Ramah Remaja

Komunikasi yang efektif dengan remaja memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi pada kelompok usia lainnya. Hal ini karena remaja berada pada tahap perkembangan yang masih mencari jati diri serta sangat peka terhadap cara orang lain memperlakukan mereka. Salah satu prinsip penting dalam komunikasi ramah remaja adalah;

1. Empati. (Jenkins et al., 2022)

Empati merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang efektif dengan remaja. Tidak sekadar memahami secara kognitif, empati menuntut kemampuan untuk “masuk” ke dalam perspektif remaja tanpa kehilangan objektivitas profesional. Kemampuan mendengarkan secara aktif juga sangat penting. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar dipahami. (Doyle et al., 2024).

2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan usia remaja, tidak menghakimi.

Sikap menghakimi, baik secara verbal maupun nonverbal, dapat memicu rasa malu, takut, atau bahkan penolakan dari remaja. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan remaja enggan mengakses layanan kesehatan. Sebaliknya, bahasa yang ramah, terbuka, dan menghargai akan menciptakan suasana yang aman secara psikologis. Remaja akan merasa lebih nyaman untuk berdiskusi, termasuk mengenai topik yang sensitif seperti kesehatan reproduksi, hubungan interpersonal, atau perilaku berisiko.

3. Menghargai otonomi dan partisipasi remaja

Salah satu karakteristik penting pada masa remaja adalah berkembangnya kebutuhan untuk mandiri dan diakui sebagai individu yang mampu mengambil keputusan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus melibatkan remaja secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *shared decision making*, di mana tenaga kesehatan dan klien bekerja sama dalam menentukan langkah terbaik.

Keterlibatan remaja dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri mereka (Thornton et al., 2024).

F. Tahapan Konseling Ramah Remaja

Proses konseling kepada remaja umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

1. Tahap pertama adalah membangun hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan remaja. Pada tahap ini, penting bagi tenaga kesehatan untuk menciptakan suasana yang nyaman serta menjelaskan bahwa percakapan yang dilakukan akan dijaga kerahasiaannya.
2. Tahap mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh remaja. Hal ini dapat dilakukan melalui pertanyaan terbuka yang memungkinkan remaja menceritakan pengalaman atau keluhan yang mereka rasakan.
3. Memberikan informasi yang relevan dan membantu remaja memahami kondisi yang mereka alami. Pada tahap ini, informasi harus disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan rasa takut. Selanjutnya, tenaga kesehatan membantu remaja mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia serta menjelaskan kemungkinan konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Proses ini bertujuan agar remaja dapat mengambil keputusan secara lebih matang.
4. Tahap terakhir adalah memberikan dukungan serta melakukan tindak lanjut apabila diperlukan. Tindak lanjut penting untuk memastikan bahwa remaja memahami informasi yang telah diberikan dan mampu menerapkan keputusan yang telah diambil.



Gambar 3.1. Konseling Ramah Remaja

G. Peran Bidan dalam Komunikasi dan Konseling Remaja.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada remaja. Dalam konteks kesehatan reproduksi, bidan tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan klinis, tetapi juga sebagai pendidik dan konselor bagi remaja. Sikap bidan yang ramah, terbuka, dan menghargai privasi remaja akan meningkatkan kepercayaan remaja terhadap pelayanan kesehatan. Kepercayaan tersebut sangat penting agar remaja merasa nyaman untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah kesehatan.

Dengan demikian, penerapan komunikasi dan konseling ramah remaja dalam pelayanan kebidanan diharapkan dapat membantu remaja memperoleh informasi kesehatan yang benar, meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang sehat, serta mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan reproduksi yang bertanggung jawab di masa depan.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Skenario Kasus

Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri haid yang cukup berat sejak 6 bulan terakhir. Ia tampak ragu-ragu dan tidak banyak bicara saat ditanya oleh bidan. Saat dilakukan anamnesis lebih lanjut, remaja tersebut hanya menjawab singkat dan sering menghindari kontak mata.

Ketika bidan mencoba menggali informasi lebih dalam, remaja tersebut mengatakan bahwa ia merasa takut jika orang tuanya mengetahui bahwa ia datang ke pelayanan kesehatan. Ia juga mengaku pernah mencari informasi di internet, tetapi justru menjadi semakin cemas karena membaca berbagai kemungkinan penyakit.

Bidan memiliki waktu terbatas dan harus tetap memberikan pelayanan yang efektif.

Pertanyaan Diskusi

- Apa saja hambatan komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut?
- Faktor apa yang menyebabkan remaja kurang terbuka?
- Bagaimana bidan seharusnya menunjukkan empati dalam situasi ini?
- Apa bentuk mendengarkan aktif yang dapat dilakukan?
- Bahasa seperti apa yang sebaiknya digunakan?
- Bagaimana cara menjaga kerahasiaan dalam kasus ini?
- Bagaimana melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan?
- Apa yang harus dihindari oleh bidan dalam komunikasi?

H. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	5
2	Judul	Komunikasi dan Konseling Ramah Remaja
3	Kasus	Partus lama/distosia kala I fase aktif dengan tindakan awal dan rujukan
4	Tujuan	Mahasiswa mampu mempraktikkan secara langsung komunikasi dan konseling ramah remaja dengan menerapkan: - Empati - Mendengarkan aktif - Bahasa yang tidak menghakimi - Menjaga kerahasiaan - Melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang ke ruang praktik bidan dengan keluhan nyeri haid dan siklus menstruasi tidak teratur. Remaja tampak cemas, sering melihat ke bawah, dan berbicara pelan. Remaja menyampaikan bahwa ia takut jika orang tuanya mengetahui kondisi yang dialaminya. Ia juga mengatakan bahwa ia mencari informasi di media sosial, tetapi justru menjadi semakin khawatir.

No.	Komponen	Isi
		TUGAS Lakukan komunikasi dan konseling selama 7–10 menit
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS Mengamati seluruh proses komunikasi mahasiswa dengan klien (SP) Menilai berdasarkan checklist yang telah disediakan Tidak memberikan bantuan atau intervensi selama ujian berlangsung Menjaga objektivitas dan konsistensi penilaian INSTRUKSI TAMBAHAN

No.	Komponen	Isi												
		<table><tr><th>Tahap</th><th>Instruksi</th></tr><tr><td>Sebelum ujian</td><td>Pastikan alat, checklist, dan skenario tersedia</td></tr><tr><td>Saat ujian dimulai</td><td>Berikan tanda mulai (timer 7–10 menit)</td></tr><tr><td>Selama ujian</td><td>Tidak boleh memberi petunjuk kepada mahasiswa</td></tr><tr><td>Saat waktu habis</td><td>Berikan tanda berhenti</td></tr><tr><td>Setelah ujian</td><td>Lengkapi penilaian dan catatan</td></tr></table>	Tahap	Instruksi	Sebelum ujian	Pastikan alat, checklist, dan skenario tersedia	Saat ujian dimulai	Berikan tanda mulai (timer 7–10 menit)	Selama ujian	Tidak boleh memberi petunjuk kepada mahasiswa	Saat waktu habis	Berikan tanda berhenti	Setelah ujian	Lengkapi penilaian dan catatan
Tahap	Instruksi													
Sebelum ujian	Pastikan alat, checklist, dan skenario tersedia													
Saat ujian dimulai	Berikan tanda mulai (timer 7–10 menit)													
Selama ujian	Tidak boleh memberi petunjuk kepada mahasiswa													
Saat waktu habis	Berikan tanda berhenti													
Setelah ujian	Lengkapi penilaian dan catatan													
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai remja <table><tr><th>Situasi</th><th>Respon PS</th></tr><tr><td>Mahasiswa tidak menyapa</td><td>Tetap diam / respon singkat</td></tr><tr><td>Mahasiswa tidak empatik</td><td>Tunjukkan ketidaknyamanannya</td></tr><tr><td>Mahasiswa empatik</td><td>Mulai lebih terbuka</td></tr><tr><td>Mahasiswa menghakimi</td><td>Tunjukkan menarik diri / defensif</td></tr><tr><td>Mahasiswa baik</td><td>Berikan informasi lebih lengkap</td></tr></table>	Situasi	Respon PS	Mahasiswa tidak menyapa	Tetap diam / respon singkat	Mahasiswa tidak empatik	Tunjukkan ketidaknyamanannya	Mahasiswa empatik	Mulai lebih terbuka	Mahasiswa menghakimi	Tunjukkan menarik diri / defensif	Mahasiswa baik	Berikan informasi lebih lengkap
Situasi	Respon PS													
Mahasiswa tidak menyapa	Tetap diam / respon singkat													
Mahasiswa tidak empatik	Tunjukkan ketidaknyamanannya													
Mahasiswa empatik	Mulai lebih terbuka													
Mahasiswa menghakimi	Tunjukkan menarik diri / defensif													
Mahasiswa baik	Berikan informasi lebih lengkap													
9	Dialog PS	Peserta: “Selamat pagi, saya bidan ..., boleh saya tahu nama kamu?” PS (respon awal – singkat): “Iya... saya Sinta.” Catatan PS: Jawab singkat dulu, belum terlalu terbuka. Peserta: “Apa yang membuat Sinta datang hari ini?”												

No.	Komponen	Isi
		PS: "Saya sering sakit perut kalau lagi haid... sakit banget." Jika mahasiswa empatik: PS mulai lebih terbuka. Jika mahasiswa cuek: PS tetap singkat. Peserta: "Sejak kapan dirasakan?" PS: "Sekitar 6 bulan ini... biasanya hari pertama." Peserta: "Seberapa nyerinya?" PS: "Sampai susah sekolah... kadang cuma tiduran." Peserta (empatik): "Kedengarannya tidak nyaman ya, pasti mengganggu aktivitas kamu." PS (mulai terbuka): "Iya... saya jadi takut... itu normal nggak sih?" Kunci: PS menunjukkan kecemasan. Jika Peserta Tidak Empatik Jika mahasiswa berkata kaku/menyepelekan: PS (defensif): "Ya sudah... mungkin biasa aja..." (menutup diri) 6. Jika Peserta Menjaga Privasi

No.	Komponen	Isi
		Peserta: "Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia ya." PS (lebih nyaman): "Oh... iya, jadi agak lega sih..." Peserta: "Nyeri haid seperti itu cukup sering terjadi pada remaja..." PS: "Oh gitu... saya kira penyakit serius..." Peserta: "Kita bisa lakukan beberapa cara untuk mengurangi nyeri..." PS: "Kayak apa ya, Kak?" Peserta: "Menurut kamu, cara apa yang kira-kira bisa kamu coba?" PS: "Mungkin minum hangat atau istirahat ya..." Menunjukkan keterlibatan remaja Peserta: "Ada yang ingin kamu tanyakan lagi?" PS: "Kalau sakit banget, boleh minum obat nggak?" Peserta (jawaban baik): "Boleh, tapi harus sesuai anjuran ya..." PS (akhir): "Iya, terima kasih ya... jadi lebih tenang."
12	Kebutuhan alat	

No.	Komponen	Isi																																				
		Alat Khusus Konseling Remaja <table> <tr> <th>No</th><th>Alat/Bahan</th><th>Fungsi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Leaflet kesehatan remaja</td><td>Media edukasi</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Flipchart / booklet</td><td>Membantu penjelasan</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kartu edukasi</td><td>Visual interaktif</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Model anatomi sederhana</td><td>(opsional) untuk penja</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Kartu skala nyeri</td><td>Menilai tingkat nyeri</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Form catatan konseling</td><td>Simulasi dokumentasi</td></tr> </table> Kebutuhan untuk Pasien Standar (PS) <table> <tr> <th>No</th><th>Kebutuhan</th><th>Keterangan</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pakaian remaja</td><td>Sederhana & sesuai usia</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Script skenario</td><td>Dipegang sebelum ujia</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Briefing</td><td>30–60 menit sebelum O</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Cue card</td><td>(opsional) untuk konsist</td></tr> </table>	No	Alat/Bahan	Fungsi	1	Leaflet kesehatan remaja	Media edukasi	2	Flipchart / booklet	Membantu penjelasan	3	Kartu edukasi	Visual interaktif	4	Model anatomi sederhana	(opsional) untuk penja	5	Kartu skala nyeri	Menilai tingkat nyeri	6	Form catatan konseling	Simulasi dokumentasi	No	Kebutuhan	Keterangan	1	Pakaian remaja	Sederhana & sesuai usia	2	Script skenario	Dipegang sebelum ujia	3	Briefing	30–60 menit sebelum O	4	Cue card	(opsional) untuk konsist
No	Alat/Bahan	Fungsi																																				
1	Leaflet kesehatan remaja	Media edukasi																																				
2	Flipchart / booklet	Membantu penjelasan																																				
3	Kartu edukasi	Visual interaktif																																				
4	Model anatomi sederhana	(opsional) untuk penja																																				
5	Kartu skala nyeri	Menilai tingkat nyeri																																				
6	Form catatan konseling	Simulasi dokumentasi																																				
No	Kebutuhan	Keterangan																																				
1	Pakaian remaja	Sederhana & sesuai usia																																				
2	Script skenario	Dipegang sebelum ujia																																				
3	Briefing	30–60 menit sebelum O																																				
4	Cue card	(opsional) untuk konsist																																				
13	Penulis	An Nisa Fithri																																				
14	Referensi	Bullington, B. W., Smith, K. J., & Lee, R. M. (2025). Clinician perspectives on adolescent contraceptive counseling. <i>Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology</i>, 38(1), 45–52. Cody, P. (2024). Sexual and reproductive health screening and counseling in adolescents. <i>Pediatric Transplantation</i>, 28(3), e14567. Firsa, A. Z., Rahman, H., & Putri, N. A. (2025). The effectiveness of group counseling on adolescent reproductive health behavior. <i>Counsnesia Journal</i>, 6(1), 12–20.																																				

No.	Komponen	Isi
		Hartup, L. A., Green, J. M., & Wallace, E. (2024). Reproductive health consultation in adolescents and young adults. <i>Journal of Adolescent and Young Adult Oncology</i>, 13(2), 89–95. Kustin, K., & Handayani, Y. (2024). Peer counseling in improving adolescent reproductive health knowledge and skills. <i>Jurnal Kesehatan Komunitas</i>, 10(2), 101–108. Rahmawati, D. A., Sari, M., & Wulandari, R. (2025). Improvement of adolescents' knowledge on reproductive health through counseling intervention. <i>TOFEDU Journal</i>, 4(1), 22–30. Dixon, S., Carter, J., & Lewis, P. (2024). Adolescent dysmenorrhea management in primary care settings. <i>Frontiers in Reproductive Health</i>, 6, 112233. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)</i>. Jakarta: Kemenkes RI. World Health Organization. (2018). <i>Global standards for quality health-care services for adolescents</i>. Geneva: WHO. United Nations Population Fund. (2019). <i>Adolescent sexual and reproductive health toolkit</i>. New York: UNFPA. Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2019). <i>Varney's midwifery</i> (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Dismenore pada remaja

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat keluhan ➤ Sejak kapan keluhan muncul? ➤ Seberapa sering terjadi? ➤ Seberapa berat (misalnya skala nyeri 1–10)? ➤ Apa yang memperberat/mengurangi? ➤ Dampak terhadap aktivitas (sekolah, tidur, dll)		
3. Riwayat Menstruasi (Jika relevan) ➤ Usia pertama haid (menarche) ➤ Siklus haid (teratur/tidak) ➤ Lama haid ➤ Keluhan saat haid (nyeri, banyak, dll)		
4. Riwayat Kesehatan Reproduksi Disampaikan dengan hati-hati & tidak menghakimi: ➤ “Apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan serupa?” ➤ “Apakah pernah mendapatkan informasi atau pengobatan sebelumnya?”		
5. Riwayat Kesehatan Umum ➤ Penyakit yang pernah dialami ➤ Alergi ➤ Konsumsi obat atau herbal		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Pemeriksaan Fisik

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
A. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi klien		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran		
b. Menilai tanda vital		
h. Menyimpulkan hasil pemeriksaan		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil pemeriksaan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **1-3 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **1-2 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi dengan bahasa sederhana		
3. Meluruskan informasi yang salah (misinformasi)		
4. Memberikan pilihan solusi		
5. Menggunakan media edukasi bila tersedia		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Kompres hangat		
Istirahat cukup		
Aktivitas ringan		
Edukasi penggunaan obat sesuai anjuran		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan		
2. Menghargai pendapat dan pilihan		
3. Memberikan kesempatan bertanya		
4. Mendorong kemandirian dalam menjaga kesehatan		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji:.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Konseling Ramah Remaja

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus dismenore pada remaja
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Dalam konteks ini, dosen/penguji mengamati secara langsung kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling ramah remaja, meliputi komunikasi efektif, empati, penggalian masalah, edukasi, serta penerapan prinsip etik dan kerahasiaan. Penilaian dilakukan saat mahasiswa berinteraksi dengan pasien standar (remaja) dalam situasi simulasi klinik. Aspek yang dinilai mencakup: • Keterampilan komunikasi • Sikap profesional (empati, non-judgmental) • Kemampuan konseling dan edukasi • Pengambilan keputusan sederhana • Keselamatan dan kenyamanan klien	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan komunikasi, kemampuan membangun hubungan, sikap empati dan profesionalisme, kemampuan memberikan edukasi yang tepat
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam:	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang

	• Melakukan komunikasi dan konseling yang efektif pada remaja • Membangun hubungan saling percaya (rapport) • Mengidentifikasi masalah kesehatan remaja secara tepat • Memberikan edukasi yang sesuai, aman, dan aplikatif • Menunjukkan sikap profesional, menjaga kerahasiaan, dan menghormati klien WHO menekankan bahwa pelayanan kesehatan remaja harus ramah, aman, tidak menghakimi, dan menjaga privasi, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip tersebut dalam praktik.	intervensi dysmenorhoe pada remaja, tetapi • Apa yang dikatakan (verbal) • Bagaimana cara menyampaikan (nonverbal) • Respon terhadap kondisi remaja
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi yang sering ditemui dalam pelayanan kesehatan remaja, seperti: • Dismenore • Siklus menstruasi tidak teratur • Keputihan • Kecemasan terkait kesehatan reproduksi • Persiapan prakonsepsi	Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang dengan keluhan nyeri saat menstruasi sejak 6 bulan terakhir. Nyeri dirasakan terutama pada hari pertama haid dan mengganggu aktivitas sekolah. Pasien tampak cemas dan khawatir kondisi tersebut merupakan penyakit serius.

		.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pembimbing mengamati mahasiswa yang sedang melakukan konseling kepada remaja dengan keluhan nyeri haid.	Mahasiswa melakukan pembukaan dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan kerahasiaan. Mahasiswa kemudian menggali keluhan menggunakan pertanyaan terbuka, menanyakan durasi, intensitas nyeri (skala nyeri), serta dampaknya terhadap aktivitas. Mahasiswa menunjukkan empati dengan mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan perasaan klien. Selanjutnya mahasiswa memberikan edukasi bahwa nyeri haid merupakan kondisi yang sering terjadi pada remaja (dismenore primer), serta memberikan saran seperti: • Kompres hangat • Istirahat cukup • Aktivitas ringan • Penggunaan obat sesuai anjuran Mahasiswa juga melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan

		bertanya, serta menyampaikan tanda bahaya dan rencana tindak lanjut.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi · Cara berkomunikasi · Kemampuan membangun hubungan · Sikap empati dan profesionalisme · Kemampuan memberikan edukasi yang tepat	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu membuka dengan ramah Menjelaskan kerahasiaan, Menggali keluhan dengan pertanyaan terbuka, Menunjukkan empati saat klien bercerita, Memberikan edukasi sederhana dan relevan, Mengajak klien berdiskusi, Menutup dengan rangkuman dan tindak lanjut
Fokus observasi pembimbing	Mahasiswa dinilai kurang kompeten apabila: • Tidak menunjukkan empati • Bersikap menghakimi • Tidak menjaga kerahasiaan • Komunikasi tidak sesuai dengan remaja • Tidak mampu memberikan edukasi yang benar	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa Komunikasi dengan remaja harus menggunakan bahasa yang sederhana, santai, dan mudah dipahami. Tenaga kesehatan perlu menghindari istilah medis yang rumit serta menyesuaikan gaya komunikasi agar tidak terkesan kaku atau mengintimidasi.

Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, Membangun hubungan yang baik menjadi kunci keberhasilan konseling. Remaja akan lebih terbuka jika merasa aman, dihargai, dan dipercaya. Empati ditunjukkan dengan kemampuan memahami perasaan remaja tanpa menghakimi. Sikap profesional tercermin dari perilaku yang menghargai, tidak menyalahkan, dan tetap menjaga batasan peran tenaga kesehatan.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila. Cara Berkomunikasi menggunakan bahasa yang sederhana, remaja bersikap terbuka karena mahasiswa mampu membangun Hubungan (Rapport), Menunjukkan sikap empati dan profesionalisme, mampu memberikan edukasi yang baik

Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus dismenore pada remaja, mahasiswa tidak hanya mampu memberikan intervensi, namun berperan sebagai edukator dan advokat dalam menangani kasus.
-----------------	---	---

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio Dismenenore pada remaja

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dismenore Remaja
Identitas Mahasiswa	Data mahasiswa yang menyusun portofolio	Nama: A, NIM: 12345, Semester: III
Waktu & Tempat Praktik	Lokasi dan waktu pelayanan	Puskesmas X, 10 Januari 2026
Identitas Pasien	Data dasar pasien	Remaja perempuan, usia 16 tahun
Keluhan Utama	Keluhan utama pasien	Nyeri perut saat menstruasi
Pengkajian (Anamnesis)	Data subjektif dari pasien	Nyeri hari pertama haid, skala 6/10, mengganggu aktivitas sekolah

Pemeriksaan Fisik	Data objektif	TTV normal, tidak ada kelainan
Analisis Masalah	Interpretasi klinis	Dismenore primer
Diagnosis	Penetapan diagnosis	Dismenore primer
Perencanaan Asuhan	Rencana tindakan	Konseling, edukasi manajemen nyeri, anjuran nonfarmakologi
Tindakan/Implementasi	Tindakan yang dilakukan	Memberikan edukasi kompres hangat, olahraga ringan, istirahat
Edukasi & Konseling	Informasi yang diberikan	Penjelasan kondisi, cara mengatasi nyeri, penggunaan obat aman
Evaluasi	Hasil setelah tindakan	Pasien memahami kondisi dan merasa lebih tenang
Tindak Lanjut	Rencana lanjutan	Disarankan kontrol bila nyeri tidak membaik
Aspek Komunikasi	Cara komunikasi dengan pasien	Bahasa sederhana, empatik, tidak menghakimi
Patient Safety	Upaya keselamatan pasien	Edukasi penggunaan obat yang rasional dan aman
Bukti Dokumentasi	Bukti kegiatan	Catatan SOAP, lembar edukasi, checklist
Refleksi Mahasiswa	Pembelajaran yang diperoleh	Menyadari pentingnya komunikasi empatik dan pendekatan ramah remaja
Rencana Perbaikan	Pengembangan diri	Meningkatkan keterampilan konseling dan clinical reasoning

Tabel. Case Report Dismenore pada remaja

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dismenore Remaja
Identitas Pasien	Data dasar pasien	Remaja perempuan, usia 16 tahun, pelajar
Keluhan Utama	Keluhan yang dirasakan pasien saat datang	Nyeri perut bagian bawah saat menstruasi
Riwayat Penyakit Sekarang	Kronologi keluhan	Nyeri muncul sejak 6 bulan terakhir, terutama hari pertama haid, skala nyeri 6/10, mengganggu aktivitas
Riwayat Menstruasi	Pola siklus haid	Siklus 28 hari, lama haid 5–6 hari, tidak ada perdarahan berlebih
Riwayat Kesehatan	Riwayat penyakit sebelumnya	Tidak ada riwayat penyakit kronis
Riwayat Pengobatan	Penggunaan obat sebelumnya	Kadang minum obat pereda nyeri tanpa resep
Pemeriksaan Fisik	Hasil pemeriksaan klinis	Tanda vital normal, tidak ada kelainan abdomen
Analisis Masalah	Interpretasi klinis	Dismenore primer (nyeri haid tanpa kelainan organik)
Diagnosis	Penetapan diagnosis	Dismenore primer
Tindakan/Intervensi	Tatalaksana yang diberikan	Konseling ramah remaja, edukasi manajemen nyeri, anjuran kompres hangat dan olahraga ringan
Edukasi	Informasi yang diberikan kepada pasien	Penjelasan kondisi normal, cara mengatasi nyeri, penggunaan obat yang aman
Tindak Lanjut	Rencana monitoring	Kontrol jika nyeri bertambah berat atau tidak membaik

Aspek Komunikasi	Cara berinteraksi dengan pasien	Menggunakan bahasa sederhana, menjaga privasi, tidak menghakimi
Patient Safety	Upaya menjaga keselamatan pasien	Menghindari penggunaan obat berlebihan, edukasi dosis aman
Refleksi Mahasiswa	Evaluasi diri pembelajar	Mahasiswa menyadari pentingnya komunikasi empatik dan edukasi yang jelas pada remaja

Tabel. Refleksi Patient Safety Dismenore pada remaja

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dismenore Remaja
Identifikasi Risiko	Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat membahayakan pasien	Nyeri haid berat menyebabkan remaja tidak masuk sekolah, penggunaan obat pereda nyeri tanpa pengawasan
Komunikasi Efektif	Komunikasi yang jelas, empatik, dan sesuai usia remaja	Bidan menggunakan bahasa sederhana, tidak menghakimi, dan memberi ruang remaja untuk bercerita
Kerahasiaan (Confidentiality)	Menjaga privasi dan informasi pasien	Bidan menjamin bahwa keluhan remaja tidak disebarkan tanpa izin
Pengambilan Keputusan Aman	Tindakan klinis berdasarkan standar dan evidence-based	Memberikan edukasi kompres hangat, olahraga ringan, dan analgesik sesuai dosis aman
Pencegahan Kesalahan	Menghindari kesalahan dalam pemberian terapi atau informasi	Memastikan dosis obat sesuai usia, tidak overuse obat nyeri
Edukasi Pasien	Memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman pasien	Menjelaskan bahwa dismenore primer umum terjadi dan dapat dikelola

Pemantauan & Evaluasi	Menilai perkembangan kondisi pasien	Menyarankan kontrol jika nyeri tidak membaik atau semakin berat
Kolaborasi	Kerja sama dengan tenaga kesehatan lain bila diperlukan	Rujukan ke dokter jika dicurigai dismenore sekunder
Refleksi Tenaga Kesehatan	Evaluasi diri terhadap pelayanan yang diberikan	Bidan mengevaluasi apakah komunikasi sudah efektif dan remaja merasa nyaman

I. Ringkasan

Komunikasi & Konseling Ramah Remaja: Kerahasiaan, Etik, dan Pendekatan Berpusat pada Remaja

Komunikasi dengan remaja memerlukan pendekatan yang berbeda karena mereka berada pada fase pencarian jati diri dan cenderung sensitif terhadap cara diperlakukan. Oleh karena itu, bidan perlu menerapkan komunikasi yang empatik, tidak menghakimi, serta menggunakan bahasa yang sederhana agar remaja merasa nyaman dan dihargai.

Prinsip utama komunikasi ramah remaja meliputi empati, mendengarkan aktif, penghargaan terhadap pendapat, serta pemberian ruang bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi. Selain itu, menjaga kerahasiaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Remaja akan lebih terbuka apabila merasa aman bahwa informasi pribadinya tidak akan disebarluaskan.

Pendekatan berpusat pada remaja (youth-centered care) menempatkan remaja sebagai subjek utama dalam pelayanan. Remaja dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kesehatannya. Dalam kasus dismenore, bidan tidak hanya memberikan penatalaksanaan nyeri, tetapi juga edukasi yang sesuai usia serta dukungan emosional.

Aspek keselamatan pasien tetap menjadi perhatian, termasuk mengenali tanda bahaya (red flags) dan melakukan rujukan bila diperlukan. Dengan demikian, komunikasi dan konseling ramah remaja tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membentuk hubungan terapeutik yang mendukung kesehatan remaja secara menyeluruh.

Alur asuhan singkat

Asuhan dismenore pada remaja → Pendekatan komunikasi ramah remaja → Edukasi yang tepat dan aman → Deteksi dini tanda bahaya → Pelibatan remaja dalam pengambilan keputusan

Tabel Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Nyeri haid sangat berat (skala $\geq 8/10$) dan tidak membaik dengan terapi biasa	Kemungkinan dismenore sekunder atau kondisi patologis	Rujuk ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut (USG/pemeriksaan lanjutan)
Nyeri haid disertai perdarahan sangat banyak (menorrhagia)	Risiko anemia atau gangguan hormonal	Lakukan pemeriksaan Hb dan rujuk bila perlu
Nyeri tidak hanya saat haid (nyeri kronis)	Curiga endometriosis atau kelainan organ reproduksi	Rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut
Siklus menstruasi tidak teratur secara signifikan	Gangguan hormonal atau kondisi sistemik	Konsultasi lanjutan dan pemeriksaan hormon
Dismenore muncul tiba-tiba setelah sebelumnya tidak ada	Kemungkinan kondisi patologis baru	Evaluasi menyeluruh dan rujukan
Nyeri disertai demam atau keputihan abnormal	Kemungkinan infeksi	Rujuk untuk pemeriksaan dan terapi antibiotik
Penggunaan obat nyeri berlebihan tanpa kontrol	Risiko efek samping obat	Edukasi penggunaan obat rasional dan monitoring
Nyeri menyebabkan gangguan aktivitas berat (tidak sekolah/aktivitas)	Dampak signifikan terhadap kualitas hidup	Evaluasi menyeluruh dan intervensi lebih lanjut
Remaja tampak cemas berlebihan atau stres terkait nyeri	Dampak psikologis	Konseling dan dukungan psikologis
Tidak ada perbaikan setelah intervensi nonfarmakologi dan farmakologi	Kemungkinan diagnosis tidak tepat	Rujuk dan evaluasi ulang diagnosis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Asuhan Kebidanan Remaja & Prakonsepsi – Dismenore Remaja

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya mampu melakukan anamnesis pada remaja dengan keluhan nyeri haid secara sistematis	☐	☐	
2	Saya mampu membangun komunikasi ramah remaja (empatik, tidak menghakimi)	☐	☐	
3	Saya mampu menjaga kerahasiaan informasi pasien remaja	☐	☐	
4	Saya mampu mengidentifikasi tanda dan gejala dismenore primer	☐	☐	
5	Saya mampu membedakan dismenore primer dan sekunder secara sederhana	☐	☐	
6	Saya mampu melakukan pemeriksaan dasar yang relevan	☐	☐	
7	Saya mampu memberikan edukasi nonfarmakologi (kompres hangat, olahraga ringan)	☐	☐	
8	Saya mampu menjelaskan penggunaan obat nyeri secara aman	☐	☐	
9	Saya mampu mengidentifikasi red flags pada dismenore	☐	☐	
10	Saya mampu menentukan kapan harus merujuk pasien	☐	☐	
11	Saya mampu mendokumentasikan asuhan dalam format SOAP	☐	☐	
12	Saya mampu memberikan kesempatan remaja untuk bertanya dan berdiskusi	☐	☐	
13	Saya mampu melakukan konseling yang melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan	☐	☐	

14	Saya mampu menerapkan prinsip patient safety dalam asuhan remaja	☐	☐	
15	Saya mampu melakukan refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Latihan Soal

1. Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang sendiri ke klinik dengan keluhan nyeri haid berat sejak 6 bulan terakhir. Ia tampak cemas dan meminta agar keluhannya tidak disampaikan kepada orang tuanya. Bidan menjelaskan tentang kerahasiaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan pasien. Tindakan paling tepat yang dilakukan bidan adalah...
 - A. Menolak memberikan pelayanan tanpa kehadiran orang tua
 - B. Menjaga kerahasiaan sepenuhnya tanpa pengecualian
 - C. Menjelaskan batasan kerahasiaan dan tetap melakukan pengkajian
 - D. Langsung merujuk tanpa penjelasan
 - E. Mengabaikan permintaan pasien

2. Seorang remaja usia 15 tahun mengeluh nyeri haid hingga tidak masuk sekolah. Ia mengatakan sudah minum obat pereda nyeri setiap bulan tanpa aturan yang jelas. Bidan ingin memastikan keselamatan pasien sekaligus meningkatkan pemahaman remaja. Pendekatan yang paling tepat adalah...
 - A. Melarang penggunaan obat tanpa penjelasan
 - B. Memberikan edukasi dosis obat yang aman dan alternatif nonfarmakologi
 - C. Mengganti obat dengan yang lebih kuat
 - D. Menyarankan berhenti minum obat sama sekali
 - E. Mengabaikan kebiasaan pasien

3. Dalam sesi konseling, bidan menemukan bahwa remaja sulit terbuka dan hanya menjawab singkat. Bidan kemudian mengubah pendekatan dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan menunjukkan empati. Analisis terhadap tindakan bidan tersebut adalah...
 - A. Tidak efektif karena memperpanjang waktu
 - B. Tidak sesuai standar pelayanan
 - C. Merupakan strategi komunikasi terapeutik yang tepat
 - D. Hanya diperlukan pada pasien dewasa
 - E. Tidak berpengaruh terhadap hasil asuhan

4. Seorang remaja usia 17 tahun mengeluh nyeri haid hebat (skala 8/10), disertai perdarahan banyak dan tidak membaik dengan terapi. Bidan mempertimbangkan kemungkinan adanya kondisi patologis. Langkah klinis yang paling tepat adalah...
 - A. Melanjutkan terapi yang sama

- B. Memberikan edukasi saja
 - C. Menunggu hingga siklus berikutnya
 - D. Melakukan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan
 - E. Menghentikan semua terapi
5. Dalam praktik asuhan, bidan memberikan beberapa pilihan penanganan dismenore dan meminta remaja memilih sesuai kenyamanan setelah diberikan informasi lengkap.
Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip...
- A. Beneficence tanpa otonomi
 - B. Paternalistik
 - C. *Youth-centered care and shared decision making*
 - D. Efisiensi pelayanan
 - E. Standarisasi prosedur

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Soal 1

Jawaban yang benar : C

Pembahasan: Komunikasi ramah remaja dimulai dengan membangun kepercayaan melalui empati dan sikap tidak menghakimi.

Soal 2

Jawaban yang benar: B

Pembahasan: Menjaga kerahasiaan merupakan kunci agar remaja merasa aman untuk terbuka.

Soal 3

Jawaban yang benar: C

Pembahasan: Penggunaan bahasa sederhana dan teknik teach-back merupakan bagian dari komunikasi efektif.

Soal 4

Jawaban yang benar: D

Pembahasan: Kondisi tersebut termasuk red flags sehingga perlu dilakukan rujukan.

Soal 5

Jawaban yang benar: D

Pembahasan: Melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan merupakan inti pendekatan berpusat pada remaja.

J. Daftar Pustaka

- Bullington, B. W., Smith, K. J., & Lee, R. M. (2025). Clinician perspectives on adolescent contraceptive counseling. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 38(1), 45–52.
- Chipako, I., Nyoni, T., & Dube, S. (2024). Impact of sexual and reproductive health interventions among adolescents: A systematic review. *Frontiers in Global Women's Health*, 5, 1344135.
- Cody, P. (2024). Sexual and reproductive health screening and counseling in adolescents. *Pediatric Transplantation*, 28(3), e14567.
- Doyle, A. A., Patel, S., & Brown, L. (2024). Adolescent reproductive health: Current perspectives and future directions. *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*, 36(4), 310–315.
- Firsa, A. Z., Rahman, H., & Putri, N. A. (2025). The effectiveness of group counseling on adolescent reproductive health behavior. *Counsensia Journal*, 6(1), 12–20.
- Hartup, L. A., Green, J. M., & Wallace, E. (2024). Reproductive health consultation in adolescents and young adults. *Journal of Adolescent and Young Adult Oncology*, 13(2), 89–95.
- Kustin, K., & Handayani, Y. (2024). Peer counseling in improving adolescent reproductive health knowledge and skills. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 10(2), 101–108.
- Rahmawati, D. A., Sari, M., & Wulandari, R. (2025). Improvement of adolescents' knowledge on reproductive health through counseling intervention. *TOFEDU Journal*, 4(1), 22–30.
- Thornton, M., Clark, L., & Nguyen, T. (2024). Shared decision-making in adolescent contraceptive counseling. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 56(2), 78–86.
- Dixon, S., Carter, J., & Lewis, P. (2024). Adolescent dysmenorrhea management in primary care settings. *Frontiers in Reproductive Health*, 6, 112233.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Buku saku kesehatan reproduksi remaja*. Jakarta: BKKBN.
- World Health Organization. (2018). *Global standards for quality health-care services for adolescents*. Geneva: WHO.
- United Nations Population Fund. (2019). *Adolescent sexual and reproductive health toolkit*. New York: UNFPA.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Geger, C. L. (2019). *Varney's midwifery* (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

BAB 4

GIZI REMAJA DAN STATUS KESEHATAN: ANEMIA, KEK, OBESITAS, DAN PENCEGAHAN STUNTING ANTAR GENERASI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi dalam Praktik Kebidanan	1.1 Menjelaskan definisi, ruang lingkup, determinan, dan prinsip layanan kesehatan reproduksi remaja & prakonsepsi.	1.2 Mengidentifikasi kerangka kebijakan, etika, dan aspek legal dasar (hak, persetujuan, kerahasiaan) pada layanan remaja/prakonsepsi.	CPMK-1	CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja: Pubertas, Perubahan Psikososial, dan Risiko Kesehatan	2.1 Menganalisis tahapan pubertas dan perubahan biologis remaja serta implikasi kebutuhan kesehatan reproduksi.	2.2 Menganalisis perubahan psikososial dan faktor risiko/perlindungan perilaku berisiko terkait reproduksi.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-5
Bab 3. Anatomi–Fisiologi Reproduksi dan Edukasi Seksualitas Komprehensif sesuai Tahap Usia	3.1 Menjelaskan anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan dasar regulasi hormonal sesuai tahap perkembangan.	3.2 Menyusun rancangan materi edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia, akurat ilmiah, dan sensitif budaya.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5
Bab 4. Komunikasi dan Konseling Ramah Remaja: Kerahasiaan, Etik, dan Pendekatan Berpusat pada Remaja	4.1 Menerapkan teknik komunikasi ramah remaja (empatik, non-judgmental, membangun kepercayaan).	4.2 Menerapkan prinsip konseling aman (kerahasiaan, informed choice, etik) untuk isu sensitif dan kebutuhan tindak lanjut.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-7
Bab 5. Gizi Remaja dan Status Kesehatan: Anemia, KEK, Obesitas, dan Pencegahan Stunting Antar Generasi	5.1 Menganalisis status gizi remaja serta faktor risiko anemia, KEK, obesitas dan konsekuensi kesehatan reproduksi.	5.2 Merancang intervensi gizi dan gaya hidup untuk pencegahan stunting antar generasi berbasis risiko.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7
Bab 6. Kesehatan Menstruasi: Siklus, Keluhan Umum, Gangguan	6.1 Menjelaskan fisiologi siklus menstruasi, keluhan umum, dan tanda bahaya yang	6.2 Melakukan tatalaksana awal gangguan menstruasi sederhana (edukasi, skrining red flags) dan	CPMK-3	CPMK-5; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Menstruasi, dan Tata Laksana Awal	memerlukan perhatian.	menentukan kebutuhan rujukan.		
Bab 7. Pencegahan Kehamilan Remaja: Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan yang Aman	7.1 Menganalisis determinan kehamilan remaja dan strategi pencegahan berbasis edukasi serta dukungan sosial.	7.2 Melakukan konseling kontrasepsi remaja yang aman (informed choice), termasuk akses layanan dan tindak lanjut.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-7
Bab 8. Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan	8.1 Mengidentifikasi faktor risiko IMS/HIV pada remaja serta prinsip pencegahan dan reduksi risiko.	8.2 Melakukan skrining risiko, edukasi pencegahan, dan rujukan/kolaborasi untuk layanan tes dan tatalaksana sesuai alur.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7
Bab 9. Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Remaja: Deteksi Dini, Tatalaksana Awal, dan Rujukan	9.1 Mengidentifikasi tanda, dampak, dan faktor risiko kekerasan berbasis gender pada remaja.	9.2 Melakukan tatalaksana awal berbasis trauma (keamanan, dukungan) dan rujukan ke layanan perlindungan sesuai kewenangan.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
Bab 10. Kesehatan Mental Remaja terkait Reproduksi: Stres, Citra Tubuh, dan Perilaku Berisiko	10.1 Menganalisis keterkaitan stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko dengan kesehatan reproduksi remaja.	10.2 Merancang dukungan awal dan rujukan untuk masalah kesehatan mental terkait reproduksi berbasis faktor risiko/protektif.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-4
Bab 11. Konsep Prakonsepsi: Tujuan, Sasaran, dan Paket Pelayanan Prakonsepsi	11.1 Menjelaskan tujuan, sasaran, dan komponen paket pelayanan prakonsepsi pada individu/pasangan.	11.2 Mengidentifikasi determinan kesiapan prakonsepsi dan prioritas masalah untuk perencanaan intervensi.	CPMK-6	CPMK-1; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 12. Skrining dan Intervensi Prakonsepsi: Imunisasi, Penyakit Kronis, Obat, dan Kebiasaan Berisiko	12.1 Melakukan skrining prakonsepsi meliputi imunisasi, penyakit kronis, obat, paparan risiko, dan status gizi.	12.2 Menyusun rencana intervensi prakonsepsi dan tindak lanjut/rujukan berdasarkan hasil skrining.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7
Bab 13. Konseling Prakonsepsi: Perencanaan Kehamilan, KB Prahamil, dan Kesiapan Keluarga	13.1 Melakukan konseling prakonsepsi untuk perencanaan kehamilan dan KB praamil secara informed choice.	13.2 Menilai kesiapan keluarga dan menyusun rencana tindak lanjut kolaboratif dengan jejaring layanan.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-6
Bab 14. Pelayanan Berbasis Sekolah dan Komunitas: Jejaring, Edukasi, dan Pencatatan-Pelaporan	14.1 Merancang layanan/program berbasis sekolah/komunitas (jejaring, peran pemangku kepentingan, inklusivitas).	14.2 Melaksanakan pencatatan-pelaporan dan monitoring-evaluasi sederhana untuk perbaikan layanan berbasis data.	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-5

Uraian Materi

Masa remaja merupakan periode kritis dalam siklus kehidupan yang ditandai oleh percepatan pertumbuhan fisik, maturasi organ reproduksi, serta perkembangan psikososial yang pesat. Pada fase ini kebutuhan zat gizi meningkat secara signifikan, terutama energi, protein, zat besi, asam folat, kalsium, dan berbagai mikronutrien lainnya. Ketidakseimbangan asupan gizi pada remaja berkontribusi terhadap munculnya berbagai masalah kesehatan seperti anemia, kekurangan energi kronik (KEK), dan obesitas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi status kesehatan reproduksi serta kualitas generasi berikutnya. Bukti penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi pada masa remaja efektif menurunkan prevalensi anemia dan memperbaiki outcome kesehatan jangka panjang, termasuk memutus siklus malnutrisi antar generasi.

Di Indonesia, masalah gizi remaja masih menjadi tantangan besar dalam konteks triple burden of malnutrition, yaitu kekurangan gizi, kekurangan mikronutrien, dan kelebihan berat badan/obesitas. Remaja putri merupakan kelompok yang sangat rentan karena anemia dan KEK pada fase ini berhubungan erat dengan risiko kehamilan berisiko, bayi berat lahir rendah, serta stunting pada anak di masa mendatang. UNICEF Indonesia menegaskan bahwa anemia pada remaja putri merupakan salah satu pintu masuk utama terjadinya stunting antar generasi, terutama ketika remaja memasuki masa prakonsepsi tanpa status gizi yang optimal.

Selain masalah kekurangan gizi, peningkatan prevalensi obesitas pada remaja juga menjadi perhatian serius akibat perubahan pola makan tinggi gula, garam, lemak, dan rendah aktivitas fisik. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa, tetapi juga memperkuat beban gizi ganda dalam keluarga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai gizi remaja, faktor determinan, dampak kesehatan, serta strategi pencegahan berbasis evidence menjadi sangat penting dalam praktik kebidanan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan Umum

Mahasiswa mampu memahami konsep gizi remaja dan keterkaitannya dengan status kesehatan, khususnya anemia, kekurangan energi kronik (KEK), obesitas, serta perannya dalam pencegahan stunting antar generasi berdasarkan bukti penelitian terkini dan praktik kebidanan berbasis evidence.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar kebutuhan gizi pada masa remaja sesuai tahapan pertumbuhan dan perkembangan.

2. Menganalisis faktor risiko anemia pada remaja, khususnya remaja putri, berdasarkan hasil penelitian terbaru.
3. Mengidentifikasi kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada remaja dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi.
4. Menjelaskan determinan obesitas pada remaja serta implikasinya terhadap penyakit metabolik dan kesehatan maternal di masa depan.
5. Menganalisis hubungan status gizi remaja dengan risiko stunting pada generasi berikutnya.
6. Mengevaluasi strategi pencegahan anemia, KEK, obesitas, dan stunting antar generasi melalui pendekatan promotif, preventif, dan intervensi kebidanan komunitas.
7. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terkini ke dalam asuhan kebidanan remaja dan prakonsepsi

Uraian materi dalam BAB ini tentang Definisi, konsep dasar/perubahan fisiologis, kebutuhan, tanda normal, tanda bahaya, asuhan kebidanan, KIE, dokumentasi tentang Gizi Remaja dan Status Kesehatan: Anemia, KEK, Obesitas, dan Pencegahan Stunting Antar Generasi.

A. Gizi Remaja

1. Definisi Gizi Remaja

Gizi remaja adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan zat gizi makro dan mikro pada individu usia 10–19 tahun untuk mendukung pertumbuhan cepat (*growth spurt*), maturasi seksual, perkembangan kognitif, dan kesiapan kesehatan reproduksi. Masa ini merupakan window of opportunity kedua setelah 1000 HPK, karena intervensi gizi pada remaja terbukti efektif memperbaiki status kesehatan saat dewasa dan mencegah stunting antar generasi. Bukti review terbaru menunjukkan bahwa kualitas gizi remaja sangat menentukan massa tulang puncak, cadangan zat besi, komposisi tubuh, serta outcome kehamilan di masa depan. (PMC)

Dalam kebidanan, fokus utama gizi remaja terutama pada remaja putri, karena status gizi saat prakonsepsi berhubungan langsung dengan anemia, KEK, infertilitas, BBLR, dan risiko stunting pada anak kelak. UNICEF Indonesia juga menekankan bahwa remaja Indonesia menghadapi triple burden of malnutrition: kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, dan obesitas. (UNICEF)

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Masa remaja merupakan fase pertumbuhan tercepat kedua setelah bayi, sehingga kebutuhan gizi meningkat tajam untuk menunjang perubahan fisik, hormonal, dan metabolik. Review terbaru menegaskan bahwa fase ini adalah

critical developmental window karena kebutuhan energi, protein, zat besi, kalsium, vitamin D, dan zinc meningkat lebih tinggi dibanding masa anak.

a. Percepatan pertumbuhan fisik

Pada masa pubertas terjadi growth spurt, yaitu percepatan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan.

1) Kenaikan tinggi badan pesat

Remaja mengalami peningkatan tinggi badan sekitar 15–25% dari tinggi dewasa, terutama pada awal pubertas. Pertumbuhan linear ini membutuhkan energi, protein, kalsium, fosfor, dan vitamin D yang cukup untuk mendukung pembentukan tulang.

2) Peningkatan massa otot pada laki-laki

Peningkatan hormon testosteron merangsang pembentukan massa otot dan kekuatan fisik, sehingga kebutuhan energi dan protein laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

3) Peningkatan lemak esensial pada perempuan

Pada remaja putri terjadi peningkatan lemak subkutan dan lemak esensial, terutama di payudara, panggul, dan paha, sebagai persiapan fungsi reproduksi normal.

4) Pembentukan massa tulang puncak

Sekitar 40–45% massa tulang dewasa terbentuk pada masa remaja, sehingga asupan kalsium, vitamin D, protein, dan aktivitas fisik sangat menentukan pencegahan osteopenia di masa depan.

b. Maturasi seksual

Perubahan pubertas juga ditandai oleh kematangan sistem reproduksi.

1) Menarche meningkatkan kebutuhan zat besi

Pada remaja putri, menstruasi pertama (*menarche*) menyebabkan kehilangan darah rutin setiap bulan, sehingga kebutuhan zat besi meningkat untuk pembentukan hemoglobin dan mencegah anemia.

2) Perkembangan payudara dan organ reproduksi

Estrogen merangsang perkembangan payudara, uterus, ovarium, dan perubahan bentuk panggul sebagai persiapan reproduksi.

3) Perubahan hormonal

Peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron memengaruhi metabolisme, komposisi tubuh, nafsu makan, serta pola distribusi lemak dan massa otot.

c. Perubahan metabolik

Selain pertumbuhan fisik, metabolisme tubuh juga berubah signifikan.

1) Peningkatan kebutuhan energi basal

Laju metabolisme basal meningkat karena pertumbuhan jaringan, aktivitas fisik, dan perubahan hormonal.

2) Peningkatan sintesis protein jaringan

Protein diperlukan lebih tinggi untuk pembentukan: Otot, enzim, hormon, jaringan reproduksi 'tulang

3) Sensitivitas insulin berubah pada pubertas

Pada masa pubertas terjadi perubahan sensitivitas insulin yang bersifat fisiologis. Bila disertai pola makan ultra-proses dan sedentary lifestyle, kondisi ini meningkatkan risiko obesitas dan resistensi insulin dini.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masa pubertas merupakan fase kritis terjadinya double burden, yaitu kurus/KEK dan obesitas pada populasi yang sama akibat perubahan hormonal dan pola makan ultra-proses. (PMC)

3. Kebutuhan Gizi Remaja

Berikut tabel ringkas kebutuhan gizi yang dapat langsung masuk buku:

Tabel 4.1 Kebutuhan Gizi Penting pada Remaja

Komponen	Fungsi Utama	Sumber	Risiko jika kurang
Energi	pertumbuhan dan aktivitas	nasi, umbi, roti	BB kurang, KEK
Protein	pembentukan jaringan	telur, ikan, tempe	hambatan pertumbuhan
Zat besi	pembentukan Hb	daging, hati, sayur hijau	anemia
Asam folat	pembelahan sel	sayur hijau, kacang	gangguan eritropoiesis
Kalsium	massa tulang puncak	susu, ikan teri	osteopenia dini
Vitamin D	absorpsi kalsium	sinar matahari, telur	gangguan tulang
Zinc	maturasi seksual	seafood, daging	pubertas terlambat

Hasil studi Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa asupan vitamin C memiliki hubungan signifikan dengan anemia pada remaja putri, karena meningkatkan absorpsi zat besi non-heme. (Journal MPCI)

4. Tanda Normal Status Gizi Remaja

Tabel 4.2 Tanda Normal

Aspek	Tanda Normal
Antropometri	IMT/U normal (-2 SD s.d +1 SD)
LILA	≥ 23,5 cm pada remaja putri akhir
Klinis umum	segar, aktif, tidak mudah lelah
Hemoglobin	≥ 12 g/dL
Menstruasi	siklus teratur, tidak berlebihan
Kulit dan rambut	tidak pucat, tidak kering
Nafsu makan	baik

5. Tanda Bahaya

Tabel 4.3 Tanda Bahaya Gizi Remaja

Masalah	Tanda Bahaya
Anemia	pucat, pusing, cepat lelah, Hb <12
KEK	LILA <23,5 cm, BB kurang
Obesitas	IMT/U > +1 SD, lingkar perut meningkat
Gangguan makan	diet ekstrem, muntah disengaja
Risiko stunting antar generasi	anemia + KEK + remaja putri pranikah

Penelitian 2025 menunjukkan anemia pada remaja putri masih sangat tinggi (71%) dan menjadi faktor risiko penting stunting antar generasi. (*Journal MPC*)

6. Asuhan Kebidanan pada Gizi Remaja

Asuhan kebidanan menggunakan pendekatan manajemen Varney:

a. Pengkajian

Pada tahap pengkajian, bidan melakukan pengumpulan data secara menyeluruh terkait kondisi remaja. Data dasar meliputi identitas, usia, status sekolah, dan fase pubertas, karena kebutuhan gizi sangat dipengaruhi tahap pertumbuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara pola makan 24 jam untuk menilai kecukupan energi, protein, zat besi, dan variasi konsumsi pangan. Pengkajian juga menitikberatkan pada frekuensi konsumsi fast food, minuman tinggi gula, serta kebiasaan melewatkan sarapan, karena penelitian terbaru menunjukkan pola makan ultra-proses berkaitan dengan anemia, obesitas, dan kualitas diet yang buruk pada remaja.

Aktivitas fisik dinilai melalui jenis olahraga, durasi, frekuensi, serta *screen time*, karena aktivitas sedang-berat terbukti berhubungan dengan kadar hemoglobin yang lebih baik dan kontrol berat badan yang optimal. Riwayat menstruasi juga harus dikaji secara rinci, meliputi usia menarche, keteraturan

siklus, lama haid, dan jumlah perdarahan, karena menstruasi berlebih meningkatkan risiko defisiensi zat besi. Selain itu dilakukan pemeriksaan BB, TB, IMT/U, dan LiLA untuk mendeteksi KEK atau obesitas, serta pemeriksaan Hb bila tersedia untuk skrining anemia dini.

b. Diagnosa Kebidanan

Contoh: Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan tidak adekuat, Risiko anemia pada remaja putri, Risiko obesitas akibat sedentary lifestyle

c. Intervensi

1) Intervensi Promotif

Intervensi promotif bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan gizi sehat remaja.

a) Edukasi gizi seimbang "Isi Piringku"

Remaja diberikan pemahaman komposisi makanan seimbang: $\frac{1}{2}$ piring sayur dan buah, $\frac{1}{4}$ protein, $\frac{1}{4}$ karbohidrat. Pendekatan edukasi visual berbasis sekolah terbukti meningkatkan kualitas diet remaja.

b) Peningkatan konsumsi protein hewani

Protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging dianjurkan setiap hari untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan Hb, dan mencegah KEK.

c) Promosi aktivitas fisik 60 menit/hari

Aktivitas aerobik ringan–sedang seperti jalan cepat, bersepeda, senam, atau olahraga sekolah minimal 60 menit/hari terbukti membantu kontrol IMT, sensitivitas insulin, dan kesehatan mental.

d) Promosi tidur cukup 8 jam

Tidur cukup penting untuk keseimbangan hormon pertumbuhan, leptin, ghrelin, dan metabolisme energi.

2) Intervensi Preventif

Intervensi preventif bertujuan mencegah timbulnya anemia, KEK, obesitas, dan gangguan reproduksi.

a) Suplementasi TTD mingguan

Pemberian tablet tambah darah 1 kali/minggu merupakan strategi utama pencegahan anemia pada remaja putri. Meta-analisis terbaru menunjukkan suplementasi Fe mingguan secara signifikan meningkatkan Hb dan menurunkan prevalensi anemia.

b) Kombinasi Fe + vitamin C

Vitamin C setelah makan atau saat minum TTD meningkatkan absorpsi Fe non-heme, terutama dari sayuran dan kacang-kacangan.

c) Pemantauan BB dan LiLA berkala

Pengukuran setiap bulan membantu deteksi dini KEK, penurunan BB, atau kenaikan IMT berlebih.

- d) Pembatasan fast food dan minuman manis
Pencegahan obesitas dilakukan dengan membatasi makanan ultra-proses, gula tambahan, dan minuman berpemanis.

Program berbasis sekolah terbukti menurunkan anemia, overweight, dan risiko stunting pada remaja. ([UNAIR E-Journal](#))

7. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

KIE pada remaja harus sederhana, praktis, dan mudah diterapkan dalam rutinitas sekolah.

A. KIE Promotif

Pesan promotif berfokus pada pembiasaan hidup sehat:

1. makan 3 kali utama + 2 snack sehat
2. konsumsi protein hewani setiap hari
3. perbanyak sayur dan buah
4. olahraga minimal 60 menit/hari
5. tidur cukup 8 jam
6. minum air putih cukup
7. bangun body image positif

B. KIE Preventif

Pesan preventif menekankan pencegahan faktor risiko:

1. minum TTD 1x/minggu
2. konsumsi buah sumber vitamin C setelah makan
3. hindari teh/kopi 1 jam setelah makan
4. kurangi minuman manis dan junk food
5. pantau berat badan setiap bulan
6. cek Hb bila sering lemas
7. catat siklus menstruasi

Penelitian Indonesia menunjukkan KIE berulang melalui sekolah, peer educator, dan media digital meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD dan perubahan perilaku makan secara signifikan.

B. Status Kesehatan Remaja

1. Definisi Anemia

Anemia pada remaja adalah kondisi kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari nilai normal sesuai usia dan jenis kelamin, sehingga kapasitas eritrosit membawa oksigen ke jaringan menurun. Pada remaja putri, anemia paling sering berkaitan dengan defisiensi zat besi akibat percean pertumbuhan,

menstruasi, dan asupan yang tidak adekuat. WHO menegaskan bahwa kelompok paling rentan adalah remaja putri yang sudah menstruasi, terutama di negara berkembang. ([World Health Organization](#))

Kajian sistematis terbaru menunjukkan anemia pada remaja berdampak pada kelelahan, penurunan konsentrasi belajar, gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas aktivitas fisik, dan peningkatan risiko komplikasi kehamilan di masa depan. ([ResearchGate](#)).

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Pada masa remaja, anemia sering terjadi karena adanya perubahan fisiologis yang meningkatkan kebutuhan zat besi dan zat pembentuk sel darah merah. Scoping review terbaru menegaskan bahwa anemia pada remaja putri sangat dipengaruhi oleh kombinasi growth spurt, menstruasi, kualitas diet, dan aktivitas fisik.

a. Growth spurt

Pada fase pubertas terjadi percepatan pertumbuhan tinggi badan dan massa tubuh, sehingga volume darah meningkat. Kondisi ini menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak eritrosit dan hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke jaringan. Akibatnya, kebutuhan zat besi (Fe) meningkat untuk sintesis hemoglobin. Bila asupan Fe tidak mencukupi, remaja mudah mengalami anemia, terutama pada fase pertumbuhan cepat. Studi terbaru menunjukkan bahwa kecukupan energi dan zat gizi makro berhubungan langsung dengan status Hb remaja.

b. Menarche dan menstruasi

Pada remaja putri, menarche dan menstruasi rutin menjadi faktor fisiologis utama peningkatan risiko anemia. Kehilangan darah setiap bulan menyebabkan hilangnya zat besi tubuh.

Risiko semakin tinggi bila:

- 1) menstruasi >7 hari
- 2) perdarahan banyak (menoragia)
- 3) siklus terlalu sering
- 4) tidak mengonsumsi TTD

WHO dan studi meta-analisis terbaru menegaskan bahwa kehilangan darah menstruasi merupakan penyebab dominan anemia defisiensi besi pada remaja putri.

c. Perubahan pola makan

Pada masa remaja sering terjadi perubahan perilaku makan, seperti: Diet ketat untuk body image, melewatkan sarapan, konsumsi *junk food*, rendah protein hewani, kurang buah sumber vitamin C. Pola makan seperti ini menyebabkan asupan Fe, protein, folat, dan vitamin B12 tidak adekuat sehingga proses eritropoiesis terganggu. Penelitian menunjukkan kualitas diet, keragaman pangan, dan konsumsi lauk hewani sangat berhubungan dengan kadar Hb.

d. Aktivitas tinggi

Remaja dengan aktivitas belajar dan olahraga tinggi memerlukan oksigen lebih banyak. Bila aktivitas fisik meningkat tanpa diimbangi asupan energi dan zat besi yang cukup, tubuh lebih cepat mengalami defisit Fe. Scoping review 2025 menunjukkan aktivitas fisik sedang–berat yang diimbangi diet baik berkorelasi positif dengan kadar hemoglobin dan ferritin. Scoping review terbaru pada remaja putri menunjukkan bahwa asupan protein, zat besi, vitamin C, folat, dan aktivitas fisik yang tidak seimbang berhubungan erat dengan anemia. (PMC)

3. Kebutuhan Nutrisi untuk Pencegahan Anemia

Tabel 4.4 Kebutuhan Nutrisi Utama

Nutrisi	Fungsi	Sumber	Risiko jika kurang
Zat besi	sintesis Hb	hati, daging, ikan, sayur hijau	anemia defisiensi Fe
Protein	pembentukan eritrosit	telur, ikan, tempe	Hb rendah
Vitamin C	absorpsi Fe	jeruk, jambu, pepaya	absorpsi Fe menurun
Asam folat	maturasi eritrosit	sayuran hijau	anemia megaloblastik
Vitamin B12	pembentukan sel darah merah	susu, daging	neuropati, anemia
Zinc	metabolisme sel	seafood, daging	pemulihan lambat

Penelitian 2025 menunjukkan bahwa kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (TTD), asupan protein hewani, dan vitamin C merupakan faktor paling berpengaruh terhadap peningkatan Hb pada remaja putri. (PubMed)

4. Tanda Normal

Tabel 4.5 Tanda Normal Status Hematologi Remaja

Parameter	Nilai Normal
Hemoglobin	≥ 12 g/dL
Konjungtiva	merah muda

Parameter	Nilai Normal
Aktivitas	aktif, tidak cepat lelah
Konsentrasi belajar	baik
Siklus haid	normal, tidak berlebihan
Nafsu makan	baik
CRT	<2 detik

5. Tanda Bahaya

Tabel 4.6 Tanda Bahaya Anemia

Tanda	Makna Klinis
Hb <12 g/dL	anemia
pucat konjungtiva	perfusi oksigen menurun
lemas dan cepat lelah	hipoksia jaringan
pusing/sinkop	perfusi serebral kurang
sesak saat aktivitas	anemia sedang–berat
takikardi	kompensasi jantung
menstruasi banyak	risiko kehilangan Fe

WHO menyebut gejala khas anemia meliputi fatigue, dizziness, headache, shortness of breath, dan cold extremities. ([World Health Organization](#))

6. Asuhan Kebidanan pada Remaja dengan Anemia

Asuhan kebidanan anemia pada remaja berfokus pada deteksi dini, peningkatan perilaku makan sehat, kepatuhan tablet tambah darah (TTD), dan pencegahan komplikasi kesehatan reproduksi di masa depan. Evidence terbaru menunjukkan bahwa kombinasi skrining Hb, edukasi gizi, suplementasi Fe, dan monitoring menstruasi merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kadar hemoglobin remaja putri.

a. Pengkajian

- 1) Pada tahap pengkajian, bidan perlu melakukan identifikasi dini gejala anemia dan faktor risikonya. Keluhan utama yang sering muncul meliputi lemas, pusing, cepat lelah, berkunang-kunang, serta sulit berkonsentrasi di sekolah, yang secara penelitian berhubungan dengan penurunan kadar Hb dan ferritin.
- 2) Selain gejala subjektif, bidan mengkaji pola makan sumber zat besi, terutama frekuensi konsumsi lauk hewani, sayuran hijau, dan buah sumber vitamin C. Penelitian 2025 menunjukkan kualitas diet, khususnya asupan

protein hewani dan vitamin C, berhubungan signifikan dengan peningkatan Hb pada remaja putri.

- 3) Kepatuhan konsumsi TTD mingguan juga harus dievaluasi karena menjadi faktor preventif utama anemia. Riwayat menstruasi perlu dikaji mencakup lama haid, banyaknya darah, dan keteraturan siklus, sebab menstruasi >7 hari meningkatkan kehilangan zat besi.
- 4) Pengkajian objektif meliputi BB, TB, LiLA, pemeriksaan Hb, dan tanda vital, untuk mendeteksi anemia yang disertai KEK atau tanda kompensasi kardiovaskular seperti takikardi.

b. Diagnosa Kebidanan

Contoh: Anemia ringan pada remaja putri berhubungan dengan kurang asupan zat besi, Risiko KEK dan anemia akibat pola makan tidak adekuat, Risiko stunting antar generasi pada remaja putri prakonsepsi

c. Intervensi

Intervensi kebidanan diarahkan untuk meningkatkan cadangan zat besi dan mencegah kekambuhan anemia.

1) Intervensi Promotif

Intervensi promotif menitikberatkan pada perubahan perilaku sehat dan peningkatan literasi gizi.

a) Edukasi makanan tinggi Fe + vitamin C

Remaja dianjurkan mengonsumsi hati, daging, ikan, telur, dan sayuran hijau yang dikombinasikan dengan buah kaya vitamin C seperti jeruk, jambu, atau pepaya untuk meningkatkan absorpsi Fe.

b) Anjuran protein hewani harian

Protein hewani penting untuk pembentukan hemoglobin dan eritrosit. Studi terbaru menunjukkan konsumsi protein hewani harian meningkatkan respons Hb lebih baik dibanding Fe non-heme saja.

c) Promosi sarapan dan istirahat cukup

Sarapan membantu kestabilan energi dan fungsi kognitif, sedangkan tidur cukup mendukung metabolisme serta pemulihan tubuh.

2) Intervensi Preventif

Intervensi preventif bertujuan mencegah anemia berlanjut dan komplikasi reproduksi.

a) Pemberian TTD 1 tablet/minggu

Suplementasi Fe mingguan terbukti efektif meningkatkan Hb dan menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri.

b) Hindari teh/kopi setelah makan

Edukasi untuk menghindari teh dan kopi minimal 1 jam setelah makan penting karena tanin menghambat absorpsi Fe.

c) Evaluasi Hb 1 bulan

Pemantauan berkala membantu menilai respons intervensi.

d) Kolaborasi bila Hb <10 g/dL

Bila Hb <10 g/dL, bidan perlu kolaborasi dengan dokter untuk evaluasi anemia sedang–berat atau kemungkinan penyebab lain.

Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa kombinasi suplementasi TTD, edukasi digital, dan monitoring Hb berkala memberikan hasil terbaik dalam peningkatan hemoglobin. Systematic review 2024 menunjukkan program sekolah + suplementasi Fe + edukasi gizi digital paling efektif meningkatkan Hb remaja. (UNAIR E-Journal)

7. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

KIE harus sederhana, aplikatif, dan sesuai kebiasaan remaja sekolah.

A. KIE Promotif

Pesan promotif bertujuan membangun kebiasaan sehat:

- a. makan sumber Fe heme setiap hari
- b. minum tablet dengan air jeruk/vitamin C
- c. sarapan sebelum sekolah
- d. istirahat cukup 8 jam
- e. konsumsi lauk hewani harian

B. KIE Preventif

Pesan preventif untuk mencegah kekambuhan:

- a. konsumsi TTD seminggu sekali
- b. hindari teh dan kopi 1 jam setelah makan
- c. catat siklus dan jumlah menstruasi
- d. kontrol Hb berkala
- e. segera periksa bila haid berlebihan atau lemas berat

Penelitian Indonesia menunjukkan bahwa KIE berulang melalui peer educator, video pendek, dan kelas sekolah meningkatkan kepatuhan TTD hingga >80% dan berpengaruh signifikan terhadap kadar Hb. Penelitian terbaru menemukan bahwa media edukasi digital, video pendek, dan peer educator sekolah meningkatkan kepatuhan TTD secara signifikan. (PubMed)

C. Status Kesehatan Remaja: KEK (Kekurangan Energi Kronik)

1. Definisi

Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada remaja adalah keadaan kurang gizi akibat asupan energi dan protein yang tidak adekuat dalam waktu lama, sehingga cadangan lemak dan massa otot tubuh menurun. Pada remaja putri, KEK menjadi masalah penting karena berkaitan langsung dengan gangguan pertumbuhan, keterlambatan maturasi seksual, anemia, gangguan kesehatan reproduksi, BBLR, dan stunting antar generasi. Penelitian terbaru di Sulawesi Selatan menunjukkan KEK pada remaja putri masih tinggi, terutama di wilayah lokus stunting. (Journal UIN Alauddin)

Secara operasional dalam pelayanan kebidanan, KEK pada remaja putri sering ditandai dengan LiLA < 23,5 cm, berat badan kurang, dan IMT/U di bawah normal. Edukasi pencegahan sejak masa remaja sangat penting untuk memutus siklus stunting antar generasi. (JAK)

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Masa remaja merupakan periode growth spurt yang ditandai peningkatan kebutuhan energi dan protein secara tajam. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam waktu lama, remaja berisiko mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronik) yang ditandai penurunan massa otot, cadangan lemak, dan LiLA <23,5 cm. Review terbaru menegaskan bahwa kekurangan energi kronik pada remaja berhubungan dengan gangguan pertumbuhan linear, keterlambatan pubertas, dan peningkatan risiko anemia.

a. Pertumbuhan fisik cepat

Pada pubertas terjadi percepatan pertumbuhan yang membutuhkan energi tinggi untuk peningkatan tinggi badan, sebagai hasil pertumbuhan tulang Panjang, penambahan massa otot, terutama pada remaja laki-laki, pembentukan jaringan lemak esensial, terutama pada perempuan untuk fungsi hormonal, pematangan tulang, termasuk pembentukan massa tulang puncak. Bila asupan energi dan protein tidak adekuat, tubuh menggunakan cadangan lemak dan protein otot sehingga berat badan turun dan pertumbuhan dapat terhambat. Evidence terbaru menunjukkan bahwa *undernutrition* pada masa pubertas berkaitan dengan short stature, delayed menarche, dan penurunan massa tulang.

b. Perubahan hormonal

Peningkatan hormon estrogen, progesteron, growth hormone, dan IGF-1 selama pubertas memerlukan kecukupan energi agar fungsi aksis hipotalamus–hipofisis–gonad berjalan normal. Perubahan ini meliputi: pembesaran organ reproduksi, pembentukan jaringan payudara, perubahan

metabolisme basal, peningkatan penyimpanan lemak esensial. Jika terjadi defisit energi kronik, kadar leptin menurun sehingga maturasi seksual dapat terlambat. Hal ini menjelaskan mengapa KEK pada remaja sering diikuti haid tidak teratur atau menarche terlambat.

c. Perubahan perilaku makan

Secara perilaku, remaja sering memiliki kebiasaan yang meningkatkan risiko KEK, seperti diet ekstrem untuk body image, *meal skipping* atau sering melewatkan makan, konsumsi *fast food* yang tinggi kalori tetapi rendah protein berkualitas, pola tidur buruk yang memengaruhi hormon lapar dan metabolisme.

Penelitian terbaru menunjukkan body image negatif dan pembatasan makan berhubungan erat dengan kejadian KEK pada remaja putri, terutama di lingkungan urban. Penelitian terbaru menunjukkan faktor dominan KEK adalah asupan energi rendah, protein kurang, body image negatif, dan kebiasaan makan tidak teratur. (Universitas Pahlawan Journal)

3. Kebutuhan Nutrisi pada Remaja dengan Risiko KEK

Tabel 4.7. Kebutuhan Nutrisi Utama Pencegahan KEK

Nutrisi	Fungsi	Sumber	Risiko jika kurang
Energi	pertumbuhan dan metabolisme	nasi, kentang, jagung	BB turun, lemah
Protein	pembentukan jaringan	telur, ikan, ayam, tempe	massa otot turun
Lemak sehat	cadangan energi	alpukat, kacang, ikan	cadangan energi rendah
Zat besi	pembentukan Hb	daging, hati	anemia + KEK
Kalsium	massa tulang	susu, ikan teri	pertumbuhan tulang terganggu
Zinc	maturasi seksual	seafood, daging	pubertas terlambat

Studi 2025 menunjukkan asupan energi dan protein yang tidak adekuat memiliki hubungan bermakna dengan kejadian KEK pada remaja putri. (Journal UIN Alauddin)

Review 2025 menegaskan bahwa remaja dengan risiko KEK membutuhkan peningkatan khusus pada energi, protein, zat besi, kalsium, zinc, dan vitamin D, karena zat gizi tersebut paling memengaruhi pertumbuhan, pubertas, dan kesiapan reproduksi. Secara praktik, pencegahan KEK lebih efektif bila dilakukan melalui makan utama 3 kali/hari, 2 snack tinggi energi protein, lauk hewani harian,

susu atau sumber kalsium, pemantauan LiLA dan berat badan bulanan. Pendekatan ini terbukti membantu memperbaiki cadangan energi dan menurunkan risiko stunting antar generasi.

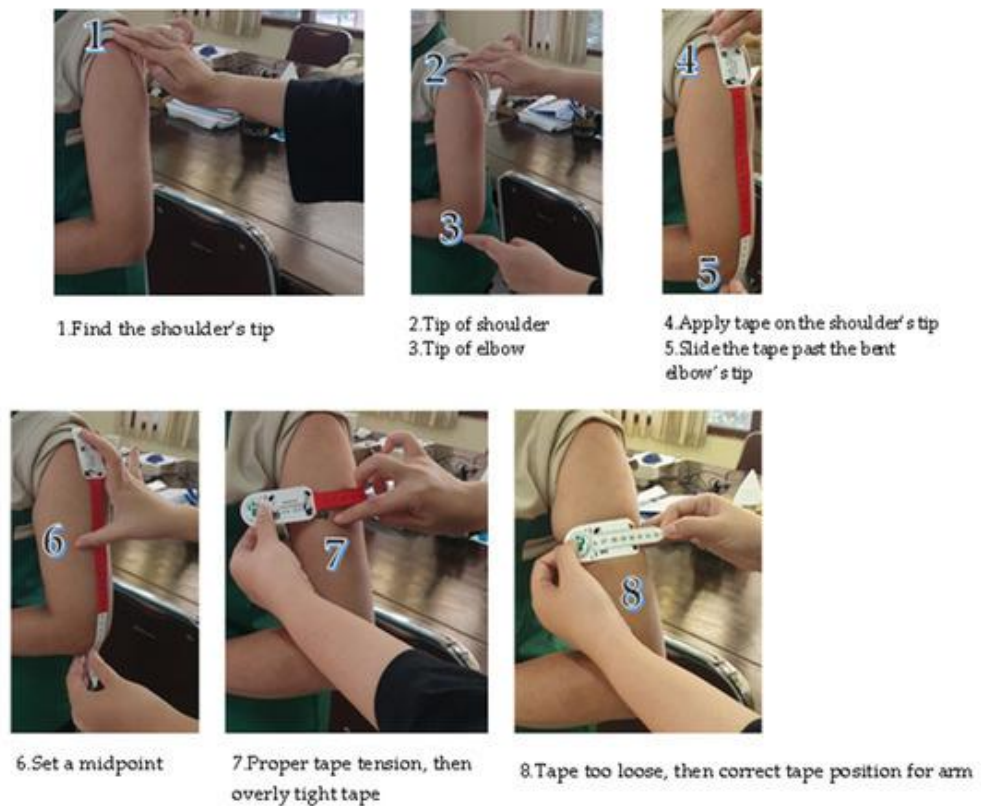
4. Tanda Normal

Tabel 4.8 Tanda Normal Status Gizi Remaja

Parameter	Nilai Normal
LiLA	$\geq 23,5$ cm
IMT/U	-2 SD sampai +1 SD
BB/TB	proporsional
Aktivitas	aktif, tidak cepat lelah
Menstruasi	teratur
Massa otot	cukup
Nafsu makan	baik



The MUAC Tape



Gambar 4.1 Pengukuran LiLA yang dapat digunakan dalam buku

5. Tanda Bahaya

Tabel 4.9 Tanda Bahaya KEK

Tanda	Makna Klinis
LiLA <23,5 cm	risiko KEK
BB tidak naik	asupan energi kurang
tubuh sangat kurus	kehilangan lemak subkutan
cepat lelah	cadangan energi rendah
pusing	sering terkait anemia
haid tidak teratur	gangguan hormonal
IMT/U <-2 SD	gizi kurang

Hasil penelitian menunjukkan KEK pada remaja berhubungan erat dengan anemia dan peningkatan risiko kehamilan berisiko di masa depan. (E-Jurnal Poltekkes Kemenkes Makassar)

6. Asuhan Kebidanan

Pendekatan menggunakan manajemen kebidanan Varney. Pada tahap pengkajian, bidan melakukan identifikasi faktor risiko gizi kurang dan perilaku makan yang tidak sehat. Data yang dikaji meliputi pola makan 24 jam dan frekuensi makan, untuk menilai kecukupan energi harian serta kebiasaan *meal skipping* yang sering menjadi penyebab utama KEK. Riwayat diet ketat dan persepsi body image perlu digali karena penelitian terbaru menunjukkan body dissatisfaction dan keinginan tubuh kurus sering mendorong pembatasan makan ekstrem pada remaja putri. Faktor ini sangat berkontribusi terhadap penurunan berat badan dan LiLA. Aktivitas fisik juga perlu dinilai, terutama bila remaja memiliki olahraga tinggi tanpa asupan adekuat. Pemeriksaan objektif mencakup BB, TB, IMT/U, dan LiLA, karena LiLA <23,5 cm merupakan indikator penting risiko KEK. Riwayat menstruasi dikaji untuk menilai dampak defisit energi terhadap keteraturan siklus, karena KEK sering disertai haid tidak teratur atau keterlambatan menarche.

a. Diagnosa Kebidanan

Contoh: Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan energi tidak adekuat, KEK pada remaja putri, Risiko anemia sekunder akibat KEK

b. Intervensi

Intervensi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi, pembentukan perilaku makan sehat, dan pemantauan pertumbuhan.

1) Intervensi Promotif

Intervensi promotif fokus pada pembentukan kebiasaan makan sehat dan citra tubuh positif.

a) Meningkatkan frekuensi makan 3 kali utama + 2 snack

Pendekatan ini membantu memenuhi kebutuhan energi tanpa membebani kapasitas lambung remaja. Penelitian menunjukkan pola makan bertahap lebih efektif meningkatkan berat badan dibanding porsi besar sekaligus.

b) Protein hewani minimal 1–2 porsi/hari

Telur, ikan, ayam, atau daging diperlukan untuk meningkatkan massa otot, memperbaiki pertumbuhan, dan mendukung hormon reproduksi.

c) Makanan padat energy

Snack sehat seperti susu, roti isi telur, kacang, alpukat, atau smoothies tinggi kalori-protein dianjurkan untuk meningkatkan cadangan energi.

d) Konseling body image positif

Edukasi tentang tubuh sehat dan bahaya diet ekstrem penting untuk mencegah pembatasan makan berulang.

2) Intervensi Preventif

Intervensi preventif bertujuan mencegah KEK berlanjut menjadi gangguan reproduksi atau anemia.

a) Suplementasi Fe bila ada anemia

KEK sering disertai anemia, sehingga suplementasi Fe diberikan sesuai hasil Hb.

b) Monitoring BB dan LiLA tiap bulan

Pemantauan berkala penting untuk menilai keberhasilan intervensi dan mencegah penurunan status gizi lebih lanjut.

c) Kolaborasi ahli gizi

Bila LiLA tetap rendah atau peningkatan berat badan lambat, bidan perlu berkolaborasi dengan ahli gizi untuk pengaturan menu individual.

Evidence terbaru menunjukkan intervensi berbasis sekolah dan keluarga yang menggabungkan snack protein, edukasi diet, dan konseling citra tubuh efektif meningkatkan LiLA dan berat badan remaja putri. Penelitian intervensi pendidikan gizi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan perilaku makan secara signifikan menurunkan risiko KEK remaja. (JAK)

7. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

KIE harus menekankan pembiasaan makan teratur dan kesiapan gizi prakonsepsi.

A. KIE Promotif

a. Makan teratur 3 kali sehari

- b. Jangan melewatkan sarapan
- c. Konsumsi lauk hewani setiap hari
- d. Tambah snack sehat tinggi kalori-protein
- e. Minum susu atau produk olahannya
- f. Bangun body image positif

B. KIE Preventif

Pesan preventif untuk mencegah KEK berlanjut:

- a. hindari diet ekstrem
- b. pantau LiLA dan berat badan tiap bulan
- c. segera periksa bila haid tidak teratur
- d. konsumsi TTD bila disertai anemia
- e. persiapkan status gizi sebelum pranikah

Metode KIE yang Efektif

Penelitian terbaru menunjukkan KIE lebih efektif bila menggunakan pendekatan multiple kelas remaja sekolah, konseling individu, peer educator, media digital sekolah, pemantauan grup WhatsApp/kelas daring. Metode ini terbukti meningkatkan kepatuhan makan, self-efficacy, dan persepsi body image sehat pada remaja.

D. Status Kesehatan Remaja: Obesitas

1. Definisi

Obesitas pada remaja adalah kondisi penumpukan lemak tubuh berlebihan yang berdampak pada kesehatan, ditandai oleh indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) di atas standar normal. WHO mendefinisikan obesitas sebagai penyakit kronis relapsing yang dipengaruhi interaksi kompleks antara genetik, neurobiologi, perilaku makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan sistem pangan modern. Data WHO terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 390 juta anak dan remaja usia 5–19 tahun mengalami overweight, termasuk 160 juta dengan obesitas pada tahun 2022. ([World Health Organization](#)). Pada remaja, obesitas menjadi perhatian kebidanan karena berkaitan dengan gangguan pubertas, oligomenorea, PCOS, hipertensi, resistensi insulin, dan peningkatan risiko obesitas maternal di masa prakonsepsi, yang dapat berkontribusi pada stunting antar generasi melalui jalur metabolik ibu. UNICEF juga menempatkan obesitas sebagai bagian dari triple burden of malnutrition di Indonesia. ([UNICEF](#))

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Secara fisiologis, obesitas pada remaja terjadi akibat ketidakseimbangan energi kronis, yaitu asupan energi yang terus-menerus melebihi pengeluaran energi. Kondisi ini menyebabkan penumpukan lemak tubuh, gangguan

metabolik, serta perubahan hormonal yang berdampak pada kesehatan reproduksi. Review terbaru menegaskan bahwa obesitas remaja merupakan faktor utama terjadinya resistensi insulin, sindrom metabolik, dan PCOS pada remaja putri.

a. Perubahan metabolik

Pada obesitas, terjadi peningkatan jaringan adiposa yang disertai hipertrofi (pembesaran) dan hiperplasia (penambahan jumlah) sel lemak. Jaringan adiposa berlebih tidak hanya menjadi cadangan energi, tetapi juga bertindak sebagai organ endokrin yang menghasilkan adipokin proinflamasi. Akibatnya muncul resistensi insulin dini, peningkatan kadar trigliserida, peningkatan LDL, penurunan sensitivitas metabolik. Bukti penelitian 2025 menunjukkan bahwa resistensi insulin pada remaja obesitas dapat muncul sejak pubertas awal dan menjadi pintu masuk gangguan ovulasi serta diabetes tipe 2 di masa depan.

b. Perubahan hormonal pubertas

Pada masa pubertas, obesitas memperberat perubahan hormonal fisiologis. Kadar leptin meningkat seiring bertambahnya jaringan lemak, namun sering disertai resistensi leptin sehingga regulasi nafsu makan terganggu.

Selain itu, pada pubertas memang terjadi penurunan sensitivitas insulin secara fisiologis, dan obesitas akan memperburuk kondisi ini menjadi hiperinsulinemia. Pada remaja putri, hiperinsulinemia merangsang peningkatan produksi androgen ovarium sehingga dapat muncul hiperandrogen, jerawat, hirsutisme, gangguan ovulasi, risiko PCOS. Review terbaru menunjukkan hubungan obesitas–resistensi insulin–hiperandrogen pada remaja putri bersifat dua arah dan menjadi mekanisme utama PCOS usia remaja.

c. Perubahan reproduksi

Obesitas pada remaja juga memengaruhi fungsi reproduksi. Peningkatan jaringan adiposa mempercepat aromatisasi androgen menjadi estrogen sehingga dapat menyebabkan menarche lebih dini. Dalam jangka lanjut dapat terjadi: siklus haid memanjang, oligomenorea, anovulasi, gangguan pematangan folikel, infertilitas di masa depan. Penelitian longitudinal menunjukkan obesitas pada usia pubertas berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan ovulasi dan infertilitas pada usia dewasa muda.

Secara klinis, perubahan ini penting dalam kebidanan karena obesitas remaja dapat menjadi faktor risiko PCOS, infertilitas, komplikasi kehamilan, dan stunting antar generasi melalui gangguan kesehatan prakonsepsi. Kajian klinis terbaru menunjukkan obesitas remaja berhubungan dengan hipertensi, fatty

liver, sleep apnea, gangguan muskuloskeletal, serta gangguan psikologis dan body image. ([ResearchGate](#))

3. Kebutuhan Nutrisi dan Aktivitas

Pada remaja obesitas, kebutuhan bukan menurunkan makan secara ekstrem, tetapi mengatur kualitas energi, protein, serat, dan aktivitas fisik.

Tabel 4.10. Kebutuhan Pencegahan dan Tata Laksana Obesitas

Komponen	Prinsip	Sumber	Manfaat
Energi	defisit ringan bertahap	porsi terukur	turunkan BB aman
Protein	cukup tinggi	telur, ikan, ayam	pertahankan massa otot
Serat	tinggi	buah, sayur, oat	kenyang lebih lama
Lemak sehat	cukup	alpukat, kacang	metabolik sehat
Air	2–2,5 L/hari	air putih	kontrol nafsu makan
Aktivitas	60 menit/hari	jalan cepat, olahraga	bakar energi

Hasil penelitian 2024 menunjukkan kombinasi edukasi diet seimbang dan aktivitas fisik berbasis sekolah paling efektif menurunkan IMT remaja obesitas. ([Jurnal Hospital Science](#))

4. Tanda Normal

Tabel 4.11 Tanda Normal Status Metabolik Remaja

Parameter	Nilai Normal
IMT/U	-2 SD sampai +1 SD
Lingkar perut	sesuai usia dan jenis kelamin
Tekanan darah	normal usia remaja
Siklus haid	teratur
Aktivitas	aktif ≥ 60 menit/hari
GDS	normal
Body image	positif

5. Tanda Bahaya

Tabel 4.12. Tanda Bahaya Obesitas

Tanda	Makna Klinis
IMT/U > +1 SD	overweight
IMT/U > +2 SD	obesitas
lingkar perut meningkat	obesitas sentral

Tanda	Makna Klinis
akantosis nigricans	resistensi insulin
TD meningkat	risiko hipertensi
haid >35 hari	risiko PCOS
mudah lelah/sesak	intoleransi aktivitas
sleep disturbance	sleep apnea

Komplikasi utama yang banyak ditemukan pada remaja obesitas adalah hipertensi, diabetes tipe 2, fatty liver, PCOS, dan gangguan psikososial. ([ResearchGate](#))

6. Asuhan Kebidanan

a. Pengkajian

Pada tahap pengkajian, bidan melakukan skrining faktor risiko obesitas dan komplikasinya secara menyeluruh. Pengkajian dimulai dari pola makan 24 jam, termasuk konsumsi *fast food*, gorengan, dan minuman tinggi gula, karena penelitian terbaru menunjukkan konsumsi gula tambahan dan makanan ultra-proses berhubungan kuat dengan peningkatan IMT remaja. Selain itu, perlu dikaji screen time dan sedentary behavior, seperti penggunaan gadget >2 jam/hari, yang terbukti berkorelasi dengan obesitas dan resistensi insulin. Aktivitas fisik dinilai dari frekuensi dan durasi olahraga, karena kurangnya aktivitas merupakan faktor utama ketidakseimbangan energi.

Riwayat keluarga diabetes mellitus dan obesitas penting untuk mengidentifikasi risiko genetik dan metabolik. Pemeriksaan objektif meliputi BB, TB, IMT/U, lingkaran perut, dan tekanan darah, untuk mendeteksi obesitas sentral dan sindrom metabolik. Pengkajian juga mencakup siklus menstruasi, karena obesitas pada remaja putri sering berkaitan dengan gangguan ovulasi dan risiko PCOS. Studi terbaru menunjukkan bahwa kombinasi obesitas, resistensi insulin, dan gangguan haid merupakan indikator awal gangguan reproduksi remaja.

b. Diagnosa Kebidanan

Contoh: Obesitas pada remaja putri berhubungan dengan asupan energi berlebih dan kurang aktivitas, Risiko hipertensi terkait obesitas, Gangguan pola menstruasi terkait obesitas

c. Intervensi

1) Intervensi Promotif

Intervensi promotif bertujuan membentuk perilaku hidup sehat jangka panjang:

a) Modifikasi pola makan “Isi Piringku”

Edukasi komposisi makan seimbang ($\frac{1}{2}$ sayur-buah, $\frac{1}{4}$ protein, $\frac{1}{4}$ karbohidrat) terbukti meningkatkan kualitas diet dan menurunkan asupan energi berlebih.

b) Peningkatan aktivitas fisik ≥ 60 menit/hari

Aktivitas aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, atau olahraga sekolah membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan lemak tubuh.

c) Konseling body image positif

Pendekatan ini penting untuk mencegah diet ekstrem dan gangguan makan, yang sering terjadi pada remaja obesitas.

2) Intervensi Preventif

Intervensi preventif bertujuan menurunkan risiko komplikasi metabolik dan reproduksi:

a) Pembatasan gula, gorengan, dan fast food

Pengurangan makanan ultra-proses terbukti menurunkan IMT dan lingkar perut secara signifikan.

b) Target penurunan berat badan bertahap (0,25–0,5 kg/minggu)

Penurunan bertahap lebih aman dan berkelanjutan dibanding diet cepat.

c) Monitoring tekanan darah dan siklus haid

Penting untuk deteksi dini hipertensi dan gangguan ovulasi/PCOS.

d) Kolaborasi dengan ahli gizi dan dokter

Dilakukan bila terdapat komorbid seperti hipertensi, prediabetes, atau gangguan haid.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi kombinasi diet, aktivitas fisik, dan dukungan perilaku memberikan hasil terbaik dalam menurunkan IMT dan memperbaiki profil metabolik remaja. Laporan asuhan kebidanan terbaru menunjukkan pendekatan diet sehat, aktivitas fisik, dan konseling psikososial efektif memperbaiki IMT dan siklus menstruasi remaja obesitas.

7. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

A. KIE Promotif

Pesan promotif untuk membangun kebiasaan sehat:

- Makan teratur 3 kali + 2 snack sehat
- Tambah buah dan sayur setiap makan
- Olahraga minimal 60 menit/hari
- Tidur cukup 8 jam
- Bangun body image positif

B. KIE Preventif

Pesan preventif untuk mengurangi faktor risiko:

- a. Kurangi minuman manis dan junk food
- b. Batasi screen time >2 jam/hari
- c. Pantau berat badan dan lingkar perut
- d. Hindari diet ekstrem
- e. Periksa bila haid tidak teratur

Metode KIE yang Efektif Berdasarkan penelitian terbaru, pendekatan KIE paling efektif adalah: kelas remaja berbasis sekolah, peer educator (teman sebaya), aplikasi digital untuk tracking makan dan aktivitas, edukasi keluarga (parental involvement). Pendekatan multi-komponen ini terbukti meningkatkan kepatuhan perubahan gaya hidup dan menurunkan risiko obesitas jangka panjang.

E. Status Kesehatan Remaja: Pencegahan Stunting Antar Generasi

1. Definisi

Pencegahan stunting antar generasi adalah serangkaian upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dimulai sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga 1000 HPK, untuk memutus siklus malnutrisi yang diwariskan dari ibu ke anak. Pada konteks kebidanan, fokus utama adalah remaja putri sebagai calon ibu, karena status gizi dan kesehatan reproduksi pada fase ini sangat menentukan pertumbuhan janin dan tinggi badan anak di masa depan.

Penelitian intervensi terbaru menunjukkan bahwa edukasi gizi seimbang, pencegahan anemia, penundaan usia nikah, dan peningkatan kesiapan prakonsepsi secara signifikan meningkatkan pengetahuan serta perilaku pencegahan stunting pada remaja putri.

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Stunting antar generasi merupakan siklus malnutrisi yang berulang dari remaja putri hingga generasi berikutnya. Siklus ini biasanya dimulai dari remaja anemia atau KEK, yang kemudian berlanjut menjadi calon ibu dengan status gizi kurang, tinggi badan pendek, dan berisiko mengalami kehamilan dengan gangguan pertumbuhan janin. Bukti systematic review terbaru menunjukkan bahwa status gizi prakonsepsi dan suplementasi sebelum hamil berperan penting meningkatkan hemoglobin ibu dan menurunkan risiko gangguan pertumbuhan intrauterin.

Alur siklusnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
remaja putri anemia/KEK → ibu pendek → kehamilan usia dini → IUGR → BBLR

→ bayi gagal tumbuh → balita stunting → remaja pendek → menjadi ibu pendek kembali.

Review terbaru juga menegaskan bahwa kehamilan remaja meningkatkan risiko undernutrition pada anak, sehingga intervensi harus dimulai sejak masa remaja untuk memutus siklus tersebut.

a. Fase Remaja

Fase remaja merupakan titik awal yang sangat menentukan. Pada masa growth spurt, kebutuhan energi, protein, zat besi, folat, dan zinc meningkat tajam untuk mendukung pertumbuhan linear, pembentukan massa tulang, dan maturasi reproduksi. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, remaja berisiko mengalami anemia dan KEK, yang menurunkan kualitas kesehatan prakonsepsi. Growth spurt membutuhkan energi tinggi untuk pembentukan jaringan baru. Anemia menurunkan oksigenasi jaringan, sehingga pertumbuhan dan fungsi ovarium terganggu. KEK menurunkan cadangan nutrisi, termasuk lemak esensial, protein, dan mikronutrien

Evidence terbaru menunjukkan anemia pada anak dan remaja memiliki hubungan bermakna dengan stunting, dengan risiko lebih dari dua kali lipat pada populasi negara berkembang.

b. Fase Prakonsepsi

Fase prakonsepsi adalah jendela penting untuk memutus siklus stunting. Kecukupan folat, zat besi, zinc, protein, dan status IMT normal sangat menentukan kualitas ovum, implantasi, dan pertumbuhan awal embrio. Status folat, Fe, dan zinc menentukan kualitas ovum serta pembelahan sel awal. IMT rendah meningkatkan risiko BBLR, karena cadangan energi ibu tidak cukup untuk mendukung perkembangan janin. Meta-analisis 2025 menunjukkan bahwa suplementasi gizi sejak prakonsepsi meningkatkan kadar Hb ibu sebesar 0,30 g/dL, yang sangat penting untuk mencegah anemia kehamilan.

c. Fase Kehamilan

Pada fase kehamilan, masalah gizi ibu akan langsung memengaruhi pertumbuhan janin. malnutrisi ibu → IUGR, karena suplai energi dan protein ke plasenta berkurang. anemia → hipoksia janin, sehingga pertumbuhan sel janin terhambat. hipertensi dan infeksi memperberat, melalui gangguan perfusi uteroplasenta dan inflamasi kronik

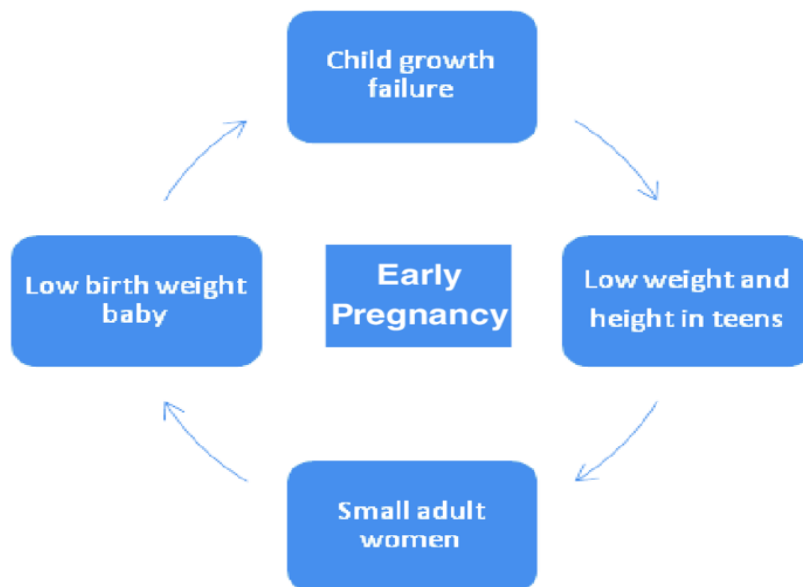
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anemia maternal, malnutrisi, dan jarak kehamilan yang tidak ideal merupakan determinan kuat stunting pada anak. Secara fisiologis, bila kondisi ini berlanjut hingga persalinan, bayi berisiko lahir dengan BBLR atau panjang badan lahir rendah, yang menjadi pintu awal stunting pada 1000 HPK.

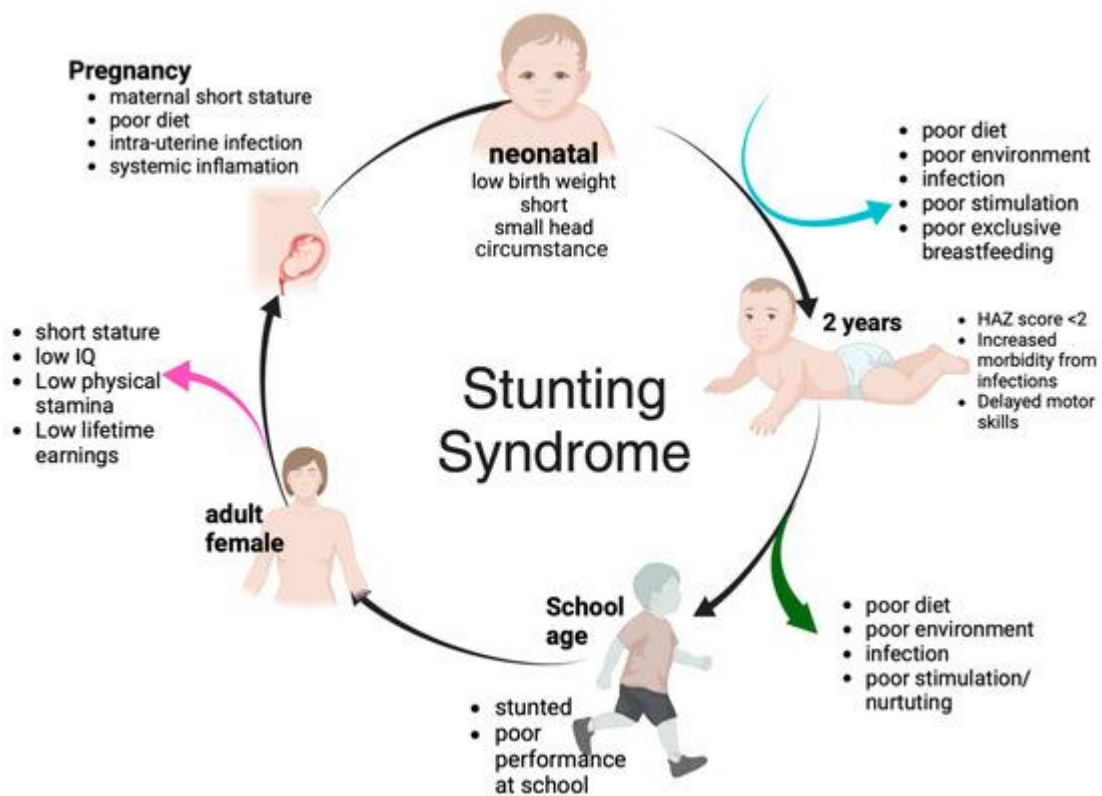
Inti Klinis Kebidanan Dalam praktik kebidanan, konsep ini menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak dimulai saat bayi lahir, tetapi sejak remaja putri, fase prakonsepsi, dan kehamilan awal. Fokus utama bidan adalah:

- 1) Pencegahan anemia dan KEK remaja
- 2) Persiapan prakonsepsi sehat
- 3) Pencegahan kehamilan usia dini
- 4) Pemantauan IMT, lila, dan Hb
- 5) Edukasi gizi serta usia ideal menikah

Pendekatan *life cycle* ini terbukti paling efektif untuk memutus stunting antar generasi.

Gambar 4.2. Siklus Stunting Antar Generasi





UNICEF menegaskan bahwa anak stunting berisiko menjadi orang dewasa pendek dan mewariskan siklus malnutrisi pada generasi berikutnya.

3. Kebutuhan Nutrisi dan Kesehatan Pencegahan

Tabel 4.13. Kebutuhan Pencegahan Stunting Antar Generasi

Komponen	Fungsi	Sumber	Dampak jika kurang
Energi	growth spurt dan cadangan kehamilan	nasi, kentang, jagung	KEK
Protein	pertumbuhan jaringan dan janin	telur, ikan, ayam	IUGR
Zat besi	Hb dan oksigenasi janin	hati, daging	anemia, BBLR
Asam folat	pembelahan sel	sayur hijau	gangguan janin
Kalsium	pertumbuhan tulang	susu, ikan teri	TB ibu pendek
Zinc	pertumbuhan linear	seafood	stunting janin
Kesehatan reproduksi	kesiapan pranikah	ANC/prakonsepsi	kehamilan risiko

Hasil penelitian pendidikan gizi remaja sehat menunjukkan peningkatan pengetahuan kategori baik hingga 60% setelah pelatihan, yang berkontribusi pada kesiapan pencegahan stunting. (jakk.candle.or.id)

4. Tanda Normal

Tabel 4.14. Tanda Normal Risiko Rendah Stunting Antar Generasi

Parameter	Tanda Normal
Hb	≥ 12 g/dL
LiLA	≥ 23,5 cm
IMT/U	normal
Tinggi badan	sesuai umur
Siklus haid	teratur
Pengetahuan gizi	baik
Usia menikah	≥ 21 tahun
Kesiapan prakonsepsi	baik

5. Tanda Bahaya

Tabel 4.15 Tanda Bahaya Risiko Stunting Antar Generasi

Tanda	Risiko
Hb < 12 g/dL	anemia
LiLA < 23,5 cm	KEK
TB < 145 cm	risiko panggul sempit + bayi kecil
menikah dini	kehamilan remaja
IMT rendah	IUGR
riwayat BBLR keluarga	siklus berulang
pola makan buruk	malnutrisi kronis

Studi terbaru menunjukkan nikah dini dan kehamilan remaja merupakan faktor penting yang memperkuat jalur stunting antar generasi. ([CIB Institute Journal](#))

6. Asuhan Kebidanan

a. Pengkajian

Pada tahap pengkajian, bidan melakukan skrining status gizi dan faktor risiko reproduksi sejak masa remaja. Pengkajian meliputi:

- 1) Status anemia, KEK, dan obesitas, karena ketiganya berhubungan langsung dengan risiko BBLR dan stunting

- 2) Pola makan dan body image, untuk mendeteksi diet ekstrem, rendah protein hewani, atau perilaku makan tidak sehat
- 3) Riwayat menstruasi, termasuk siklus tidak teratur yang dapat menandakan masalah gizi atau hormonal
- 4) Usia menikah dan rencana kehamilan, sebagai dasar konseling pendewasaan usia perkawinan
- 5) Pengetahuan prakonsepsi, meliputi TTD, protein hewani, folat, dan usia ideal hamil
- 6) Pemeriksaan objektif: BB, TB, lila, Hb, IMT
- 7) Riwayat keluarga stunting, untuk mengidentifikasi faktor genetik dan lingkungan

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa skrining Hb dan LiLA pada remaja putri di wilayah lokus stunting efektif sebagai deteksi dini risiko generasi stunting.

b. Diagnosa Kebidanan

Contoh: Risiko stunting antar generasi pada remaja putri, Risiko kehamilan usia dini, Risiko anemia dan KEK prakonsepsi.

c. Intervensi

1) Intervensi Promotif

Intervensi promotif diarahkan pada pembentukan status gizi prakonsepsi yang optimal.

a) Edukasi protein hewani harian

Konsumsi telur, ikan, ayam, hati, dan susu terbukti meningkatkan cadangan protein, zat besi, zinc, dan kualitas ovum.

b) Edukasi prakonsepsi sehat

Meliputi kesiapan gizi, kesehatan reproduksi, usia ideal hamil, dan pencegahan kehamilan tidak direncanakan.

c) Kelas remaja anti stunting

Evidence menunjukkan kelas remaja berbasis sekolah/posyandu efektif meningkatkan literasi gizi, anemia, dan kesiapan calon ibu.

d) Konseling pendewasaan usia perkawinan

Menunda kehamilan hingga usia ideal membantu menurunkan risiko BBLR dan stunting.

2) Intervensi Preventif

Intervensi preventif bertujuan mencegah berlanjutnya faktor risiko ke fase prakonsepsi dan kehamilan.

a) Suplementasi TTD mingguan

Tablet tambah darah terbukti efektif mencegah anemia dan memperbaiki Hb sebelum kehamilan.

b) Pemantauan LiLA dan Hb berkala

Monitoring bulanan membantu memastikan remaja masuk fase pranikah dengan status gizi optimal.

c) Rujukan bila KEK berat atau Hb rendah

Kolaborasi dengan dokter/ahli gizi dilakukan bila LiLA <23,5 cm atau Hb <10 g/dL.

Program peer group dan skrining anemia di daerah lokus stunting terbukti meningkatkan kesadaran remaja dan kepatuhan intervensi gizi. Program sekolah terbukti meningkatkan pengetahuan anti stunting melalui edukasi gizi dan pencegahan nikah dini. (*CIB Institute Journal*)

7. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

A. KIE Promotif

Pesan promotif untuk mempersiapkan generasi sehat:

- cegah anemia sejak remaja
- makan protein hewani setiap hari
- persiapkan prakonsepsi sehat
- ikuti kelas remaja posyandu
- bangun body image positif dan status gizi ideal

B. KIE Preventif

Pesan preventif untuk memutus siklus stunting:

- Konsumsi TTD mingguan
- Hindari diet ekstrem
- Tunda kehamilan sampai usia ideal
- Pantau lila, Hb, dan IMT
- Segera periksa bila haid tidak teratur atau berat badan turun

Metode KIE yang Efektif Berdasarkan penelitian terbaru, metode yang paling efektif: peer educator, kelas remaja, media digital sekolah, program sekolah anti stunting, konseling keluarga. Pendekatan kombinasi sekolah–keluarga terbukti meningkatkan perubahan perilaku gizi dan kesiapan prakonsepsi remaja putri.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 15 tahun datang ke PMB diantar oleh ibunya. Hasil anamnesa mengeluh kepala sering pusing, badan lemas dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan TD 100/70 mmhg, N 78 x/menit, S 36°C, P 21 x/menit, konjungtiva pucat, Hb 9 mg/dl.

- Apa masalah utama pada kasus di atas?
- Data apa saja yang mendukung analisis Anda?

- c. Berdasarkan konsep 3P, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
- d. Tanda bahaya apa yang mulai muncul perempuan tersebut?
- e. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
- f. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
- g. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan?

F. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pranikah dan prakonsepsi
3	Kasus	Anemia pada remaja
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke PMB diantar oleh ibunya. Hasil anamnesa mengeluh kepala sering pusing, mata berkunang kunang, badan lemas dan mudah Lelah dan susah berkonsentrasi . Hasil pemeriksaan TD 90/70 mmhg, N 78 x/menit, S 36°C, P 21 x/menit. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut.

No.	Komponen	Isi
		5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan konjungtiva, penguji memberikan data:- konjungtiva merah muda. 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan HB penguji memberikan data:- hasil pemeriksaan 8 gr/dl

No.	Komponen	Isi
		4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai seorang perempuan. PS tampak lelah, lemas. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Mba. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa Mba. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama mba? PS: Saya merasa lemas, mudah lelah Bu, Peserta: Apakah mba makan teratur terutama pagi hari?

No.	Komponen	Isi
		PS: tidak. Pagi jarang sarapan Peserta: Apakah mba suka minum tablet tambah darah saat haid? PS: Tidak suka minum tablet tambah darah.
10	Kebutuhan manikin	Tidak ada
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat pemeriksaan — 1 2. HB Set — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Termometer — 1 6. Sarung tangan bersih — 1 pasang 7. Tisu — 1 pack 8. Bengkok — 1
13	Penulis	
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.

No.	Komponen	Isi

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Pranikah dan prakonsepsi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat haid (lama haid, berapakali ganti pembalut)		
3. Riwayat makan dalam sehari dan makanan berprotein (telur, daging, tempe tahu dll)		
4. Riwayat minum tablet tambah darah		
5. Riwayat kegiatan sehari-hari		
6. Riwayat istirahat dalam sehari		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. menilai warna wajah		
d. Menilai konjungtiva		
e. Menilai warna kuku		
f. Melakukan pemeriksaan hemoglobin		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **11–15 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **6–10 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–5 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
3. Memberikan perhatian terhadap respons selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 (dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji:.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada anemia, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan pengkajian dan penanganan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada anemia, dengan tetap berpusat pada keselamatan serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang anemia, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi, membaca hasil laboratorium.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan prolonged, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal.	Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke PMB diantar oleh ibunya. Hasil anamnesa mengeluh kepala sering pusing, mata berkunang kunang, badan lemas dan mudah Lelah dan susah berkonsentrasi . Hasil pemeriksaan TD 90/70 mmhg,N 78 x/menit, S 36°C, P 21 x/menit.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu,	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi , membaca hasil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia
	bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, konjungtiva, pemeriksaan HB, serta melakukan tindakan awal.	lab, menyimpulkan keadaan anemia.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks gizi, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali kekurangan zat besi dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan kelelahan, jarang sarapan, tidak minum tablet tambah darah saat haid, mata berkunang kunang.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada pengkajian data yang ada.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca hasil lab, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal pengkajian, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus anemia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kAnemia pada remaja secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel. Portofolio pada Anemia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Kasus Anemia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Anemia remaja, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menilai kondisi, tanda bahaya, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani Anemia, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi, anemia dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian stabilisasi awal,.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Nn dengan anemia sedang,
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pengenalan anemia, pencegahan dan

Komponen	Deskripsi	Kasus Anemia, dan Tindakan Awal
	potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	komunikasi cepat dengan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali Anemia, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai pengkajian
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus anemia, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai keadaan, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengkaji, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat .
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Kesehatan Reproduksi Remaja: Anemia

Komponen	Deskripsi	Anemia ramaja
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang perempuan yang mengalami anemia.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, 157rofess rujukan, dan perkembangan kondisi setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan badan lemas, mata berkunang kunang, jarang sarapan, tidak minum tambah darahbsaat haid, konjungtiva merah muda dan HB 8 gr/dl. Dengan anemia dantindakan awal pemberian tablet Fe
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan dan hasil pemeriksaan..
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan	Dari kasus partus lama, mahasiswa belajar bahwa 157rofession, pengkajian, dan

Komponen	Deskripsi	Anemia ramaja
	kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep Anemia tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Kesehatan Reproduksi Remaja : Anemia

Komponen	Deskripsi	Anemia Remaja
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus anemia, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali anemia dapat menyebabkan perburukan kondisi.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah pengkajian, dapat berdampak pada keselamatan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah tumbuh kembang terganggu.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis anemia.

Komponen	Deskripsi	Anemia Remaja
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian dan pemeriksaan yang benar.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan lama, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Ringkasan

Anemia pada remaja merupakan masalah gizi yang paling sering terjadi, terutama pada remaja putri, dan berhubungan erat dengan growth spurt, menarche, pola makan rendah zat besi, serta kepatuhan tablet tambah darah (TTD). Evidence terbaru menunjukkan bahwa faktor paling berpengaruh terhadap peningkatan hemoglobin adalah konsumsi TTD mingguan, protein hewani harian, serta vitamin C yang membantu absorpsi Fe. Secara fisiologis, masa pubertas meningkatkan kebutuhan zat besi karena terjadi peningkatan volume darah, massa eritrosit, dan kehilangan Fe melalui menstruasi. Kondisi ini diperberat oleh kebiasaan diet ketat, melewatkan sarapan, konsumsi junk food, serta aktivitas tinggi tanpa asupan adekuat.

Asuhan kebidanan berfokus pada pendekatan promotif–preventif melalui skrining gejala (lemas, pusing, sulit konsentrasi), pengkajian pola makan sumber Fe, kepatuhan TTD, riwayat menstruasi, pemeriksaan BB, TB, LiLA, tanda vital, dan Hb. Intervensi utama meliputi pemberian TTD 1 tablet/minggu, edukasi makanan tinggi Fe dan vitamin C, anjuran protein hewani setiap hari, menghindari teh/kopi setelah makan, serta evaluasi Hb setelah 1 bulan. Bila Hb <10 g/dL diperlukan kolaborasi.

KIE yang efektif menekankan pesan sederhana: konsumsi TTD seminggu sekali, makan sumber Fe heme setiap hari, minum tablet dengan air jeruk, sarapan sebelum sekolah, mencatat siklus menstruasi, kontrol Hb berkala, dan istirahat cukup. Penelitian terbaru menunjukkan metode peer educator, kelas remaja sekolah, dan media digital meningkatkan kepatuhan TTD hingga lebih dari 80% sehingga efektif mencegah anemia, gangguan konsentrasi belajar, serta risiko stunting antar generasi.

Alur asuhan singkat

Remaja dengan keluhan lemas/pusing → skrining pola makan, TTD, menstruasi, Hb → identifikasi anemia/risiko → TTD + edukasi Fe, protein hewani, vitamin C → monitoring Hb 1 bulan → kolaborasi bila Hb <10 g/dL → KIE berkelanjutan untuk pencegahan stunting antar generasi.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Kesehatan Reproduksi Remaja : Anemia remaja

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Hb <10 g/dL	Anemia sedang–berat, risiko hipoksia jaringan dan gangguan belajar	Kolaborasi dokter, evaluasi penyebab, pertimbangkan Fe harian dan pemeriksaan lanjutan
Lemas berat, pusing, sinkop	Menunjukkan perfusi oksigen tidak adekuat	Istirahatkan, cek tanda vital, Hb segera, rujuk bila sinkop berulang
Takikardi, hipotensi, pucat berat	Kompensasi kardiovaskular akibat Hb rendah	Stabilisasi awal, monitor ketat, kolaborasi/rujuk
Menstruasi >7 hari / sangat banyak	Kehilangan Fe kronis, risiko anemia defisiensi besi	Konseling menstruasi, Hb ulang, kolaborasi bila menoragia
Tidak patuh TTD >1 bulan	Risiko Hb tidak meningkat dan anemia berulang	KIE intensif, peer educator, libatkan keluarga/sekolah
Diet ekstrem / meal skipping	Asupan Fe, protein, folat rendah	Konseling gizi dan body image positif
Hb tidak naik setelah 1 bulan	Curiga kepatuhan rendah, infeksi, talasemia, atau penyebab lain	Rujuk pemeriksaan ferritin/CBC dan evaluasi dokter
Sulit konsentrasi, nilai sekolah turun	Dampak anemia pada fungsi kognitif	Skrining Hb dan intervensi TTD + edukasi gizi

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Kesehatan Reproduksi remaja – Anemia Remaja

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian Anemia remaja	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan penyebab Anemia	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai hasil pengkajian	☐	☐	
5	Saya sudah bisa membaca hasil pemeriksaan HB	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab anemia	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya anemia	☐	☐	
8	Saya sudah bisa mengenali awal anemia	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan pencegahan yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal penanganan yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan penanganan dengan baik	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

- Brown, J. E., Isaacs, J. S., Krinke, U. B., Lechtenberg, E., Murtaugh, M. A., Sharbaugh, C., ... Wooldridge, N. H. (2023). *Nutrition through the life cycle* (8th ed.). Cengage Learning.
- Gibson, R. S. (2023). *Principles of nutritional assessment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri*. Kemenkes RI.
- Rahmatina, B., Sari, D. P., Wulandari, N., & Hapsari, A. (2025). Weekly iron supplementation, dietary protein, and vitamin C intake improve hemoglobin levels among adolescent girls: A school-based intervention study. *International Journal of Women's Health*, 17, 2891–2907. <https://doi.org/10.2147/IJWH.SXXXXX>
- UNICEF. (2024). *Adolescent nutrition: Iron deficiency and school-based interventions*. UNICEF.
- World Health Organization. (2024). *Accelerating anaemia reduction among adolescent girls and women of reproductive age: Policy brief*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2024). *Guideline on intermittent iron and folic acid supplementation in menstruating women and adolescent girls*. WHO.

BAB 5

KESEHATAN MENSTRUASI: SIKLUS, KELUHAN UMUM, GANGGUAN MENSTRUASI, DAN TATA LAKSANA AWAL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Uraian Materi

Menstruasi merupakan proses fisiologis alami yang terjadi pada perempuan sebagai bagian dari fungsi normal sistem reproduksi dan menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi, khususnya pada masa remaja. Secara biologis, menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan endometrium uterus yang keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi secara periodik sebagai akibat tidak terjadinya fertilisasi setelah proses ovulasi (Kabra & Fisher, 2022). Proses ini mencerminkan bahwa sistem reproduksi telah memasuki fase maturitas seksual, sehingga menstruasi sering dijadikan penanda kesiapan biologis tubuh perempuan untuk proses reproduksi (Grover, 2019). Pada remaja, menarke sebagai menstruasi pertama juga memiliki makna penting sebagai indikator perkembangan pubertas dan fungsi endokrin reproduksi yang mulai aktif.

Secara fisiologis, siklus menstruasi merupakan rangkaian perubahan yang kompleks dan terintegrasi antara sistem hormonal, ovarium, dan lapisan endometrium yang berlangsung secara berulang setiap bulan. Siklus ini pada umumnya memiliki rata-rata 28 hari, dengan rentang normal antara 21–35 hari, dan terdiri atas tiga fase utama, yaitu fase folikular, ovulasi, dan fase luteal (Carmine & Fisher, 2022). Pada fase folikular terjadi pematangan folikel ovarium yang dipengaruhi oleh hormon FSH, kemudian dilanjutkan dengan ovulasi akibat lonjakan hormon LH, dan diakhiri dengan fase luteal yang ditandai peningkatan progesteron untuk mempersiapkan endometrium terhadap kemungkinan implantasi (Salih et al., 2024). Apabila fertilisasi tidak terjadi, kadar hormon estrogen dan progesteron akan menurun sehingga menyebabkan peluruhan endometrium yang tampak sebagai menstruasi.

Dalam perspektif ilmu kesehatan terbaru, menstruasi tidak lagi dipandang hanya sebagai proses fisiologis sistem reproduksi, tetapi juga sebagai indikator status kesehatan umum perempuan. Oleh karena itu, menstruasi sering disebut sebagai “the fifth vital sign”, terutama pada remaja perempuan, karena pola siklus menstruasi dapat mencerminkan kondisi kesehatan secara menyeluruh, termasuk status nutrisi, keseimbangan hormonal, tingkat stres psikologis, aktivitas fisik yang berlebihan, serta kemungkinan adanya penyakit sistemik (Cheung, 2025). Perubahan siklus yang tidak normal, seperti siklus memanjang, perdarahan berlebihan, atau amenore, sering kali menjadi manifestasi awal gangguan kesehatan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Dalam konteks pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), konsep definisi menstruasi tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi harus diarahkan pada pencapaian CPL dan CPMK yang relevan. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep menstruasi secara ilmiah dan sistematis, mengaitkan proses menstruasi dengan kesehatan reproduksi remaja, mengidentifikasi variasi

fisiologis maupun penyimpangan patologis sejak dini, serta menggunakan pemahaman tersebut dalam pengambilan keputusan klinik pada asuhan kebidanan (Howlett et al., 2025). Dengan demikian, teori dasar ini mendukung pencapaian CPL pada aspek pengetahuan, keterampilan klinik, dan kemampuan clinical reasoning, yang sangat diperlukan dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

A. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Siklus menstruasi merupakan proses fisiologis yang dikendalikan oleh sumbu hipotalamus–hipofisis–ovarium (Hypothalamic–Pituitary–Ovarian axis / HPO axis) melalui mekanisme umpan balik hormonal yang kompleks. Sistem ini berperan penting dalam mengatur pematangan folikel, ovulasi, serta perubahan endometrium secara periodik (Kabra & Fisher, 2022). Keseimbangan kerja sumbu HPO sangat menentukan keteraturan siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi perempuan, terutama pada masa remaja yang masih berada dalam fase maturasi hormonal (Howlett et al., 2025).

1. Peran Hipotalamus

Hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengatur awal dalam siklus menstruasi dengan menghasilkan GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) secara pulsatif. Pola pelepasan GnRH yang teratur sangat penting karena akan merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) (Brookhart & Naroji, 2025). Frekuensi dan amplitudo pulsasi GnRH menentukan keseimbangan hormon reproduksi, sehingga gangguan pada pola ini dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur, termasuk amenore dan anovulasi.

2. Peran Hipofisis

Hipofisis anterior berperan sebagai mediator hormonal yang menerima rangsangan dari hipotalamus. Kelenjar ini mengeluarkan FSH dan LH yang memiliki fungsi spesifik dalam regulasi siklus menstruasi. FSH berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium, sedangkan LH berperan dalam memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum (Carmine & Fisher, 2022). Keseimbangan kedua hormon ini sangat penting dalam menentukan fase-fase siklus menstruasi.

3. Peran Ovarium

Ovarium merupakan organ target utama dari stimulasi FSH dan LH. Ovarium menghasilkan dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, yang berperan dalam perubahan lapisan endometrium dan memengaruhi berbagai gejala klinis selama siklus menstruasi (Salih et al., 2024). Estrogen dominan pada

fase proliferasi, sedangkan progesteron dominan pada fase sekretori. Kedua hormon ini juga memengaruhi mood, suhu tubuh, dan retensi cairan.

B. Fase Siklus Menstruasi

1. Fase Folikular (Hari 1–13)

Fase folikular dimulai sejak hari pertama menstruasi. Pada fase ini terjadi peningkatan kadar FSH yang merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Folikel yang berkembang akan meningkatkan produksi estrogen sehingga menyebabkan proliferasi endometrium dan penebalan lapisan uterus sebagai persiapan implantasi (Kabra & Fisher, 2022). Pada remaja, fase ini sering kali belum stabil karena maturasi sumbu HPO belum sempurna, sehingga variasi siklus masih dianggap fisiologis hingga 2–3 tahun setelah menarke (Adeyemi-Fowode, 2022).

2. Ovulasi (Hari ke-14)

Ovulasi ditandai dengan lonjakan LH (LH surge) yang menyebabkan pelepasan oosit matang dari ovarium. Fase ini merupakan indikator penting kesuburan karena menandai masa paling subur dalam siklus menstruasi (Grover, 2019). Pada kondisi tertentu, seperti stres berat atau gangguan hormonal, ovulasi dapat tidak terjadi sehingga menimbulkan siklus anovulatorik.

3. Fase Luteal (Hari 15–28)

Setelah ovulasi, folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Hormon ini berfungsi mempertahankan ketebalan endometrium, meningkatkan vaskularisasi, dan mempersiapkan implantasi embrio (Salih et al., 2024). Jika fertilisasi tidak terjadi, kadar progesteron menurun sehingga lapisan endometrium mengalami peluruhan dan terjadilah menstruasi.

C. Perubahan Fisiologis Lain yang Menyertai

Menstruasi tidak hanya berupa perdarahan, tetapi juga disertai perubahan fisiologis sistemik. Setelah ovulasi, terjadi peningkatan suhu basal tubuh akibat efek termogenik progesteron. Selain itu, terdapat perubahan lendir serviks yang menjadi lebih kental pada fase luteal, retensi cairan, perubahan mood, perubahan nafsu makan, serta fluktuasi metabolisme tubuh (Delanerolle et al., 2025). Pemahaman mengenai perubahan ini penting agar mahasiswa mampu menghubungkan perubahan hormonal dengan manifestasi klinis yang dialami remaja.

D. Kesehatan Menstruasi pada Remaja

Kesehatan menstruasi remaja harus dipahami secara holistik, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya.

1. Aspek Biologis

Aspek biologis meliputi status hormonal, status gizi, kebutuhan zat besi, aktivitas fisik, dan kualitas tidur. Kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko anemia akibat kehilangan darah selama menstruasi, terutama pada remaja dengan perdarahan menstruasi yang banyak (Calcaterra et al., 2024).

2. Aspek Psikologis

Stres emosional, tekanan akademik, dan kecemasan terbukti memengaruhi kestabilan sumbu HPO. Stres kronis dapat menyebabkan amenore, oligomenore, maupun siklus menstruasi yang tidak teratur (Aningsih et al., 2025).

3. Aspek Sosial dan Budaya

Norma budaya sangat memengaruhi persepsi remaja terhadap menstruasi, seperti rasa malu, stigma, mitos makanan, dan larangan aktivitas tertentu. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mampu memberikan edukasi yang sensitif budaya dan berbasis kebutuhan remaja (Liang et al., 2023).

E. Tanda Menstruasi Normal

Menstruasi normal ditandai dengan siklus 21–35 hari, durasi 3–7 hari, volume darah sekitar 30–80 ml, warna merah terang hingga cokelat, tanpa nyeri berat, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari (Carmine & Fisher, 2022). Pada remaja awal, variasi siklus masih dianggap normal hingga 2–3 tahun pascamenarke karena proses maturasi hormonal belum sepenuhnya stabil (Adeyemi-Fowode, 2022).

F. Keluhan Umum dan Patofisiologi

1. Dismenore Primer

Dismenore primer adalah nyeri menstruasi tanpa adanya kelainan organik. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan prostaglandin yang memicu kontraksi uterus berlebihan, vasokonstriksi, dan iskemia miometrium sehingga menimbulkan nyeri spasmodik (O'Brien & Bosak, 2025).

2. PMS (Premenstrual Syndrome)

PMS terjadi akibat fluktuasi estrogen dan progesteron yang memengaruhi neurotransmitter, terutama serotonin. Gejalanya meliputi mudah marah, cemas, nyeri payudara, perut kembung, dan sakit kepala (Salih et al., 2024).

3. Kelelahan dan Gangguan Mood

Fluktuasi hormonal selama siklus menstruasi juga dapat memengaruhi fungsi neurologis dan kesehatan mental, sehingga menyebabkan kelelahan, mudah lelah, dan perubahan mood (Delanerolle et al., 2025).

G. Gangguan Menstruasi

Gangguan menstruasi yang sering dijumpai meliputi amenore, oligomenore, polimenore, menoragia, abnormal uterine bleeding (AUB), dan dismenore sekunder. Penyebabnya dapat berupa imaturitas sumbu HPO, gangguan nutrisi, stres, PCOS, endometriosis, fibroid, hingga gangguan tiroid (Howlett et al., 2025). Kemampuan membedakan kondisi fisiologis dan patologis merupakan inti CPMK pada analisis kasus klinik.

H. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dimulai dari anamnesis yang meliputi pola siklus, durasi, jumlah darah, nyeri, riwayat stres, dan aktivitas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik untuk menilai tanda anemia, status gizi, IMT, dan tanda hiperandrogen. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan meliputi kadar Hb, pemeriksaan hormon reproduksi, USG pelvis, serta tes kehamilan bila diperlukan (Bannow, 2024).

I. Tata Laksana Awal

Tata laksana awal dapat dilakukan secara non-farmakologis melalui kompres hangat, olahraga ringan, relaksasi, sleep hygiene, dan edukasi diet. Secara farmakologis dapat diberikan NSAID untuk dismenore, suplemen Fe pada anemia, dan terapi hormonal bila terdapat indikasi klinis (Ganguly et al., 2025). Pendekatan terbaru juga menekankan self-management melalui menstrual tracking apps untuk memantau siklus dan gejala, yang sangat relevan dalam edukasi kesehatan remaja.

Aktivitas 2 — Knows How Mini-Case

Topik: Kesehatan Menstruasi Remaja: Identifikasi Keluhan, Gangguan, dan Tata Laksana Awal

Skenario Kasus (Mini-Case)

Seorang remaja perempuan usia 16 tahun, menarche pada usia 12 tahun, datang ke Puskesmas remaja mengeluh nyeri perut bagian bawah setiap kali menstruasi.

Hasil pengkajian awal:

1. Nyeri muncul 6–12 jam sebelum perdarahan dan berlangsung 2–3 hari.
2. Aktivitas sekolah terganggu selama menstruasi.
3. Perdarahan 5–6 hari, volume sedang, warna merah cerah.
4. Tidak ada riwayat kelainan organik atau gangguan hormonal yang diketahui.
5. Remaja tidak mengetahui cara mengurangi nyeri menstruasi atau mencatat siklus menstruasi.
6. Dukungan keluarga terbatas; orang tua sibuk bekerja dan belum memberikan edukasi menstruasi rutin.

Tugas Mahasiswa (Level Knows How)

Mahasiswa diminta untuk menganalisis dan merencanakan intervensi (bukan melakukan tindakan langsung):

1. Identifikasi masalah kebidanan dan faktor yang memengaruhi keluhan menstruasi remaja (dismenore primer, risiko anemia, kurang edukasi).
2. Jelaskan pendekatan konseling berbasis hak remaja (rights-based & client-centered care) terkait menstruasi.
3. Tentukan tata laksana awal yang aman dan efektif, termasuk:
 - Manajemen nyeri nonfarmakologi (kompres hangat, relaksasi, olahraga ringan)
 - Edukasi pencatatan siklus menstruasi
 - Nutrisi dan hidrasi selama menstruasi
4. Jelaskan peran jejaring pelayanan kesehatan:
 - Bidan Puskesmas, guru BK, kader remaja, dan orang tua.
5. Rancang rencana tindak lanjut berbasis komunitas:
 - Pencatatan siklus menstruasi, evaluasi nyeri setiap bulan
 - Pemantauan gejala baru atau red flags (menoragia, nyeri hebat, demam)
6. Identifikasi potensi risiko:
 - Drop out dari pencatatan siklus
 - Penyalahpahaman terkait menstruasi normal
 - Perkembangan gangguan menstruasi sekunder yang tidak terdeteksi

J. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	6
2	Judul	Kesehatan Menstruasi Remaja: Pengkajian Keluhan, Identifikasi Gangguan, dan Edukasi Tata Laksana Awal
3	Kasus	Pengkajian remaja yang mengalami keluhan menstruasi (nyeri, perdarahan tidak teratur, PMS) dan penyusunan rencana edukasi dan tata laksana awal
4	Tujuan	Menilai kemampuan peserta melakukan pengkajian menstruasi remaja, mengidentifikasi gangguan menstruasi, memberikan edukasi berbasis hak remaja, dan merencanakan tata laksana awal yang aman dan efektif
5	Kompetensi	1. Anamnesis riwayat menstruasi dan keluhan 2. Identifikasi tipe gangguan menstruasi (dismenore, menoragia, AUB) 3. Skrining risiko red flags 4. Edukasi manajemen nyeri dan pencatatan siklus 5. Konseling berbasis hak dan client-centered care 6. Edukasi nutrisi dan gaya hidup 7. Perencanaan tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan 8. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Remaja perempuan usia 16 tahun datang ke Puskesmas remaja mengeluh nyeri perut bagian bawah setiap menstruasi sejak menarche. Perdarahan 5–6 hari, volume sedang, nyeri kram menjalar ke punggung, terkadang mual ringan. Aktivitas sekolah terganggu. Tidak ada riwayat kelainan organik. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terkait menstruasi dan keluhan nyeri 2. Identifikasi tipe gangguan menstruasi 3. Lakukan skrining red flags (menoragia hebat, nyeri berat, gejala sistemik)

		4. Jelaskan manajemen nyeri awal dan edukasi pencatatan siklus menstruasi 5. Berikan edukasi nutrisi dan gaya hidup 6. Rancang rencana tindak lanjut dan edukasi rujukan jika muncul gejala abnormal
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai 2. Penilaian berdasarkan checklist (0–3) dan global rating (1–4) 3. Tidak memberikan bantuan 4. Penilaian objektif INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis → PS menjawab sesuai scenario 2. Skrining → identifikasi red flags yang ada/tidak ada 3. Diagnosis yang diharapkan: dismenore primer dengan risiko menoragia ringan 4. Tindakan yang diharapkan: a. Edukasi manajemen nyeri nonfarmakologi b. Pencatatan siklus menstruasi c. Edukasi nutrisi dan gaya hidup sehat 5. Rencana tindak lanjut: pemantauan siklus bulanan, edukasi rujukan bila gejala abnormal muncul
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai remaja usia 16 tahun dengan dismenore primer 2. Sedikit cemas karena nyeri menstruasi mengganggu sekolah 3. Fokus masalah: nyeri menstruasi, gangguan aktivitas sekolah, kurang edukasi tentang pencatatan siklus 4. Jika dijelaskan → mulai memahami manajemen nyeri, pencatatan siklus, dan nutrisi yang dianjurkan 5. Akan bertanya: “Bu, saya selalu sakit saat haid, apa yang bisa saya lakukan supaya tidak terganggu sekolah?”
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi PS: Pagi Bu Peserta: Apa keluhan yang dialami? PS: Saya selalu nyeri perut bagian bawah setiap haid, terkadang mual, dan terganggu sekolah

		Peserta: Saya akan jelaskan cara mengurangi nyeri dan mencatat siklus haid supaya ibu bisa memantau PS: Oke, Bu, bagaimana cara melakukannya? Peserta: Berikan edukasi langkah-langkah, nutrisi, olahraga ringan, dan kapan harus konsultasi
10	Kebutuhan manikin	Tidak wajib (roleplay konseling)
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruang OSCE 2. Menyiapkan lembar penilaian 3. Mengatur alur peserta
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi 2. Lembar status pasien 3. Lembar penilaian 4. Alat tulis 5. Leaflet edukasi menstruasi 6. Buku panduan KIE remaja
13	Penulis	(Isi sesuai penulis)
14	Referensi	1. Carmine, L., & Fisher, M. (2022). Menstrual and reproductive health in female adolescents. <i>Current Problems in Pediatric and Adolescent Health</i>. 2. Çınar, H.U., et al. (2023). Assessing menstrual problems in adolescents. <i>Elsevier</i>. 3. Kabra, R., & Fisher, M. (2022). Adolescent gynecology. <i>Journal of Pediatric and Adolescent Health</i>. 4. Bidemi, A.I., et al. (2021). Challenges facing menstruating adolescents. <i>ResearchGate</i>. 5. Nelson, A.L. (2023). Dysmenorrhea management in adolescents. <i>Journal of Pediatric Health Care</i>. 6. Salih, S., et al. (2025). Menstrual health and self-care among adolescents. <i>Elsevier</i>. 7. Leroy-Melamed, M., et al. (2020). Menstrual dysfunction in adolescents. <i>Journal of Pediatric and Adolescent Health</i>. 8. Gaferi, S.M., et al. (2018). Knowledge and practices related to reproductive health. <i>Journal of Nursing</i>. 9. WHO. (2021). Adolescent reproductive health. World Health Organization.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 6: Kesehatan Menstruasi Remaja

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis Menstruasi)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Keluhan utama menstruasi (nyeri, perdarahan, PMS)		
Durasi dan frekuensi siklus menstruasi		
Volume dan warna perdarahan		
Riwayat nyeri menstruasi sebelumnya / dismenore		
Riwayat gangguan menstruasi dalam keluarga		
Faktor sosial / dukungan keluarga, sekolah, teman sebaya		
Pengetahuan remaja tentang manajemen menstruasi dan gaya hidup		

Skoring KOMPETENSI 1

3 = Melakukan semua 7 langkah dengan benar

2 = Melakukan 4–6 langkah dengan benar

1 = Melakukan 1–3 langkah dengan benar

0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Perencanaan dan Edukasi Tata Laksana Awal

1. Persiapan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyapa remaja dengan sopan	0–3	
b. Memperkenalkan diri dan peran sebagai bidan	0–3	
c. Menjelaskan tujuan pengkajian / edukasi menstruasi	0–3	
d. Meminta persetujuan untuk pengkajian	0–3	
e. Menjaga privasi dan kenyamanan	0–3	
f. Hand hygiene sebelum/selama interaksi	0–3	
g. Menyiapkan lembar pencatatan siklus menstruasi / KIE	0–3	

2. Langkah-langkah

Komponen	Skoring	Skor
a. Menilai kondisi umum remaja (tanda vital, gizi)	0–3	
b. Mengidentifikasi tipe gangguan menstruasi	0–3	
c. Melakukan skrining red flags (nyeri hebat, perdarahan berlebihan, gejala sistemik)	0–3	
d. Memberikan edukasi manajemen nyeri nonfarmakologi	0–3	
e. Edukasi pencatatan siklus menstruasi	0–3	

f. Edukasi nutrisi dan gaya hidup sehat	0–3	
g. Menjelaskan tanda bahaya dan kapan harus rujuk	0–3	
h. Menyusun rencana tindak lanjut / follow-up	0–3	

3. Pasca Tindakan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyimpulkan hasil pengkajian dan edukasi	0–3	
b. Memberikan kesempatan remaja bertanya	0–3	
c. Dokumentasi pengkajian, edukasi, dan rencana tindak lanjut	0–3	

Skoring KOMPETENSI 2

3 = Melakukan 15–20 langkah dengan tepat & sistematis

2 = Melakukan 10–14 langkah cukup tepat

1 = Melakukan 1–9 langkah

0 = Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE / Konseling Berbasis Hak

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Sapa dan salam ramah		
Menjelaskan kondisi dan kebutuhan remaja		
Menjelaskan pilihan manajemen nyeri dan pencatatan siklus		
Menjelaskan efek samping / risiko ringan dan meluruskan mitos		
Memberi kesempatan remaja bertanya		
Menjawab pertanyaan dengan jelas dan empatik		

Skoring KOMPETENSI 3

3 = Semua 6 langkah benar

2 = 4–5 langkah benar

1 = 1–3 langkah benar

0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Menjaga privasi remaja		
3. Empati terhadap remaja		
4. Komunikasi jelas & tenang		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

3 = 5 langkah benar

2 = 4 langkah benar

1 = 1–3 langkah benar

0 = Tidak melakukan

$$\text{TOTAL SKOR} = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3$$

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{-----}}{30} \times 100 =$$

(Kota),.....

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Topik: Kesehatan Menstruasi Remaja: Pengkajian, Identifikasi Gangguan, dan Tata Laksana Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Menstruasi Remaja
Metode penilaian	DOPS menilai keterampilan mahasiswa melalui observasi langsung tindakan di praktik klinik atau simulasi. Domain dinilai: komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan teknis, keselamatan pasien, profesionalisme.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan pengkajian menstruasi remaja, menilai keluhan nyeri, frekuensi siklus, volume perdarahan, skrining red flags, memberikan edukasi manajemen nyeri, pencatatan siklus, nutrisi, dan rencana tindak lanjut.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa memberikan asuhan kebidanan menstruasi yang aman, efektif, dan berpusat pada remaja.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan anamnesis, identifikasi gangguan, edukasi berbasis hak remaja, serta menyusun rencana tindak lanjut dan rujukan bila perlu.
Kasus klinik	Kasus nyata atau simulasi untuk menunjukkan keterampilan klinik.	Remaja 16 tahun mengeluh nyeri perut bagian bawah saat menstruasi, perdarahan 5–6 hari, volume sedang, nyeri menjalar ke punggung, aktivitas sekolah terganggu.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Observasi pengkajian, edukasi, skrining, identifikasi red flags, dan rencana tindak lanjut.	Mahasiswa menyapa remaja, anamnesis riwayat menstruasi, menilai dismenore primer, memberikan edukasi manajemen nyeri dan pencatatan siklus, nutrisi, serta mendokumentasikan intervensi.
Aspek yang dinilai	Anamnesis, skrining, edukasi, KIE, keselamatan, profesionalisme,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa menghubungkan keluhan, riwayat menstruasi, faktor sosial, dan memilih

	penghargaan keputusan klien.	intervensi yang tepat, serta menjelaskan tanda bahaya/red flags.
Fokus observasi pembimbing	Observasi performa nyata: sistematis, aman, efektif, pengambilan keputusan klinis.	Pembimbing melihat mahasiswa melakukan edukasi berbasis hak, menyusun rencana tindak lanjut, memilih intervensi sesuai kebutuhan remaja, dan menjaga privasi.
Umpan balik	Segera setelah observasi, menekankan kelebihan dan area perbaikan, spesifik dan konstruktif.	Pembimbing memberi komentar mahasiswa mampu memberikan edukasi jelas, tetapi perlu lebih rinci dalam penilaian red flags dan rencana follow-up.
Keputusan penilaian	Dikategorikan: kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa kompeten jika mampu melakukan pengkajian, edukasi, identifikasi gangguan, dan menyusun rencana tindak lanjut. Perlu supervisi bila masih memerlukan arahan. Remedial bila salah menilai gangguan atau tidak edukatif.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik level "does" pada taksonomi Miller.	Mahasiswa menerapkan teori ke praktik nyata, melakukan pengkajian, edukasi, pengambilan keputusan klinis, dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

OSCE + DOPS

Catatan kasus singkat

Refleksi patient safety

Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

Bukan sekali ujian

Bukti konsistensi kompetensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Menstruasi Remaja
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.	Memuat bukti mahasiswa melakukan pengkajian menstruasi, identifikasi gangguan, edukasi manajemen nyeri, pencatatan siklus, dan rencana tindak lanjut.
Tujuan portofolio	Dokumentasi proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, tindak lanjut perbaikan.	Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemampuan memberikan edukasi menstruasi, identifikasi red flags, dan konseling berbasis hak remaja.
OSCE & DOPS	Memberikan bukti keterampilan terstruktur dan performa nyata di lapangan.	OSCE memuat ujian simulasi pengkajian dan edukasi menstruasi, DOPS mengamati performa nyata di Puskesmas remaja.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus klien: data penting, masalah, tindakan, hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus remaja 16 tahun dengan dismenore primer, keluhan nyeri, volume perdarahan sedang, aktivitas sekolah terganggu, edukasi manajemen nyeri, pencatatan siklus, dan rencana tindak lanjut.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko dan mencegah kesalahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya skrining red flags, edukasi jelas, pencatatan siklus, dan rujukan bila gejala abnormal muncul.

Feedback CI/dosen	Umpan balik pembimbing mengenai kekuatan dan area perbaikan.	CI menilai mahasiswa komunikatif, edukatif, tetapi perlu lebih rinci dalam skrining red flags dan tindak lanjut.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi terlihat mahasiswa konsisten mampu memberikan edukasi menstruasi dan pengkajian lengkap.
Makna dalam OBE	Bukti autentik capaian pembelajaran terlihat dalam performa nyata berulang.	Mahasiswa menerapkan teori menstruasi secara konsisten, aman, berbasis hak, dan adaptif terhadap kondisi remaja.

K. Rangkuman Materi

Menstruasi merupakan proses fisiologis alami yang menandai berfungsinya sistem reproduksi perempuan. Siklus menstruasi adalah perubahan berkala pada endometrium dan hormon reproduksi yang terjadi rata-rata setiap 28 hari (± 7 hari), menandai kemampuan reproduksi seorang remaja (Grover, 2019).

Siklus menstruasi terdiri dari tiga fase utama: fase folikular, ovulasi, dan fase luteal. Fase folikular ditandai oleh pertumbuhan folikel ovarium yang dipengaruhi hormon FSH. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus ketika hormon LH memuncak, diikuti fase luteal di mana korpus luteum menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan endometrium bagi implantasi (Kabra & Fisher, 2022). Perubahan fisiologis ini membutuhkan dukungan nutrisi yang cukup, edukasi yang tepat, serta dukungan psikososial agar siklus menstruasi berlangsung normal tanpa gangguan (Rakib, 2024).

Menstruasi normal ditandai oleh perdarahan 3–7 hari, volume 30–80 ml, warna merah cerah hingga coklat, frekuensi setiap 21–35 hari, tanpa nyeri berat atau gejala sistemik (Carmin & Fisher, 2022). Keluhan yang paling sering muncul pada remaja meliputi dismenore primer, perubahan mood atau PMS, nyeri payudara, dan kelelahan ringan. Keluhan ini dapat memengaruhi kualitas hidup dan aktivitas sekolah remaja (Çınar et al., 2023; Gopalan et al., 2024).

Gangguan menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Disminore primer adalah nyeri menstruasi tanpa kelainan organik, akibat kontraksi uterin berlebihan. Disminore sekunder terjadi akibat kelainan patologis seperti endometriosis, fibroid, atau adenomyosis. Amenore adalah tidak menstruasi selama ≥ 3 bulan pada remaja yang sebelumnya telah menstruasi. Menoragia merupakan perdarahan berlebihan

atau berlangsung lebih dari 7 hari, sedangkan Abnormal Uterine Bleeding (AUB) adalah perdarahan yang tidak sesuai siklus normal dan memerlukan evaluasi lebih lanjut (Kabra & Fisher, 2022; Al-Qazaz & Al-Dabbagh, 2020).

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan meliputi anamnesis detail riwayat siklus menstruasi, pemeriksaan fisik, ultrasonografi pelvis, dan pemeriksaan hormonal bila diperlukan (Özcan & Burger, 2024).

Tata laksana awal disesuaikan dengan jenis keluhan. Pada dismenore primer, diberikan NSAID, kompres hangat, olahraga ringan, dan edukasi teknik relaksasi. Gangguan mood atau PMS dapat dikelola dengan teknik coping, diet seimbang, dan aktivitas fisik teratur. Untuk menoragia ringan, penting memantau jumlah perdarahan, mencatat siklus menstruasi, dan memberikan edukasi pencatatan siklus (Bidemi et al., 2021). Reaksi red flags seperti nyeri hebat, perdarahan sangat banyak, demam, atau gejala sistemik harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan (Leroy-Melamed et al., 2020).

Asuhan kebidanan untuk remaja meliputi pengkajian riwayat menstruasi, pola perdarahan, dan keluhan nyeri, serta observasi tanda vital dan status gizi. Edukasi diberikan kepada remaja dan keluarga mengenai manajemen nyeri, higiene menstruasi, pencatatan siklus, serta pentingnya konsultasi jika terdapat gejala abnormal. Dokumentasi lengkap mengenai siklus, keluhan, dan intervensi yang diberikan sangat penting untuk keberlanjutan asuhan (Gaferi et al., 2018).

Red flags yang perlu diwaspadai meliputi nyeri menstruasi hebat yang tidak membaik dengan analgesik ringan, perdarahan sangat banyak atau lebih dari 7 hari, gejala sistemik seperti demam, mual/muntah, pusing hebat, gangguan aktivitas sehari-hari yang signifikan, dan penurunan berat badan drastis atau kelelahan ekstrem. Kehadiran salah satu tanda tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan rujukan ke fasilitas kesehatan.

Pencatatan dan edukasi menstruasi merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan remaja. Remaja dianjurkan mencatat frekuensi, durasi, volume, warna perdarahan, serta keluhan nyeri pada setiap siklus. Edukasi mengenai nutrisi yang baik, aktivitas fisik ringan, serta pengenalan red flags harus diberikan agar remaja dapat mengenali kondisi normal dan abnormal, serta tahu kapan harus mencari bantuan profesional.

Ringkasan narasi ini menyatukan teori dasar, tanda normal, keluhan umum, gangguan menstruasi, pemeriksaan, tata laksana awal, asuhan kebidanan, red flags, serta edukasi dan pencatatan dalam satu alur naratif sehingga mudah dipahami dan dijadikan referensi bagi bidan atau mahasiswa kebidanan dalam konteks pembelajaran OBE.

Tabel Red Flags & Eskalasi
Kesehatan Menstruasi Remaja

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Nyeri menstruasi hebat yang tidak membaik dengan analgesik ringan	Dapat menunjukkan dismenore sekunder, endometriosis, fibroid, atau gangguan patologis lain	Evaluasi lengkap, anamnesis, pemeriksaan fisik, rujuk ke fasilitas kesehatan spesialis kebidanan/ginekologi
Perdarahan sangat banyak (>80 ml/hari) atau berlangsung >7 hari	Menandakan menoragia atau AUB yang dapat menyebabkan anemia	Pantau tanda vital, lakukan pemeriksaan hemoglobin, catat siklus menstruasi, rujuk ke dokter/RS
Tidak menstruasi ≥ 3 bulan pada remaja yang sebelumnya menstruasi	Menunjukkan amenore sekunder, kemungkinan gangguan hormonal, stres, atau penyakit sistemik	Evaluasi riwayat medis, pemeriksaan hormonal, USG pelvis, rujuk ke spesialis jika diperlukan
Gejala sistemik: demam, mual/muntah, pusing hebat, penurunan berat badan drastis	Bisa mengindikasikan infeksi, anemia berat, gangguan metabolik atau endokrin	Evaluasi segera, lakukan pemeriksaan laboratorium, rujuk ke fasilitas kesehatan
Gangguan aktivitas sehari-hari berat akibat nyeri atau perdarahan	Menunjukkan kondisi menstruasi yang abnormal dan mempengaruhi kualitas hidup	Catat dampak pada aktivitas, beri edukasi awal, pertimbangkan intervensi farmakologis atau rujuk ke spesialis
Perdarahan tidak sesuai siklus normal (tidak teratur, bercampur darah hitam, atau bercak panjang)	Menandakan AUB atau gangguan hormonal	Dokumentasikan pola perdarahan, lakukan skrining red flags, rujuk untuk evaluasi lebih lanjut
Gejala anemia (lemas, pucat, napas pendek)	Komplikasi dari perdarahan berlebihan	Lakukan pemeriksaan hemoglobin, edukasi nutrisi tinggi zat besi, rujuk ke fasilitas kesehatan

Nyeri perut disertai benjolan atau pembesaran perut	Dapat mengindikasikan fibroid, endometriosis, atau massa pelvis lain	Evaluasi USG pelvis, konsultasi dengan spesialis ginekologi
Keluhan psikologis berat (depresi, kecemasan ekstrem) terkait menstruasi	Menunjukkan PMS berat atau gangguan mood terkait hormon	Lakukan screening psikologis, edukasi manajemen stres, rujuk ke psikolog atau psikiater bila perlu
Gangguan pencernaan atau gejala sistemik lain yang menyertai menstruasi	Dapat menjadi tanda penyakit sistemik atau komplikasi hormonal	Evaluasi klinis lengkap, pemeriksaan laboratorium, rujuk sesuai temuan

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab : Kesehatan Menstruasi Remaja

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Lapangan Komunitas : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi dan konsep dasar menstruasi pada remaja	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan fase-fase siklus menstruasi: folikular, ovulasi, luteal	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda normal menstruasi pada remaja	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan keluhan umum menstruasi, termasuk dismenore dan PMS	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali gangguan menstruasi: dismenore sekunder, amenore, menoragia, AUB	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan pengkajian riwayat menstruasi dan keluhan nyeri	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai tanda vital dan status gizi remaja terkait menstruasi	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk gangguan menstruasi	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan edukasi mengenai manajemen nyeri menstruasi dan teknik relaksasi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan edukasi nutrisi dan aktivitas fisik yang mendukung kesehatan menstruasi	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa mengenali red flags menstruasi yang memerlukan evaluasi medis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menyusun rencana tindak lanjut dan monitoring siklus menstruasi	☐	☐	_____

13	Saya sudah bisa melakukan edukasi higiene menstruasi dan pencatatan siklus menstruasi	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa memberikan edukasi psikososial dan dukungan bagi remaja terkait menstruasi	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan pengkajian, keluhan, intervensi, dan rencana tindak lanjut	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama asuhan menstruasi	☐	☐	_____

L. Daftar Pustaka

- Adeyemi-Fowode, O. A. (2022). Menstrual disorders in adolescents. *Pediatric Clinics of North America*, 69(2), 231–245.
- Al-Qazaz, H. K., & Al-Dabbagh, S. A. (2020). Abnormal uterine bleeding among adolescent females: Clinical evaluation and management. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 149(3), 289–296.
- Aningsih, S., Amalia, S., & Safitri, Y. R. (2025). Analysis of factors affecting the menstrual cycle among adolescent girls: A scoping review. *Journal of Nursing Education and Practice*, 15(1), 45–56.
- Bannow, B. T. (2024). Evaluation of heavy menstrual bleeding in adolescents. *Hematology/Oncology Clinics of North America*, 38(1), 101–115.
- Bidemi, A. I., Odetola, T. D., & Adebayo, A. M. (2021). Challenges facing menstruating adolescents in low-resource settings. *Journal of Adolescent Health*, 68(4), 721–728.
- Brookhart, M., & Naroji, S. (2025). Neuroendocrine regulation of the hypothalamic-pituitary-ovarian axis in adolescents. *Endocrine Reviews*, 46(1), 55–72.
- Calcaterra, V., Verduci, E., Cena, H., & Magenes, V. C. (2024). Iron deficiency and anemia in menstruating adolescents: Prevention and management strategies. *Nutrients*, 16(2), 245–259.
- Carmine, L., & Fisher, M. (2022). Menstrual and reproductive health in female adolescents. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, 52(8), 101219. <https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2022.101219>

- Cheung, E. Y. L. (2025). Menstruation as the fifth vital sign in adolescent health assessment. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 38(1), 12–18.
- Çınar, H. U., Yıldız, E., & Korkmaz, M. (2023). Assessing menstrual problems in adolescents: A clinical review. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 36(4), 301–309.
- Delanerolle, G., Pathak, A., & Zeng, Y. (2025). Hormonal fluctuations and mood changes across the menstrual cycle in adolescents. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 112345.
- Gaferi, S. M., Al-Harbi, K. A., & Alqahtani, M. M. (2018). Knowledge and practices related to reproductive health among adolescent girls. *Journal of Nursing Education and Practice*, 8(9), 77–85.
- Ganguly, S., Das, P., & Banerjee, M. (2025). Initial management of dysmenorrhea and menstrual disorders in adolescents. *Obstetrics and Gynecology Clinics*, 52(1), 89–104.
- Gopalan, S., Narayanan, R., & Kumar, P. (2024). Menstrual symptoms and school absenteeism among adolescents: A systematic review. *BMC Women's Health*, 24(1), 112.
- Grover, S. R. (2019). Menstrual disorders in adolescence: A clinical overview. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 48, 3–12.
- Howlett, M., Johnson, K., & Peters, A. (2025). Clinical reasoning in adolescent menstrual health: An outcome-based education approach. *Nurse Education Today*, 138, 106102.
- Kabra, R., & Fisher, M. (2022). Adolescent gynecology and menstrual health. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 35(5), 455–463.
- Leroy-Melamed, M., Kaunitz, A. M., & Micks, E. A. (2020). Menstrual dysfunction in adolescents. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 33(6), 587–594.
- Liang, S., Wong, L. P., & Lim, H. M. (2023). Cultural beliefs and menstrual health practices among adolescent girls. *BMC Public Health*, 23(1), 874.
- McKenna, K. A., & Fogleman, C. D. (2021). Dysmenorrhea. *American Family Physician*, 104(2), 164–170.
- Nelson, A. L. (2023). Dysmenorrhea management in adolescents. *Journal of Pediatric Health Care*, 37(5), 411–419.

- O'Brien, S. H., & Bosak, K. A. (2025). Primary dysmenorrhea: Pathophysiology and management updates. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 37(1), 34–41.
- Özcan, M., & Burger, H. G. (2024). Diagnostic evaluation of menstrual disorders in adolescents. *Gynecological Endocrinology*, 40(2), 95–103.
- Popat, V. B., Prodanov, T., & Calis, K. A. (2008). The menstrual cycle: A biological marker of general health in adolescents. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1135(1), 43–51.
- Rakib, M. A. (2024). Nutritional support and menstrual cycle health among adolescent girls. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 36(2), 145–153.
- Salih, S., Ahmed, N., & Yusuf, R. (2024). Menstrual health and self-care among adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 74(3), 356–365.
- World Health Organization. (2021). Adolescent reproductive health. <https://www.who.int>

BAB 6

PENCEGAHAN KEHAMILAN REMAJA: EDUKASI, KONSELING, DAN AKSES PELAYANAN YANG AMAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Uraian Materi

A. Konsep dan Determinan Kehamilan Remaja

Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Menurut *World Health Organization*, remaja adalah individu yang berada pada rentang usia **10–19 tahun**. Pada masa ini terjadi perkembangan pesat dalam aspek biologis, terutama kematangan organ reproduksi yang membuat remaja mulai memiliki kemampuan untuk bereproduksi.

Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan yang berusia di bawah 20 tahun. Kondisi ini sering kali dikaitkan dengan berbagai permasalahan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menurut *United Nations Population Fund*, kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan perempuan dewasa. Risiko tersebut meliputi anemia, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, hingga peningkatan angka kematian ibu dan bayi.



Gambar 6.1. Resiko Kehamilan Remaja Dibawah Umur

Selain risiko kesehatan, kehamilan remaja juga berdampak pada aspek sosial, seperti putus sekolah, keterbatasan kesempatan kerja, serta tekanan psikologis. Dalam banyak kasus, kehamilan yang terjadi pada remaja merupakan kehamilan yang tidak direncanakan akibat kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan remaja antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
2. Minimnya komunikasi antara orang tua dan anak mengenai seksualitas.
3. Pengaruh teman sebaya.
4. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi.
5. Norma sosial dan budaya yang tidak mendukung edukasi seksual.

Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat strategis sebagai edukator, konselor, dan fasilitator layanan. Bidan tidak hanya dituntut untuk memberikan informasi yang benar, tetapi juga mampu membangun hubungan yang empatik, menjaga kerahasiaan, serta membantu remaja dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksinya

1. Konsep Dasar Etik dalam Pelayanan Kesehatan reproduksi

Etik adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan salah dalam praktik pelayanan kesehatan.

a. Prinsip-Prinsip Etik Utama

1) Autonomi (Autonomy)

Menghargai hak remaja untuk membuat keputusan terkait kesehatan reproduksinya.

Contoh: remaja berhak memilih metode kontrasepsi setelah mendapatkan informasi yang cukup.

2) Beneficence (Berbuat Baik)

Tenaga kesehatan wajib memberikan manfaat terbaik bagi klien.

Contoh: memberikan edukasi pencegahan kehamilan yang sesuai usia.

3) Non-maleficence (Tidak Merugikan)

Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan klien.

Contoh: tidak memberikan informasi yang menyesatkan atau tindakan tanpa indikasi.

4) Justice (Keadilan)

Memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi.

Contoh: semua remaja mendapatkan akses layanan tanpa memandang status sosial.

2. Prinsip Etik Spesifik pada Remaja

a. Kerahasiaan (Confidentiality)

Informasi kesehatan remaja harus dijaga, kecuali terdapat risiko serius (misalnya kekerasan atau ancaman keselamatan).

b. Privasi

Pelayanan harus dilakukan di ruang yang aman dan tidak terbuka.

c. Non-judgmental

Tidak menghakimi pilihan atau kondisi remaja.

d. Respect (Menghormati)

Menghargai nilai, budaya, dan latar belakang remaja.

3. Kerangka Legal dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Hak Remaja dalam Pelayanan Kesehatan

Remaja memiliki hak untuk:

- 1) Mendapatkan informasi kesehatan yang benar
 - 2) Mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas
 - 3) Menjaga kerahasiaan data kesehatan
 - 4) Memberikan persetujuan terhadap tindakan medis
- b. Informed Consent
- Persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi lengkap meliputi:
- 1) Tujuan tindakan
 - 2) Prosedur
 - 3) Risiko dan manfaat
 - 4) Alternatif tindakan
- Pada remaja, informed consent dapat melibatkan orang tua/wali tergantung usia dan regulasi.
- c. Batasan Hukum
- Tenaga kesehatan harus memahami:
- 1) Usia legal untuk persetujuan tindakan
 - 2) Perlindungan anak
 - 3) Kasus wajib lapor (misalnya kekerasan seksual)

B. Komunikasi Dan Konseling Ramah Remaja/Prakonsepsi Secara Aman

Komunikasi dan konseling merupakan komponen utama dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi. Remaja berada pada fase perkembangan yang unik, sehingga pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik psikologis, sosial, dan budaya mereka.



Gambar 6.2 Pentingnya Komunikasi Pada Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi

Komunikasi ramah remaja adalah proses penyampaian informasi dan interaksi antara tenaga kesehatan dengan remaja yang dilakukan secara terbuka, menghargai, dan tidak menghakimi. Karakteristik Komunikasi Ramah Remaja:

- Menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami
- Tidak menggurui atau menyalahkan
- Menghargai pendapat dan perasaan remaja
- Menyesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan
- Memberikan ruang untuk bertanya

Hambatan Komunikasi:

- a. Rasa malu atau takut pada remaja
- b. Perbedaan bahasa atau budaya
- c. Sikap tenaga kesehatan yang otoriter
- d. Kurangnya privasi

Tahapan Komunikasi

1. Membangun Hubungan (Rapport Building)

- a. Menyapa dengan ramah
- b. Memperkenalkan diri
- c. Menciptakan suasana nyaman

2. Menggali Informasi

- a. Menggunakan pertanyaan terbuka
- b. Mendengarkan secara aktif
- c. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah

3. Memberikan Informasi

- a. Menyampaikan informasi sesuai kebutuhan
- b. Menggunakan media bantu jika perlu
- c. Menghindari istilah medis yang sulit

4. Membantu Pengambilan Keputusan

- a. Menjelaskan pilihan yang tersedia
- b. Membantu mempertimbangkan risiko dan manfaat
- c. Tidak memaksakan pilihan

5. Menutup Komunikasi

- a. Merangkum hasil diskusi
- b. Menyusun rencana tindak lanjut
- c. Memberikan kesempatan bertanya

Komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi merupakan kunci dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang efektif. Dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan informed choice, serta menggunakan pendekatan empatik dan non-judgmental, tenaga kesehatan dapat membantu remaja

membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya.

C. Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja

Edukasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan kehamilan remaja. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar mengenai fungsi organ reproduksi, perubahan yang terjadi pada masa pubertas, serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif harus mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pengetahuan tentang pubertas dan perubahan tubuh.
2. Pemahaman mengenai hubungan yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Informasi tentang kontrasepsi dan pencegahan penyakit menular seksual.
4. Pengembangan keterampilan pengambilan keputusan.
5. Pembentukan sikap dan nilai yang positif terhadap kesehatan reproduksi.

Edukasi kesehatan reproduksi dapat diberikan melalui berbagai media, seperti kurikulum sekolah, program penyuluhan di masyarakat, media digital, serta kegiatan remaja berbasis komunitas. Program edukasi yang efektif tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kemampuan remaja dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi mereka

D. Konseling Kesehatan Reproduksi bagi Remaja

Konseling merupakan proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan remaja yang bertujuan membantu remaja memahami masalah yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat. Konseling kesehatan reproduksi bagi remaja memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi.
2. Membantu remaja memahami risiko perilaku seksual yang tidak aman.
3. Mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab.
4. Memberikan dukungan emosional dan psikologis.

Dalam pelaksanaannya, konseling bagi remaja harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Kerahasiaan (*confidentiality*)
2. Sikap tidak menghakimi (*non-judgmental*)
3. Menghargai hak dan pilihan remaja
4. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

Pendekatan konseling yang ramah remaja sangat penting agar remaja merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

E. Akses Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Aman bagi Remaja

Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang aman merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan kehamilan remaja. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja harus dirancang secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik remaja.

Pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja biasanya memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Mudah diakses oleh remaja.
2. Menjamin kerahasiaan dan privasi.
3. Memberikan informasi yang jelas dan akurat.
4. Tenaga kesehatan yang terlatih dalam menangani remaja.
5. Lingkungan pelayanan yang nyaman dan tidak diskriminatif.

Di Indonesia, pelayanan kesehatan reproduksi remaja sering diselenggarakan melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Selain fasilitas kesehatan, akses informasi melalui media digital juga semakin penting dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja. Namun demikian, informasi yang diberikan harus bersumber dari lembaga yang terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

F. Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja

Pencegahan kehamilan remaja memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Beberapa strategi utama yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.
2. Penyediaan layanan konseling bagi remaja.
3. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja.
4. Penguatan peran keluarga dalam memberikan pendidikan seks yang tepat.
5. Kampanye kesehatan reproduksi melalui media massa dan media sosial.



Gambar 6.3 Pencegahan Kehamilan Remaja

Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan angka kehamilan remaja serta meningkatkan kualitas hidup remaja secara keseluruhan.

Layanan Berbasis Sekolah Melalui Jejaring, Pencatatan–Pelaporan, Monitoring-Evaluasi Sederhana, Dan Pemanfaatan Evidence.

Layanan berbasis sekolah/komunitas adalah pelayanan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan di lingkungan sekolah atau masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan:

1. Meningkatkan akses remaja terhadap layanan
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup
3. Mencegah perilaku berisiko
4. Menurunkan angka kehamilan remaja

Adapun bentuk kegiatannya yaitu, Edukasi kesehatan reproduksi, Konseling remaja, Skrining Kesehatan, Kelas remaja/prakonsepsi dan Posyandu remaja. Penguatan jejaring layanan merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan program kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi. Jejaring ini mencakup keterlibatan sekolah (guru dan UKS), puskesmas atau bidan, orang tua, tokoh masyarakat, organisasi remaja, serta lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menciptakan dukungan yang komprehensif bagi remaja, baik dari sisi edukasi, pelayanan kesehatan, maupun lingkungan sosial. Strategi dalam membangun jejaring dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, penyelenggaraan pertemuan rutin, pembagian peran yang jelas di antara pihak terkait, serta penyusunan rencana kerja bersama. Dalam hal ini, bidan berperan sebagai koordinator layanan kesehatan, fasilitator edukasi dan konseling, serta penghubung antar sektor untuk memastikan kesinambungan program.

Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian penting dalam manajemen layanan karena berfungsi untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan dapat digunakan dalam proses evaluasi. Tujuan utama pencatatan adalah mendokumentasikan kegiatan, menilai capaian program, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Data yang dicatat meliputi identitas klien (menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan), jenis layanan yang diberikan, hasil skrining, hasil konseling, serta rujukan yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, pencatatan harus memenuhi prinsip akurat, lengkap, tepat waktu, dan tetap menjaga kerahasiaan klien. Format pencatatan dapat disusun secara sederhana, misalnya dalam bentuk tabel yang memuat tanggal pelayanan, jenis layanan, hasil, dan tindak lanjut.

Monitoring dan evaluasi (monev) sederhana dilakukan untuk menilai apakah program berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara rutin untuk melihat pelaksanaan kegiatan, dengan indikator seperti jumlah kegiatan edukasi yang dilakukan, jumlah remaja yang hadir, serta jumlah layanan konseling yang diberikan. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai hasil dan dampak program, seperti peningkatan pengetahuan remaja, perubahan sikap, serta penurunan perilaku berisiko. Proses monev dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain observasi, penggunaan kuesioner sederhana, wawancara, dan diskusi kelompok.

Secara operasional, alur pengorganisasian layanan dimulai dari identifikasi kebutuhan remaja, dilanjutkan dengan pembentukan jejaring, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan layanan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, hingga perbaikan layanan berbasis evidence. Dalam keseluruhan proses tersebut, bidan memegang peran penting sebagai perencana program, koordinator jejaring, pelaksana layanan, pengelola data, sekaligus evaluator program.

Namun demikian, pelaksanaan layanan berbasis sekolah dan komunitas tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi remaja, adanya stigma terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi yang adaptif, antara lain melalui pendekatan peer education yang melibatkan remaja sebagai agen perubahan, pemanfaatan media digital dalam edukasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi yang tepat, layanan kesehatan reproduksi remaja diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan kehamilan remaja.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun datang ke puskesmas bersama temannya untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi. Ia mengaku sedang berpacaran dan merasa khawatir karena beberapa temannya di sekolah mengalami kehamilan pada usia remaja. Remaja tersebut menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya memahami tentang cara mencegah kehamilan, siklus menstruasi, maupun risiko hubungan seksual tanpa perlindungan.

Remaja tersebut juga menyampaikan bahwa ia merasa malu untuk bertanya kepada orang tua maupun guru mengenai masalah kesehatan reproduksi. Selama ini informasi yang ia peroleh sebagian besar berasal dari teman sebaya dan media sosial, sehingga ia tidak yakin apakah informasi tersebut benar atau tidak.

Petugas kesehatan di puskesmas berupaya memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, risiko kehamilan pada usia dini, serta berbagai pilihan layanan konseling yang dapat membantu remaja memahami dan menjaga kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, petugas juga menjelaskan bahwa puskesmas menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja yang bersifat rahasia, aman, dan ramah bagi remaja.

Situasi ini menjadi kesempatan penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang tepat, melakukan konseling yang efektif, serta memastikan remaja memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan terpercaya.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama yang dihadapi oleh remaja pada kasus tersebut?
2. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan pada remaja dalam kasus ini?
3. Mengapa edukasi kesehatan reproduksi menjadi penting dalam upaya pencegahan kehamilan remaja?
4. Bagaimana peran konseling kesehatan reproduksi dalam membantu remaja membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi mereka?
5. Apa saja prinsip pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja yang harus diterapkan oleh tenaga kesehatan?
6. Layanan apa saja yang dapat disediakan oleh fasilitas kesehatan untuk mendukung pencegahan kehamilan pada remaja?

7. Bagaimana cara tenaga kesehatan membangun komunikasi yang efektif agar remaja merasa nyaman dan percaya untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan reproduksi?

Aktivitas 2 — *Shows How*

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Pencegahan Kehamilan Remaja

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan Pencegahan Kehamilan Remaja
- Eskalasi bila red flags

muncul Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	& Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen keputusan	& Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

G. Latihan Soal

No	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	(Dikosongkan)
2	Judul	Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Aman
3	Kasus	Konseling kesehatan reproduksi pada remaja untuk pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam memberikan edukasi, konseling, serta informasi mengenai akses pelayanan kesehatan reproduksi yang aman bagi remaja.
5	Kompetensi	1. Anamnesis pada remaja terkait kesehatan reproduksi 2. Identifikasi faktor risiko kehamilan remaja 3. Perumusan masalah kesehatan reproduksi remaja 4. Edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan 5. KIE/konseling yang ramah remaja 6. Pemberian informasi mengenai akses pelayanan kesehatan 7. Perilaku profesional dan komunikasi efektif dengan remaja
6	Skenario dan Tugas Peserta Ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 17 tahun datang ke Puskesmas bersama temannya untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi. Hasil anamnesis menunjukkan bahwa klien sedang berpacaran dan merasa khawatir karena beberapa teman sekolahnya mengalami kehamilan pada usia remaja. Klien mengatakan belum memahami secara baik tentang siklus menstruasi, cara mencegah kehamilan, serta risiko hubungan seksual tanpa perlindungan. Klien mengaku selama ini memperoleh informasi kesehatan reproduksi dari media sosial dan teman sebaya sehingga belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Klien juga mengatakan merasa malu untuk bertanya kepada orang tua maupun guru mengenai masalah kesehatan reproduksi. Saat

No	Komponen	Isi
		dilakukan wawancara, klien tampak cemas, sering menunduk, namun kooperatif dan berharap mendapatkan penjelasan yang jelas, aman, serta menjaga kerahasiaannya. Sebagai bidan di Puskesmas, peserta diminta memberikan asuhan komunikasi, edukasi, dan konseling kesehatan reproduksi remaja secara ramah remaja untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. TUGAS Lakukan komunikasi terapeutik dan bina hubungan saling percaya dengan klien. Lakukan anamnesis terarah terkait kesehatan reproduksi remaja. Identifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kehamilan remaja. Jelaskan masalah dan kebutuhan kesehatan reproduksi berdasarkan hasil pengkajian. Berikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan pada remaja sesuai usia klien. Lakukan konseling singkat dengan pendekatan ramah remaja, menjaga privasi dan kerahasiaan klien. Jelaskan layanan kesehatan reproduksi remaja yang tersedia di fasilitas kesehatan secara aman dan rahasia. Lakukan penutupan konseling dan tindak lanjut secara tepat.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. Tuliskan nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti ujian. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: Actual mark (0/1/2/3)

No	Komponen	Isi
		Global rating (1/2/3/4) Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi kepada peserta selain yang telah ditentukan. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE INSTRUKSI KHUSUS Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, pasien standar menjawab sesuai dialog yang tersedia. Jika peserta menanyakan tentang siklus menstruasi atau riwayat kesehatan reproduksi, penguji memberikan data tambahan sesuai skenario. Peserta diharapkan menjelaskan: Perubahan fisik pada masa remaja Risiko kehamilan pada usia remaja Cara menjaga kesehatan reproduksi Peserta diharapkan memberikan edukasi mengenai: Pentingnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Risiko hubungan seksual tanpa perlindungan Pentingnya mencari informasi kesehatan dari sumber terpercaya Peserta juga menjelaskan layanan kesehatan yang tersedia bagi remaja di fasilitas kesehatan INSTRUKSI TAMBAHAN Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. Siapkan lembar baru untuk peserta berikutnya
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS PS berperan sebagai remaja perempuan usia 17 tahun.

No	Komponen	Isi
		PS tampak sedikit cemas dan malu ketika membicarakan kesehatan reproduksi. PS bersikap kooperatif jika peserta menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan tidak menghakimi. PS tampak lebih nyaman ketika peserta menunjukkan sikap empati dan menjaga kerahasiaan
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, saya bidan yang bertugas di puskesmas ini. Apakah kamu bersedia berkonsultasi dengan saya? PS: Iya, Bu. Peserta: Apa yang membuat kamu datang ke puskesmas hari ini? PS: Saya ingin bertanya tentang kesehatan reproduksi, Bu. Soalnya beberapa teman saya ada yang hamil saat masih sekolah. Peserta: Apakah kamu sudah pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi sebelumnya? PS: Sedikit, Bu. Tapi kebanyakan dari teman atau media sosial. Peserta: Apakah kamu merasa khawatir tentang kemungkinan kehamilan pada usia remaja? PS: Iya, Bu. Saya takut kalau terjadi hal seperti itu. Peserta: Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kesehatan reproduksi dan cara menjaga diri agar tetap sehat. PS: Terima kasih, Bu

No	Komponen	Isi
10	Kebutuhan Manikin	Tidak diperlukan manikin khusus karena stasiun ini berfokus pada komunikasi, edukasi, dan konseling kesehatan reproduksi remaja
11	Kebutuhan Laboran	Peran laboran: Menyiapkan ruangan simulasi konseling Menyiapkan lembar instruksi peserta dan penguji Memastikan stasiun siap digunakan oleh peserta berikutnya
12	Kebutuhan Alat	Meja dan kursi konseling Lembar kasus OSCE Lembar penilaian peserta Media edukasi kesehatan reproduksi (poster/leaflet) Alat tulis
13	Penulis	
14	Referensi	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar bidan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan. World Health Organization. (2018). Adolescent sexual and reproductive health guidelines. United Nations Population Fund. (2020). Adolescent pregnancy and reproductive health programs

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Pencegahan Kehamilan Remaja

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Keluhan utama		
Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi (pemahaman tentang pubertas, kehamilan, dan pencegahannya)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Riwayat perilaku berisiko (aktivitas seksual, penggunaan kontrasepsi, atau paparan risiko lain)		
Riwayat menstruasi (usia menarche, siklus haid, keluhan yang menyertai)		
Riwayat hubungan atau tekanan dari pasangan/teman sebaya (termasuk adanya paksaan atau pengaruh lingkungan)		
Riwayat kesehatan umum (penyakit, penggunaan obat, alergi, kondisi khusus)		
Riwayat psikososial (dukungan keluarga, kondisi emosional, lingkungan sosial)		
Akses terhadap informasi dan layanan Kesehatan (apakah pernah mendapatkan edukasi atau mengakses layanan sebelumnya)		

Skoring KOMPETENSI 1

3 = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.

2 = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.

1 = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.

0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan, ramah, dan tidak menghakimi		
b. Memperkenalkan diri serta menjelaskan peran sebagai tenaga kesehatan		
c. Menjelaskan tujuan edukasi dan konseling yang akan dilakukan		
d. Memastikan klien memahami prosedur serta meminta persetujuan (informed consent)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
e. Menjamin dan menjelaskan prinsip kerahasiaan (confidentiality)		
f. Menjaga privasi dan kenyamanan klien selama proses berlangsung		
g. Melakukan kebersihan tangan (hand hygiene)		
h. Menyiapkan media edukasi dan alat pendukung (leaflet, formulir skrining, dll.)		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai kondisi umum dan kesiapan klien untuk menerima konseling		
b. Menggali pengetahuan awal klien tentang kesehatan reproduksi		
c. Menggali kebutuhan dan masalah yang dihadapi klien		
d. Melakukan skrining risiko kehamilan remaja		
e. Mengidentifikasi perilaku seksual berisiko		
f. Mengidentifikasi kemungkinan adanya kekerasan atau tekanan		
g. Menilai kondisi kesehatan umum yang relevan		
h. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pubertas		
i. Menjelaskan risiko kehamilan remaja		
j. Menjelaskan upaya pencegahan kehamilan (abstinensi, kontrasepsi, dll.)		
k. Menjelaskan pilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan klien		
l. Menjelaskan konsep hubungan sehat dan persetujuan (consent)		
m. Menerapkan prinsip informed choice (menjelaskan manfaat, risiko, dan alternatif)		
n. Membantu klien dalam pengambilan keputusan tanpa paksaan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
o. Menjelaskan akses layanan kesehatan yang aman dan ramah remaja		
p. Mengidentifikasi kebutuhan rujukan atau kolaborasi (jika diperlukan)		
q. Melakukan evaluasi pemahaman klien selama proses konseling		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil konseling dan rencana tindak lanjut		
b. Memberikan penguatan (reinforcement positif) kepada klien		
c. Menyusun rencana kunjungan ulang atau tindak lanjut		
d. Mencatat hasil pengkajian, edukasi, dan konseling dalam catatan medis		
e. Melakukan kebersihan tangan kembali		
f. Merapikan alat dan lingkungan		

Skoring KOMPETENSI 2

3 = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.

2 = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.

1 = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.

0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pengkajian dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan Edukasi dan Tindakan yang Diberikan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
4. Menjelaskan Perlunya Rujukan atau Kolaborasi (Jika Diperlukan)		
5. Memberikan Dukungan Emosional		
6. Memberi Kesempatan Bertanya dan Menjawab dengan Jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

3 = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.

2 = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.

1 = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.

0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan Perhatian terhadap Respons Klien		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

3 = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.

2 = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.

1 = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.

0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1+2+3+4/3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30
(Kota),.....

.....
Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan yang Aman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Kehamilan Remaja
Metode penilaian	DOPS digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan edukasi, konseling, skrining risiko, serta memfasilitasi akses pelayanan kesehatan yang aman dan ramah remaja. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme dan privasi.	Penilaian dilakukan oleh pembimbing dengan mengamati secara langsung interaksi mahasiswa dengan klien remaja, kemudian memberikan umpan balik segera setelah kegiatan selesai. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan komunikasi, penerapan prinsip kerahasiaan (confidentiality), pemberian informed choice, keterampilan konseling, profesionalisme, serta keselamatan psikososial klien.
Tujuan penilaian	Tujuan penerapan DOPS pada topik ini adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif yang komprehensif kepada remaja, khususnya dalam	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari aspek pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga dari keterampilan praktis dalam menggali informasi, memberikan edukasi yang sesuai, melakukan konseling yang efektif, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Kehamilan Remaja
	mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.	membantu klien dalam pengambilan keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan remaja yang menekankan aspek ramah remaja, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada hak klien.
Kasus klinik	Kasus dalam konteks pencegahan kehamilan remaja dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang relevan dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya dalam kemampuan melakukan edukasi, konseling, skrining risiko, serta pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi remaja. Fokus utama dalam kasus ini adalah kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi faktor risiko kehamilan remaja, memahami kebutuhan klien, serta memberikan intervensi promotif dan preventif melalui pendekatan yang ramah remaja, menjaga kerahasiaan, dan menerapkan prinsip informed choice.	Seorang remaja perempuan usia 17 tahun datang ke puskesmas untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi. Klien mengaku telah memiliki hubungan dekat dengan pacarnya dan merasa khawatir akan kemungkinan terjadinya kehamilan, namun belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara pencegahannya. Klien tampak ragu dan malu saat menyampaikan keluhannya, serta menyatakan bahwa ia tidak ingin orang tuanya mengetahui kunjungannya. Dari hasil pengkajian awal, diketahui bahwa klien belum pernah mendapatkan edukasi formal tentang kesehatan reproduksi dan belum pernah mengakses layanan konseling sebelumnya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Kehamilan Remaja
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Aktivitas mahasiswa yang diamati dalam DOPS mencakup seluruh rangkaian proses pelayanan, mulai dari membangun hubungan terapeutik, menggali informasi dan kebutuhan klien, melakukan skrining risiko kehamilan dan perilaku berisiko, hingga memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan, serta pilihan kontrasepsi.	Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan prinsip informed choice dengan menjelaskan manfaat, risiko, dan alternatif pilihan secara jelas, serta membantu klien dalam mengambil keputusan tanpa paksaan. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan akses layanan kesehatan yang tersedia dan mengidentifikasi kebutuhan rujukan apabila diperlukan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai dalam DOPS meliputi kemampuan komunikasi interpersonal, ketepatan dalam melakukan skrining risiko, kejelasan dalam memberikan edukasi, kemampuan menerapkan prinsip informed choice, serta sikap profesional dalam menjaga kerahasiaan dan kenyamanan klien.	Penilaian juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah utama dan menentukan langkah tindak lanjut yang tepat, termasuk kebutuhan rujukan atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah pada performa nyata mahasiswa dalam memberikan layanan kepada remaja. Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman, menggunakan pendekatan non-judgmental, serta menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami.	Pembimbing memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam merespons kebutuhan emosional klien dan membantu proses pengambilan keputusan secara mandiri.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Kehamilan Remaja
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi, dengan menekankan pada kelebihan yang telah dicapai serta area yang perlu ditingkatkan. Misalnya, mahasiswa mungkin sudah baik dalam membangun hubungan terapeutik dan menyampaikan informasi	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan perlu meningkatkan keterampilan dalam menggali risiko secara lebih mendalam atau memperjelas penjelasan mengenai pilihan kontrasepsi. Umpan balik ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan..
Keputusan penilaian	Keputusan penilaian dalam DOPS dapat dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melaksanakan edukasi dan konseling secara sistematis, aman, dan sesuai prinsip pelayanan ramah remaja. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila sebagian besar langkah sudah benar namun masih memerlukan arahan. Sedangkan mahasiswa dinyatakan remedial apabila belum mampu melakukan konseling secara efektif, tidak menjaga kerahasiaan, atau tidak mampu membantu klien dalam pengambilan keputusan.
Makna dalam OBE	Dalam kerangka Outcome-Based Education (OBE), DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai	Melalui observasi langsung dan umpan balik yang konstruktif, mahasiswa tidak hanya memahami teori pencegahan kehamilan remaja, tetapi juga mampu menerapkannya secara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Kehamilan Remaja
	capaian pembelajaran pada level praktik nyata (does).	profesional dalam situasi pelayanan kesehatan yang sesungguhnya. Pendekatan ini sangat relevan dalam membentuk bidan yang kompeten, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi remaja.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan yang Aman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dalam memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja secara ramah, aman, dan berbasis kebutuhan klien..	Pada topik pencegahan kehamilan remaja, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, skrining risiko, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, melakukan konseling ramah remaja, serta membantu klien mengambil keputusan secara sadar (informed choice) dan memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan untuk mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, kemampuan refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik pelayanan kesehatan reproduksi remaja.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan konseling pada remaja, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuan komunikasi, kedalaman skrining, dan kualitas edukasi setelah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
		mendapatkan masukan dari dosen atau CI
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium serta performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat keterampilan komunikasi, edukasi kesehatan reproduksi, dan konseling pencegahan kehamilan remaja. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan skrining risiko, konseling, serta membantu klien dalam pengambilan keputusan di puskesmas atau komunitas.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus klien remaja yang pernah ditangani, meliputi data penting, masalah kesehatan reproduksi, intervensi edukasi dan konseling, serta hasil atau tindak lanjut.	Mahasiswa menuliskan kasus remaja usia 17 tahun yang datang dengan kekhawatiran risiko kehamilan, hasil skrining menunjukkan kurangnya pengetahuan reproduksi, tindakan berupa edukasi dan konseling kontrasepsi, serta rencana tindak lanjut layanan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko pada klien, menganalisis potensi kesalahan dalam pelayanan, serta menyusun langkah pencegahan untuk meningkatkan keselamatan klien.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga kerahasiaan remaja, penggunaan komunikasi non-judgmental, ketepatan dalam memberikan informasi kontrasepsi, serta pencegahan kesalahan dalam penyampaian informasi yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
		dapat menimbulkan miskonsepsi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi mahasiswa	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empatik dan membangun kepercayaan, namun perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali risiko secara lebih mendalam.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan dan tidak hanya berdasarkan satu kali penilaian, tetapi merupakan kumpulan bukti dari berbagai pengalaman belajar yang menunjukkan konsistensi performa mahasiswa	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus konseling remaja, tetapi dari berbagai pengalaman yang menunjukkan konsistensi kompetensi.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa dalam berbagai situasi praktik dan waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan komunikasi ramah remaja, skrining risiko, dan edukasi pencegahan kehamilan dengan baik.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan secara nyata, berulang, dan berkembang dalam praktik.	Pada topik ini, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga mampu secara konsisten menerapkan edukasi dan konseling pencegahan kehamilan secara profesional di lahan praktik.

Tabel. Case Report pada Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan yang Aman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi remaja.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang remaja perempuan yang datang untuk berkonsultasi mengenai risiko kehamilan dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
Tujuan	Case report bertujuan untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, perencanaan, implementasi edukasi dan konseling, serta evaluasi hasil pelayanan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data klien, tetapi juga menjelaskan masalah utama, intervensi edukasi dan konseling, serta hasil dan tindak lanjut yang dilakukan
Isi laporan	Isi laporan mencakup identitas klien (dengan menjaga kerahasiaan), keluhan utama, data subjektif dan objektif, hasil skrining risiko, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus	Mahasiswa menuliskan kasus remaja usia 17 tahun dengan kekhawatiran kehamilan, hasil skrining menunjukkan kurangnya pengetahuan, dilakukan edukasi dan konseling kontrasepsi, serta direncanakan tindak lanjut layanan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinis, ketepatan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan faktor risiko (kurangnya pengetahuan, pengaruh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
	intervensi edukasi dan konseling, serta kemampuan evaluasi hasil pelayanan.	lingkungan) dengan potensi kehamilan dan memberikan intervensi tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir klinis (clinical reasoning), keterampilan dokumentasi, serta refleksi terhadap praktik pelayanan kesehatan reproduksi remaja.	Mahasiswa belajar pentingnya komunikasi empatik, menjaga kerahasiaan, serta memberikan edukasi yang tepat untuk mencegah kehamilan remaja.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam praktik nyata secara sistematis dan bertanggung jawab	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pencegahan kehamilan remaja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelayanan edukasi dan konseling secara langsung.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan yang Aman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi client safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko pada klien remaja, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan tindakan pencegahan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.	Mahasiswa merefleksikan bahwa kurangnya edukasi dan komunikasi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kehamilan remaja yang tidak direncanakan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
Tujuan	Refleksi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan klien (fisik dan psikososial) merupakan bagian penting dalam setiap pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti tidak menjaga kerahasiaan, komunikasi yang menghakimi, atau informasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada keputusan yang salah dan meningkatkan risiko kehamilan
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh dari praktik pelayanan.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah kurangnya pengetahuan, pengaruh teman sebaya, akses layanan yang terbatas, serta komunikasi yang tidak efektif antara remaja dan tenaga kesehatan..
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan klien dalam konteks kesehatan reproduksi remaja.	Risiko yang diidentifikasi meliputi kehamilan tidak direncanakan, perilaku seksual berisiko, kurangnya penggunaan kontrasepsi, serta ketakutan mengakses layanan kesehatan karena stigma.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan klien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, konseling ramah remaja, menjaga kerahasiaan, penggunaan pendekatan non-judgmental, serta meningkatkan akses layanan kesehatan yang aman..

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pencegahan Kehamilan Remaja
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa komunikasi empatik, pemberian informasi yang jelas, serta penghormatan terhadap keputusan klien sangat penting dalam mencegah kehamilan remaja
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan klien	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya memberikan edukasi dan konseling, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja secara berkelanjutan.

H. Ringkasan

Pencegahan kehamilan remaja merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesehatan reproduksi serta kualitas hidup remaja. Remaja berada pada fase transisi dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat, sehingga rentan terhadap perilaku berisiko. Kehamilan pada usia remaja (di bawah 20 tahun) berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan seperti anemia, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, hingga peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, dampak sosial seperti putus sekolah, keterbatasan kesempatan kerja, dan tekanan psikologis juga sering terjadi. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi, minimnya komunikasi dengan orang tua, pengaruh teman sebaya, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Upaya pencegahan kehamilan remaja harus dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, konseling, dan penyediaan akses pelayanan kesehatan yang aman. Edukasi kesehatan reproduksi berperan dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai pubertas, fungsi organ reproduksi, hubungan yang sehat, serta pencegahan kehamilan dan penyakit menular seksual. Edukasi yang efektif tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga membangun keterampilan pengambilan keputusan dan sikap yang bertanggung jawab. Konseling kesehatan reproduksi menjadi komponen penting untuk membantu remaja memahami risiko, mengekspresikan permasalahan, serta mengambil keputusan secara sadar (*informed choice*). Pendekatan konseling harus bersifat ramah remaja, menjaga kerahasiaan, tidak menghakimi, serta menggunakan komunikasi empatik dan bahasa yang mudah dipahami.

Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan ramah remaja merupakan faktor kunci dalam pencegahan kehamilan remaja. Pelayanan harus mudah dijangkau, menjaga privasi dan kerahasiaan, didukung tenaga kesehatan yang terlatih, serta menyediakan informasi yang akurat. Program seperti Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) menjadi salah satu bentuk layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan remaja. Selain itu, pemanfaatan media digital dan layanan berbasis sekolah/komunitas juga berperan dalam memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Peran bidan sangat strategis sebagai edukator, konselor, dan fasilitator layanan dalam pencegahan kehamilan remaja. Bidan harus mampu melakukan pengkajian, skrining risiko, memberikan edukasi, melakukan konseling, serta mengarahkan remaja pada layanan yang sesuai. Prinsip etik seperti autonomi, beneficence, non-

maleficence, dan justice harus diterapkan, disertai dengan penghormatan terhadap kerahasiaan dan hak remaja. Selain itu, dokumentasi, pencatatan, monitoring, dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelayanan dan keberlanjutan program

Alur Asuhan Singkat

Remaja dengan risiko kehamilan → lakukan pengkajian dan skrining risiko → identifikasi faktor penyebab (pengetahuan, perilaku, lingkungan, akses layanan) → berikan edukasi kesehatan reproduksi → lakukan konseling ramah remaja → bantu pengambilan keputusan (informed choice) → arahkan ke layanan kesehatan yang aman dan ramah remaja → lakukan dokumentasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Tabel Red Flags & Eskalasi**Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan yang Aman**

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Remaja memiliki pengetahuan rendah tentang kesehatan reproduksi	Remaja memiliki pengetahuan rendah tentang kesehatan reproduksi	Remaja memiliki pengetahuan rendah tentang kesehatan reproduksi
Tidak adanya komunikasi terbuka dengan orang tua atau pendamping	Tidak adanya komunikasi terbuka dengan orang tua atau pendamping	Tidak adanya komunikasi terbuka dengan orang tua atau pendamping
Remaja mulai menunjukkan perilaku seksual berisiko	Remaja mulai menunjukkan perilaku seksual berisiko	Remaja mulai menunjukkan perilaku seksual berisiko
Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi terbatas	Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi terbatas	Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi terbatas
Penggunaan kontrasepsi rendah atau tidak konsisten	Penggunaan kontrasepsi rendah atau tidak konsisten	Penggunaan kontrasepsi rendah atau tidak konsisten
Tekanan dari pasangan atau lingkungan sosial	Tekanan dari pasangan atau lingkungan sosial	Tekanan dari pasangan atau lingkungan sosial
urangnya kegiatan positif atau pemberdayaan remaja	urangnya kegiatan positif atau pemberdayaan remaja	urangnya kegiatan positif atau pemberdayaan remaja
Adanya stigma terhadap akses layanan kesehatan reproduksi	Adanya stigma terhadap akses layanan kesehatan reproduksi	Adanya stigma terhadap akses layanan kesehatan reproduksi
Tanda-tanda kehamilan remaja yang tidak ditangani sejak dini	Tanda-tanda kehamilan remaja yang tidak ditangani sejak dini	Tanda-tanda kehamilan remaja yang tidak ditangani sejak dini

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tidak adanya sistem rujukan atau pendampingan yang jelas	Tidak adanya sistem rujukan atau pendampingan yang jelas	Tidak adanya sistem rujukan atau pendampingan yang jelas

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Pencegahan Kehamilan Remaja melalui Edukasi, Konseling, dan Akses Pelayanan Kesehatan yang Aman

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian kehamilan remaja dan risikonya	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah terkait perilaku berisiko pada remaja	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai faktor risiko kehamilan remaja dari data yang tersedia	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda-tanda remaja dengan risiko tinggi mengalami kehamilan tidak direncanakan	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor penyebab kehamilan remaja (lingkungan, pengetahuan, akses layanan)	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya bagi kesehatan ibu remaja	☐	☐	
8	Saya sudah bisa mengenali dampak kehamilan remaja terhadap janin	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi awal tentang pencegahan kehamilan remaja	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memberikan konseling yang tepat dan ramah remaja	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan dan pendampingan remaja secara sistematis	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan informasi kesehatan reproduksi kepada remaja dan keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan remaja perlu dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih lengkap	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mengarahkan akses ke pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan ramah remaja	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil edukasi dan konseling secara tepat	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, kerahasiaan, dan sikap profesional dalam pelayanan remaja	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

- Bearinger, L. H., Sieving, R. E., Ferguson, J., & Sharma, V. (2017). Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents. *The Lancet*, 369(9568), 1220–1231.
- Chandra-Mouli, V., Svanemyr, J., Amin, A., Fogstad, H., Say, L., Girard, F., & Temmerman, M. (2025). Twenty years after ICPD: Where are we with adolescent sexual and reproductive health and rights? *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S1–S6.
- Denno, D. M., Hoopes, A. J., & Chandra-Mouli, V. (2017). Effective strategies to provide adolescent sexual and reproductive health services. *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S22–S41.
- Hall, K. S., Moreau, C., & Trussell, J. (2019). Determinants of and disparities in reproductive health service use among adolescent women. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 44(3), 141–149.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Ott, M. A., & Santelli, J. S. (2017). Abstinence and abstinence-only education. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 19(5), 446–452.
- Patton, G. C., et al. (2016). Our future: A Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *The Lancet*, 387(10036), 2423–2478.
- Santrock, J. W. (2016). *Adolescence* (16th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Secura, G. M. (2019). Long-acting reversible contraception: A practical solution to reduce unintended pregnancy. *Minerva Ginecologica*, 65(3), 271–277.
- Senderowitz, J. (2020). A review of program approaches to adolescent reproductive health. *Journal of Adolescent Health*, 26(5), 377–383.
- Tylee, A., Haller, D. M., Graham, T., Churchill, R., & Sanci, L. A. (2007). Youth-friendly primary-care services. *The Lancet*, 369(9572), 1565–1573.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. (2018). *International technical guidance on sexuality education*. Paris: UNESCO.

United Nations Population Fund. (2020). Adolescent pregnancy: A review of the evidence. New York: UNFPA.

World Health Organization. (2018). Adolescent sexual and reproductive health. Geneva: WHO.

PROFIL PENULIS



Dr. An Nisa Fithri, S.KM., M.KM., penulis lahir di Bandung pada 7 Agustus 1976 dan menetap di Malang, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tahun 2008, lulus S2 Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Kesehatan Reproduksi, Universitas Padjadjaran pada tahun 2015, lulus S3 Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran konsentrasi biologi reproduksi. Penulis adalah dosen Prodi S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes dan mengampu mata kuliah Herbal dan Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Menopause. Penulis aktif melakukan riset di bidang herbal untuk kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis telah mempublikasikan

beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi.

Email: teh.nisa1@gmail.com

Instansi mengajar : Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes



Sefria Indah Primasari, S.ST., M.Kes. Lahir di Metro, 22 September 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu DIII Kebidanan dan DIV Pendidik di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Mitra Lampung dan lulus tahun 2014 Mengampu mata kuliah Anatomi, Kesehatan Masyarakat, Penyakit dan Kelainan Pada Kesehatan Reproduksi, Metode Penelitian, dan lain-lain. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selama ini terlibat aktif sebagai dosen pembimbing mahasiswa dan terlibat dalam publikasi, penelitian dan pengabdian masyarakat. Telah menulis beberapa buku

ajar dan penelitian yang sudah dipatenkan dan terdaftar di HaKI yaitu Buku Kesehatan Reproduksi dalam Keluarga dan Masyarakat, Buku Ajar Dokumentasi dan Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sefriaindahprimasari76@gmail.com

Motto: Choose happiness every day

PROFIL PENULIS



Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes. Penulis lahir di Tulungagung pada tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKES Karya Husada Kediri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Griya Husada Surabaya, D4 Bidan Pendidik dan Pendidikan Profesi Bidan di STIKES Karya Husada Kediri dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak serta kesehatan reproduksi remaja.

Penulis aktif dalam kegiatan menulis artikel di majalah kebidanan maupun karya ilmiah semenjak masih di bangku perkuliahan. Selain aktif sebagai pengajar, saat ini penulis juga aktif dalam organisasi IBI, sebagai penulis buku, reviewer dan editor pada beberapa jurnal ilmiah. Penulis juga aktif menghasilkan karya-karya penelitian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pembicara / narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Scopus ID 58947027700; Sinta ID 6121817; Orcid ID 0009-0000-2816-9033; Garuda ID 1055674; email: brivianflorentis@gmail.com.



Bdn. Rini Deska, S.ST. M.KM.CTM-MT Lahir di Tanjung Karang, 16 Desember 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan di Universitas Padjajaran tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 sebagai bidan desa sangat terpencil di kabupaten Tanggamus Lampung dan pada tahun 2005 bergabung di Akbid Panca Bhakti yang sekarang menjadi Prodi D3 Kebidanan STIKes Panca Bhakti sampai dengan

sekarang 2026. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu penulis diantaranya Asuhan Kehamilan, Asuhan kebidanan komunitas, Asuhan Pasca Persalinan dan Menyusui, dan Entrepreneurship Kebidanan serta PBAK. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinideska12@gmail.com

PROFIL PENULIS



Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes. merupakan dosen tetap di Universitas Kader Bangsa Palembang dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Beliau adalah seorang bidan profesional dengan kompetensi dan pengalaman akademik di bidang kesehatan reproduksi, khususnya pada kelompok remaja. Lahir di Kalianda pada tanggal 9 April 1991, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan (M.Kes.) pada tahun 2016 dan menuntaskan Program Profesi Bidan pada tahun 2024. Latar belakang pendidikan tersebut memperkuat kapasitas akademik dan praktik profesionalnya dalam pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi yang berbasis promotif dan preventif. Fokus kegiatan tridarma perguruan tinggi yang ditekuni meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan konsentrasi utama pada kesehatan reproduksi remaja, terutama strategi pencegahan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesiapan kesehatan generasi muda. Berbagai kajian dan kegiatan pengabdian yang dilakukan diarahkan pada penguatan literasi kesehatan reproduksi serta pencegahan perilaku berisiko pada remaja. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik pada alamat putu.indriani91@gmail.com.



Dr. Idawati, S.ST., M.K.M., C.Ed. Penulis lahir di Janarata, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 April 1986 merupakan putri ke enam dari ayahanda Abu Bakar Yakin dan ibu Nurhayati serta bersuamikan T. Safrizal, SH, memiliki dua orang putra dan satu putri yaitu T. Ramadhan Fuanna dan T. Fathan Aulia Putra serta Cut Fiola Humaira. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Kebidanan Prodi S1 Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Penulis Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di Akademi Kesehatan Bukit Rata Lhokseumawe pada tahun 2008, lulus pendidikan D-IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2010, lulus pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Institut Helvetia Medan pada tahun 2018 dan lulus pendidikan Doktor (S3) pada Program Study Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2025. Penulis sudah menulis 19 buku dengan judul Konsep Dasar Kebidanan, Persalinan Berbasis *Sectio Caesarea*, Mutu Pelayanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan, Konsep Dasar Manajemen Kesehatan, Kegagalan Pemberian ASI Eksklusif, Pengantar Profesionalisme Kebidanan, Asuhan Kebidanan Komplementer dan *Evidence Based* Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Komplementer dan *Evidence Based* Pada Persalinan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Masalah Kesehatan Reproduksi Pada Remaja, Asuhan Kebidanan Komunitas, Stunting dan Permasalahan disekitarnya, Metodologi Penelitian dan Penulisan Skripsi Kesehatan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengantar Sistem Informasi dan Teknologi Dalam Pelayanan Kebidanan, Kebidanan Komunitas di Era Society 5.0, Dokumentasi dan Pelaporan Asuhan Pascapersalinan dan Asuhan Kebidanan Pascapersalinan. Penulis dapat dihubungi melalui email: idawatiwati45@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan 1 membahas dasar pelayanan kesehatan reproduksi sejak masa remaja hingga sebelum kehamilan. Materi mencakup pubertas, kebersihan organ reproduksi, menstruasi, anemia, status gizi, kesehatan mental, perilaku berisiko, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, serta kehamilan yang tidak direncanakan.

Buku ini juga menguraikan persiapan prakonsepsi melalui pengkajian status kesehatan, gizi, penyakit kronis, gaya hidup, kesehatan mental, imunisasi, dan riwayat reproduksi. Disusun secara sistematis, buku ini diharapkan membantu mahasiswa kebidanan meningkatkan kemampuan pengkajian, edukasi, konseling, deteksi dini, dan rujukan dalam memberikan pelayanan yang aman, berbasis bukti, menghormati hak klien, serta berpusat pada kebutuhan remaja dan calon orang tua.

Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan 1 membahas dasar pelayanan kesehatan reproduksi sejak masa remaja hingga sebelum kehamilan. Materi mencakup pubertas, kebersihan organ reproduksi, menstruasi, anemia, status gizi, kesehatan mental, perilaku berisiko, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, serta kehamilan yang tidak direncanakan.

Buku ini juga menguraikan persiapan prakonsepsi melalui pengkajian status kesehatan, gizi, penyakit kronis, gaya hidup, kesehatan mental, imunisasi, dan riwayat reproduksi. Disusun secara sistematis, buku ini diharapkan membantu mahasiswa kebidanan meningkatkan kemampuan pengkajian, edukasi, konseling, deteksi dini, dan rujukan dalam memberikan pelayanan yang aman, berbasis bukti, menghormati hak klien, serta berpusat pada kebutuhan remaja dan calon orang tua.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-93-0 (PDF)



9

786347

756930

